

MỤC LỤC

1. Cách đề cập dịch tễ học và Chiến lược thiết kế Nghiên cứu dịch tễ học	1
2. Số đo mắc bệnh và tử vong.....	5
3. Đo lường sự kết hợp.....	14
4. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả	20
5. Sàng tuyển phát hiện bệnh sớm	25
6. Chẩn đoán cộng đồng.....	31
7. Các kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin.....	36
8. Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng.....	43
9. Phương pháp nghiên cứu thuần tập.....	52
10. Phương pháp nghiên cứu can thiệp.....	59
11. Các sai số trong nghiên cứu dịch tễ học, xác định mối quan hệ nhân quả	67
12. Giám sát dịch tễ học.....	76
13. Nguyên lý dịch tễ học các bệnh nhiễm trùng.....	83
14. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp.....	93
15. DTH nhóm bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá	99
16. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu.....	105
17. DTH bệnh truyền nhiễm đường da và niêm mạc.....	111
18. Tiêm chủng phòng bệnh.....	129

Cách đề cập dịch tễ học và Chiến lược thiết kế Nghiên cứu dịch tễ học

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất

1. Dịch tễ học được định nghĩa là:

- a. phương pháp nghiên cứu quan sát ứng dụng trong các nghiên cứu y học
- b. khoa học nghiên cứu tần số mắc và chết đối với các bệnh trạng cùng với các yếu tố qui định sự phân bố của bệnh trạng.
- c. phương pháp nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố căn nguyên
- d. môn khoa học áp dụng cho các nghiên cứu bệnh truyền nhiễm

2. Các phương pháp nghiên cứu dịch tễ học được áp dụng trong các trường hợp:

- a. chỉ áp dụng cho nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm
- b. nghiên cứu từng trường hợp bệnh và kết quả của nghiên cứu có thể đưa ra liệu trình điều trị thích hợp
- c. nghiên cứu về một bệnh hoặc hiện tượng sức khỏe trong cộng đồng.
- d. áp dụng cho nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm và nghiên cứu từng trường hợp bệnh và kết quả của nghiên cứu có thể đưa ra liệu trình điều trị thích hợp

3. Nghiên cứu dịch tễ học nhằm mục tiêu:

- a. Xác định sự phân bố hiện tượng sức khỏe bệnh trạng nhằm định hướng cho các chương trình và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
- b. Làm bộc lộ các nguy cơ và các yếu tố căn nguyên của hiện tượng sức khỏe, bệnh trạng nhằm phục vụ cho kế hoạch kiểm soát ngăn ngừa và thanh toán bệnh
- c. Cung cấp phương pháp đánh giá các giải pháp can thiệp sức khỏe
- d. cả 3 ý trên đều đúng.

4. Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học là:

- a. nghiên cứu quan sát
- b. nghiên cứu can thiệp
- c. nghiên cứu dịch tễ học gồm có thiết kế nghiên cứu quan sát và nghiên cứu can thiệp chỉ áp dụng trong dự phòng
- d. nghiên cứu dịch tễ học bao gồm cả nghiên cứu quan sát và nghiên cứu thực nghiệm.

5. Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học mô tả là:

- a. nghiên cứu quan sát

- b. nghiên cứu cho phép phân tích và xác định kết hợp giữa hiện tượng sức khoẻ-bệnh trạng và yếu tố nguy cơ
 - c. nghiên cứu quan sát cho phép thiết lập giả thiết có sự kết hợp giữa hiện tượng sức khoẻ-bệnh trạng và yếu tố nguy cơ .
 - d. cả ý a và c đều đúng
6. Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học quan sát bao gồm:
- a. thiết kế nghiên cứu dịch tễ học mô tả và dịch tễ học phân tích.
 - b. chỉ có các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học phân tích
 - c. chỉ có các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học mô tả
 - d. thiết kế nghiên cứu dịch tễ học mô tả, phân tích các kết quả thu nhận được để thiết lập giả thiết về bệnh trạng và các yếu tố nguy cơ
7. Nghiên cứu dịch tễ học can thiệp là:
- a. nghiên cứu trong đó các yếu tố nguy cơ đối với bệnh được chỉ định và giám sát bởi người nghiên cứu.
 - b. nghiên cứu phân tích cho phép đưa ra kết luận có sự kết hợp giữa yếu tố nguy cơ và bệnh
 - c. nghiên cứu kết luận về sự kết hợp giữa yếu tố nguy cơ và bệnh
 - d. cả hai ý a và c đều đúng
8. Thiết kế nghiên cứu dịch tễ học mô tả cắt ngang được lựa chọn khi:
- a. xác định tỷ lệ mắc một bệnh vào thời điểm nghiên cứu tại một cộng đồng
 - b. mô tả tỷ lệ theo các đặc điểm liên quan tới tuổi, giới, ..của các trường hợp mắc một bệnh tại một thời điểm
 - c. cần xác định tỷ lệ mắc một bệnh tại cộng đồng nhằm phục vụ cho việc lập kế hoạch chăm sóc và dịch vụ y tế.
 - d. nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định sự kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh trạng
9. Nghiên cứu ngang cho phép tính toán được:
- a. tỷ lệ mới mắc
 - b. tỷ lệ hiện mắc điểm.
 - c. tỷ lệ mật độ mới mắc
 - d. tốc độ mới mắc
10. Nghiên cứu thuần tập tương lai được áp dụng khi:
- a. xác định có sự kết hợp giữa yếu tố phơi nhiễm và bệnh trạng
 - b. cần xác định tỷ lệ hiện mắc kỳ
 - c. cần xác định tỷ lệ hiện mắc điểm

- d. áp dụng cho các nghiên cứu có phơi nhiễm hiếm gặp và xác định sự kết hợp giữa yếu tố phơi nhiễm và bệnh trạng.

11. Nghiên cứu bệnh-chứng được áp dụng khi :

- khi nghiên cứu xác định sự kết hợp yếu tố phơi nhiễm và bệnh hiếm gặp.
- khi nghiên cứu cần xác định tỷ lệ hiện mắc một bệnh hiếm gặp trong cộng đồng
- khi nghiên cứu cần xác định tỷ lệ mới mắc tích lũy của một bệnh hiếm trong cộng đồng
- khi kết quả nghiên cứu nhằm suy ra tần số phơi nhiễm hiếm của một yếu tố nguy cơ trong cộng đồng

12. Nghiên cứu can thiệp có thể áp dụng khi:

- khi nghiên cứu nhằm can thiệp phòng ngừa bệnh xuất hiện trong cộng đồng.
- khi nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ nhân quả giữa yếu tố phơi nhiễm và bệnh trạng
- khi nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ mới mắc của nhóm phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ
- khi nghiên cứu về một bệnh hiếm gặp có thể can thiệp được

Chọn câu trả lời đúng/sai phù hợp với mỗi câu sau:

STT	Câu hỏi	Đ	S
1.	Các phương pháp nghiên cứu dịch tễ học chỉ áp dụng cho các bệnh truyền nhiễm		
2.	nghiên cứu can thiệp là một thiết kế nghiên cứu dịch tễ học nhằm chứng minh sự kết hợp giữa yếu tố nguy cơ và bệnh trạng		
3.	Nghiên cứu tương quan là nghiên cứu quan sát mô tả		
4.	Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu, đối tượng chọn vào nghiên cứu trong nghiên cứu thuần tập lồng ghép với nghiên cứu bệnh chứng có phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ		

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

- Dịch tễ học là khoa học nghiên cứu (a).....đối với các bệnh trạng cùng với những yếu tố (b)

2. Dựa trên tính chất của quan sát, nghiên cứu dịch tễ học quan sát bao gồm nghiên cứu (a)..... và nghiên cứu (b).....
3. Nghiên cứu phân tích thường đi sau nghiên cứu mô tả để giả thuyết mà nghiên cứu mô tả đã hình thành.
4. Nghiên cứu thuần tập thường áp dụng cho các nghiên cứu về.....

Số đo mắc bệnh và tử vong

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất

1. Ví dụ đúng về tỷ lệ hiện mắc như sau:
 - a. tất cả số hiện đang bị bệnh trong quần thể không phân biệt mới mắc hay đã mắc từ lâu rồi
 - b. Số mắc bệnh ung thư phổi trên 100.000 dân của một thành phố tại một thời điểm.
 - c. tổng số những người hiện đang bị mắc bệnh tăng huyết áp trong năm 1997.
 - d. tổng số mới bị mắc tăng huyết áp của thành phố năm 1997 chia cho dân số trung bình của thành phố trong năm 1997
2. Tỷ lệ mới mắc có thể thu được trong các nghiên cứu nào sau đây?
 - a. các nghiên cứu cắt ngang
 - b. các nghiên cứu thuần tập (cohort study).
 - c. các nghiên cứu bệnh chứng
 - d. các nghiên cứu chùm bệnh
3. Tại một vụ dịch tả ở 1 địa phương năm 2007, để góp phần vào việc nhận định tình hình dịch người ta thu thập được các tỷ lệ mắc bệnh như sau: tuần 1: 5/100.000; tuần 2: 7/100.000; tuần 3: 12/100.000; tuần 4: 9/100.000; tuần 5: 6/100.000; tuần 6: 2/100.000; tuần 7: 0. Đây là ví dụ về :
 - a. tỷ lệ hiện mắc kỳ
 - b. tỷ lệ tấn công
 - c. tốc độ mới mắc.
 - d. mật độ mới mắc
4. Một ví dụ về tỷ lệ mới mắc là như sau :
 - a. tổng số mới mắc tích lũy của những bệnh nhân lao ở một quần thể trong 1 năm
 - b. tổng số các trường hợp mắc bệnh trong một vụ dịch nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn tại một nhà máy chia cho tổng số người có dự bữa ăn đó tại nhà máy.
 - c. tổng số trường hợp mới mắc tính từ ngày 1/1/1995 đến 30/12/1995 tại một huyện chia cho dân số huyện đó vào thời điểm 30/12/1995
 - d. tổng số trường hợp bị ung thư tuyến tiền liệt tại thời điểm tháng 7 năm 1997 tại một thành phố trên tổng số nam giới tại thời điểm đó

Một nhà nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu về mối liên hệ giữa việc dùng viên tránh thai O.C và ung thư vú. ông ta đã theo dõi được 1000 phụ nữ đã từng dùng viên thuốc tránh

thai từ 1 tháng trở lên và theo họ trong vòng 30 năm. Số phát triển ung thư là 25 người. Đồng thời ông ta cũng theo dõi 1000 phụ nữ không uống thuốc tránh thai O.C và cũng theo dõi họ trong 30 năm. Thấy có 5 trường hợp bị ung thư vú. Ví dụ này dùng cho các câu hỏi 5, 6, 7

5. Đây là một ví dụ về :
 - a. nghiên cứu bệnh chứng
 - b. nghiên cứu thuần tập.
 - c. nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
 - d. nghiên cứu quan sát mô tả
6. Từ số liệu trên có thể tính được :
 - a. tỷ lệ mới mắc tích lũy.
 - b. tỷ lệ hiện mắc điểm
 - c. tỷ lệ hiện mắc kỳ
 - d. tỷ lệ tấn công
7. Từ số liệu trên có thể tính được :
 - a. nguy cơ tương đối $RR = (25/1000)/(5/1000)$.
 - b. tỷ suất chênh $OR = (25 \times 995 / 5 \times 975)$
 - c. nguy cơ qui thuộc $AR\% = \{(25/1000) - (5/1000)\} \times 100$
 - d. nguy cơ qui thuộc $AR = 1$
8. Ví dụ về tỷ lệ hiện mắc là như sau :
 - a. tỷ lệ mắc bướu cổ ở nhân dân huyện đảo Cát bà là 25%
 - b. tỷ suất giữa số giường bệnh của các bệnh viện trên số dân của thành phố Hải phòng năm 1998 là 1/500
 - c. tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi của Hàiphòng bị suy dinh dưỡng năm 1987 là 45%.
 - d. tổng số trường hợp trẻ sơ sinh tại 1 quận mang HbsAg tại thời điểm tháng 9/1996 chia cho dân số quận đó vào thời điểm 9/1996
9. Tỷ lệ hiện mắc có thể thu được trong các nghiên cứu nào sau đây ?
 - a. nghiên cứu bệnh chứng
 - b. nghiên cứu ngang.
 - c. nghiên cứu thuần tập
 - d. nghiên cứu chùm bệnh
10. Tại một nhà dưỡng lão đã xảy ra một vụ dịch nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn do salmonella gây ra, người ta đã tính được tỷ lệ giữa số người bị bệnh trên số người dự bữa ăn của vụ dịch. Đây là ví dụ về :

- a. tỷ lệ hiện mắc điểm
 - b. tỷ lệ mới mắc tích lũy
 - c. tỷ lệ tấn công.
 - d. tốc độ mới mắc
11. Về lý thuyết, mẫu số của tỷ lệ mới mắc tích lũy bao gồm :
- a. số cá thể của quần thể có khả năng bị mắc bệnh trong quần thể tại một thời điểm trong quần thể
 - b. tổng số cá thể của quần thể có khả năng mắc bệnh trong quần thể tại thời điểm giữa của nghiên cứu
 - c. toàn bộ cá thể trong quần thể tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu.
 - d. tổng số thời gian theo dõi được của các cá thể mắc bệnh quan tâm
12. Ví dụ về tỷ lệ hiện mắc như sau :
- a. số lượng giường bệnh trên 1000 dân của một thành phố trong một năm
 - b. tỷ lệ giữa số lượng bệnh nhân tử vong trên số bệnh nhân mắc bệnh tại một vụ dịch
 - c. tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị tiêu chảy tại một thành phố tại thời điểm tháng 6 năm 1998 là 10%.
 - d. tỷ lệ học sinh mới bị mắc bướu cổ năm 1997 trên tổng số học sinh tại thời điểm giữa năm 1997 của một thành phố
13. Trong một vụ dịch hạch tại một thành phố người ta tính được tỷ lệ mắc bệnh theo tuần như sau : tuần 1 : 10/100.000 ; tuần 2 : 15/100.000 ; tuần 3 : 18/100.000 ; tuần 4 : 17/100.000 ; tuần 5 : 16/100.000 ; tuần 6 : 8/100.000 ; tuần 7 : 3/100.000 ; tuần 8 : 0. Đây là ví dụ về :
- a. tỷ lệ hiện mắc kỳ
 - b. tỷ lệ mới mắc tích lũy
 - c. tốc độ mới mắc.
 - d. tỷ lệ mật độ mới mắc
14. Có 3 đợt bệnh phân bố theo giới như sau :

Đợt bệnh	bệnh nhân nam	bệnh nhân nữ
1	200	100
2	250	50
3	450	150
tổng	900	300

Tỷ lệ mới mắc theo giới là:

- ở nam gấp đôi nữ
- ở nam gấp 3 so với nữ
- ở nam gấp 2 đến 5 lần so với nữ
- không thể tính được từ số liệu trên.

15. Trong một nghiên cứu sàng lọc trên 1329 nam giới có tuổi từ 40-59 tuổi, người ta tiến hành khám kiểm tra mức độ cholesterol huyết thanh và huyết áp tâm trương cho những đối tượng này. Sau đó tiến hành theo dõi những đối tượng trên trong vòng 6 năm nhằm phát hiện những trường hợp nhồi máu cơ tim. Biết rằng tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu tất cả các đối tượng đều không bị bệnh này. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng: mức huyết áp tâm trương

Mức cholesterol huyết thanh (mg/100ml)	<147		147-166		>167	
	Tổng số	Trường hợp bệnh	Tổng số	Trường hợp bệnh	Tổng số	Trường hợp bệnh
<220	431	10	93	3	49	7
220-259	347	19	74	6	49	6
>260	185	19	57	11	44	11

Dựa vào bảng số liệu trên người ta có thể tính được ví dụ nhóm có huyết áp tâm trương dưới 147mmHg và cholesterol dưới 220 mg/ml

- tỷ lệ mới mắc bệnh 10/431.
- tỷ lệ mật độ mới mắc
- tỷ lệ tấn công
- tốc độ mới mắc.

16. Tỷ lệ mới mắc của 2 bệnh A và B là tương đương nhau, nhưng tỷ lệ hiện mắc tại một thời điểm của bệnh A lại cao hơn bệnh B. Cách giải thích phù hợp là:

- bệnh A có bệnh kỳ dài hơn bệnh B.
- bệnh A có bệnh kỳ ngắn hơn bệnh B
- bệnh A có tỷ lệ tử vong cao hơn bệnh B
- bệnh B có tỷ lệ chuyển thành mạn tính cao hơn bệnh A

17. Tỷ lệ mới mắc của bệnh A và bệnh B là tương đương nhau, tỷ lệ chết/mắc của bệnh A cao hơn bệnh B, nhưng tỷ lệ hiện mắc của bệnh A và bệnh B tại một thời điểm lại như nhau. Cách giải thích phù hợp là:

- a. bệnh kỳ của A dài hơn bệnh kỳ của B.
 - b. tỷ lệ trở thành mạn tính của bệnh A thấp hơn bệnh B
 - c. tỷ lệ điều trị khỏi của bệnh A cao hơn bệnh B
 - d. không có cách giải thích nào phù hợp
18. Tỷ lệ mới mắc của bệnh A cao hơn bệnh tỷ lệ mới mắc bệnh B gấp 3 lần, nhưng tỷ lệ hiện mắc tại một thời điểm của hai bệnh lại tương đương nhau. những tình huống có thể phù hợp là:
- a. tỷ lệ chết của bệnh B cao hơn bệnh A
 - b. tỷ lệ chết của bệnh A cao hơn bệnh B.
 - c. bệnh kỳ của bệnh B thấp hơn bệnh kỳ của A
 - d. Bệnh A là bệnh không chữa khỏi mà chỉ có thể kéo dài thời gian mắc bệnh còn bệnh B là bệnh có thể chữa khỏi
19. Tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ chết/mắc của bệnh A và bệnh B là tương đương nhau nhưng tỷ lệ hiện mắc của bệnh A cao hơn bệnh B. những tình huống có thể phù hợp là:
- a. bệnh A có bệnh kỳ ngắn hơn bệnh B
 - b. bệnh B có tỷ lệ chuyển thành mạn tính cao hơn bệnh A
 - c. bệnh A có tỷ lệ chuyển thành mạn tính cao hơn bệnh B.
 - d. tỷ lệ khỏi bệnh của bệnh A cao hơn bệnh B
20. Tỷ lệ hiện mắc có thể giảm bằng cách:
- a. kéo dài thời gian mắc bệnh
 - b. giảm tỷ lệ mới mắc.
 - c. tăng tỷ lệ mới mắc
 - d. cải tiến việc chẩn đoán bệnh
21. Khi muốn so sánh tỷ lệ tử vong vì một bệnh của một quần thể ở hai thời điểm khác nhau, cần phải dựa vào
- a. tỷ lệ tử vong thô
 - b. tỷ lệ tử vong riêng phần cho từng nhóm tuổi và phân bố dân số theo nhóm tuổi.
 - c. tỷ lệ tử vong riêng phần cho từng nhóm tuổi
 - d. không thể so sánh được vì thời gian cách xa nhau không cho giá trị tin cậy
22. Bảng số liệu sau đây trình bày tỷ lệ tử vong thô và tỷ lệ tử vong chuẩn hoá theo tuổi tại thành phố New York và toàn bộ nước Mỹ trong vòng 40 năm. Dựa vào bảng số liệu này để giải thích những điều sau:

Bảng: tỷ lệ tử vong thô và tỷ lệ tử vong chuẩn hóa theo tuổi do mọi nguyên nhân tính trên 1000 dân

Năm	Thành phố New York		Nước Mỹ	
	Tỷ lệ chuẩn hoá theo tuổi	Tỷ lệ tử vong thô	Tỷ lệ chuẩn hoá theo tuổi	Tỷ lệ tử vong thô
1940	11,3	10,2	10,8	10,8
1950	8,9	10,0	8,4	9,6
1960	8,1	11,1	7,6	9,5
1970	7,7	11,2	7,1	9,5
1980	6,6	10,8	5,9	9,9

- tỷ lệ tử vong thô cho phép nhận định về xu thế tử vong theo năm ở thành phố newYork và nước Mỹ
 - yếu tố tuổi của cùng một cộng đồng **không** ảnh hưởng sai lệch đến nhận định về xu thế tử vong theo năm
 - tỷ lệ tử vong thô cho nhận định rằng tỷ lệ tử vong có xu hướng tăng và tỷ lệ tử vong ở New York cao hơn so với cả nước
 - tỷ lệ tử vong chuẩn hoá theo tuổi là cần thiết và tốt nhất khi so sánh.
23. Năm 1970 tỷ lệ tử vong thô tại Guyana (một nước đang phát triển tại Nam Phi) là 6,8 trên 1000 dân và tỷ lệ này tại mỹ là 9,8 trên 1000 dân. Tỷ lệ tử vong thô tại Guyana thấp hơn so với Mỹ có thể được giải thích như thế nào là phù hợp
- Mỹ có tổng số dân lớn hơn
 - Cơ cấu dân số theo tuổi khác nhau giữa hai nước: ở các nước phát triển tỷ lệ tử vong thô thấp nhưng tỷ lệ tử vong riêng phần theo tuổi cao, và ngược lại ở các nước phát triển
 - không so sánh được khi không chuẩn hoá tỷ lệ tử vong theo tuổi.
 - Không có cách lý giải nào phù hợp
24. Tỷ lệ tử vong thô và tỷ lệ tử vong chuẩn hoá theo tuổi (tính trên 100000 dân) do bị bệnh tim và bệnh xơ cứng động mạch tại Chile và Mỹ năm 1967 trình bày ở bảng sau đây, cho phép đưa ra những nhận định nào?

Bảng: Tỷ lệ tử vong thô và tỷ lệ tử vong chuẩn hoá theo tuổi do bị bệnh tim mạch

Nước	Tỷ lệ tử vong thô	Tỷ lệ tử vong chuẩn hoá
Chile	67,4	58,2
Mỹ	316,3	131,4
Tỷ suất Mỹ/Chile	4,7	2,3

- a. sử dụng tỷ lệ tử vong chuẩn hoá theo tuổi để so sánh tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch giữa hai nước.
 - b. sự khác biệt về tỷ suất tử vong giữa mỹ và chi lê theo tỷ lệ tử vong thô cao hơn theo tỷ lệ tử vong chuẩn hoá theo tuổi vì dân số Mỹ lớn hơn dân số chile
 - c. sự khác biệt về tỷ suất tử vong giữa mỹ và chi lê theo tỷ lệ tử vong thô cao hơn theo tỷ lệ tử vong chuẩn hoá theo tuổi vì cơ cấu dân số Mỹ khác so với cơ cấu dân số của chile
 - d. không thể nhận định gì theo kết quả số liệu trên
25. Tỷ lệ chết của trẻ em dưới 1 tuổi trên 10000 trẻ đẻ sống
- a. từ 24 giờ đến 1 năm tuổi trên 10000 trẻ đẻ sống
 - b. dưới 6 tháng tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống
 - c. dưới 1 năm tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống.
 - d. dưới 1 năm tuổi trên 1000 cuộc đẻ
26. Tỷ lệ suy dinh dưỡng theo năm của trẻ dưới 5 tuổi có thể sử dụng trong các mục đích sau:
- a. xác định tần xuất mắc suy dinh dưỡng của một trẻ dưới 5 tuổi
 - b. Đánh giá hiệu quả của các dịch vụ y tế và lên kế hoạch dịch vụ chăm sóc cho năm sau.
 - c. Xác định yếu tố nguy cơ đối với suy dinh dưỡng của trẻ
 - d. So sánh tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi giữa các năm
27. Trong một cộng đồng bao gồm 100000 người có 1000 trường hợp mắc 1 bệnh, trong đó 200 trường hợp chết vì bệnh đó trong năm. Tỷ lệ chết vì bệnh này là
- a. 0,2 %
 - b. 1%
 - b. 2%
 - d. 20%.

Chọn câu trả lời đúng/sai phù hợp với mỗi câu sau:

STT	Câu hỏi	Đ	S
1.	Nghiên cứu ngang cho phép tính được tỷ lệ hiện mắc		
2.	Nghiên cứu bệnh chứng cho phép tính toán trực tiếp được các số mới mắc của hai nhóm nghiên cứu và nhóm chứng.		
3.	Nghiên cứu thuần tập tương lai cho phép tính được tỷ lệ mới mắc, mật độ mới mắc.		
4.	Muốn giảm tỷ lệ hiện mắc thì có thể thực hiện biện pháp chống dịch hữu hiệu như bảo vệ khỏi cảm nhiễm, cắt đường truyền nhiễm, không để xuất hiện những trường hợp bệnh mới		
5.	Muốn giảm tỷ lệ hiện mắc có thể thực hiện điều trị khỏi, rút ngắn thời gian điều trị		

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

1. Tỷ lệ hiện mắc được tính như sau: $p = \frac{\dots}{\dots}$
2. Tỷ lệ mới mắc tích lũy (CI) được tính như sau: $CI = \dots / \dots$
3. Tỷ lệ mật độ mới mắc (IDR) được tính như sau: $IDR = \dots / \dots$
4. Tỷ lệ tấn công $= \dots / \dots$
5. Nếu tỷ lệ hiện mắc $p < 10\%$ liên quan giữa tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mới mắc được thể hiện qua đẳng thức sau: $P = \dots$
6. Nếu tỷ lệ hiện mắc $p \geq 10\%$ thì liên quan giữa tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mới mắc được thể hiện qua đẳng thức sau: $P = \dots / \dots$
7. Tỷ lệ chết thô (CDR) được tính như sau $CDR = \dots / \dots \cdot 10^n$
8. Tỷ lệ tử vong riêng phần theo tuổi $= \dots / \dots \cdot 10^n$
9. Tỷ lệ tử vong theo nguyên nhân trong quần thể $= \dots / \dots \cdot 10^n$
10. Tỷ lệ chết/mắc $= \dots / \dots \cdot 10^n$
11. Tỷ lệ suy dinh dưỡng theo năm của trẻ em dưới 5 tuổi $= \dots / \dots$
12. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm phòng đầy đủ $= \dots / \dots$

Đo lường sự kết hợp

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất

1. Nguy cơ tương đối được sử dụng để đánh giá:
 - a. Độ lớn của sự kết hợp chặt chẽ hay không giữa một yếu tố nguy cơ và bệnh.
 - b. tần suất xuất hiện trường hợp bệnh trong cộng đồng
 - c. kết quả đo lường được sau một nghiên cứu thuần tập
 - d. kết quả đo lường được sau một nghiên cứu bệnh chứng
2. Tỷ suất chênh được sử dụng để đánh giá
 - a. Độ lớn của sự kết hợp chặt chẽ hay không giữa một yếu tố nguy cơ và bệnh.
 - b. thể hiện tần suất phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ
 - c. kết quả đo lường được sau một nghiên cứu bệnh chứng
 - d. kết quả đo lường được sau một nghiên cứu thuần tập
3. Có thể tính toán được nguy cơ tương đối dựa vào các số đo bệnh trạng sau:
 - a. tỷ lệ mới mắc.
 - b. tỷ lệ hiện mắc kỳ
 - c. tốc độ mới mắc
 - d. tỷ lệ chết/mắc của một bệnh
4. Nguy cơ qui thuộc có thể tính toán được sau các nghiên cứu
 - a. nghiên cứu ngang
 - b. nghiên cứu thuần tập.
 - c. nghiên cứu bệnh chứng
 - d. nghiên cứu chùm bệnh
5. Trong một nghiên cứu xác định sự kết hợp giữa hút thuốc lá và ung thư phổi nhà nghiên cứu theo dõi 1000 đối tượng có hút thuốc ở các mức độ khác nhau trong 20 năm. Cũng trong thời gian này, ông theo dõi 1000 đối tượng không hút thuốc. Sau thời gian theo dõi có 20 trường hợp bệnh ở nhóm có hút thuốc và 5 trường hợp bệnh ở nhóm không hút thuốc. kết quả nghiên cứu có thể tính toán được các chỉ số
 - a. chỉ suất chênh $= (20 \times 1000) / (5 \times 1000)$
 - b. nguy cơ tương đối $RR = (20/1000) / (5/1000)$.
 - c. nguy cơ qui thuộc $AR = (25/1000) - (20/1000)$
 - d. nguy cơ qui thuộc phần trăm $AR\% = \{(25/1000) - (20/1000)\} / (25/1000)$

6. Trong một nghiên cứu thuần tập, nhóm nghiên cứu gồm 200 người có sử dụng thuốc tránh thai OC, theo dõi trong 2 năm. Sau thời gian theo dõi 6 tháng đầu có 3 trường hợp bị nhiễm khuẩn niệu. có 10 trường hợp bỏ nghiên cứu sau khi đã theo dõi 1 năm. Đồng thời theo dõi 200 trường hợp không sử dụng thuốc tránh thai OC. Sau 3 tháng theo dõi có 1 trường hợp bị nhiễm khuẩn niệu. có 18 trường hợp bỏ nghiên cứu sau khi theo dõi được 10 tháng. kết quả nghiên cứu được trình bày bằng bảng tiếp liên 2x2 dựa vào số đo bệnh trạng nào?
- tỷ lệ mới mắc tích lũy
 - mật độ mới mắc.
 - tỷ lệ hiện mắc điểm
 - tỷ lệ tấn công
7. Kết quả nghiên cứu trên được trình bày theo số đo bệnh trạng sau:
- mật độ mới mắc của nhóm có dùng thuốc = $3/404$ (tháng - người).
 - mật độ mới mắc của nhóm có dùng thuốc = $3/480$ (tháng-người)
 - tỷ lệ mới mắc tích lũy nhóm có dùng thuốc = $3/200$
 - tỷ lệ mới mắc tích lũy của nhóm có dùng thuốc = $3/190$
8. Để tính toán các chỉ số đo lường sự kết hợp, kết quả nghiên cứu phải được trình bày theo bảng 2x2 các số đo bệnh trạng sau:
- tỷ lệ mới mắc tích lũy.
 - tỷ lệ tấn công
 - tỷ lệ hiện mắc kỳ
 - tỷ lệ tốc độ mới mắc
9. Từ kết quả nghiên cứu ở bảng số liệu sau, hãy tính:

Bảng: tỷ lệ chết do bệnh ung thư phổi ở những người tuổi từ 35 tuổi trở lên

Tỷ lệ chết do ung thư phổi trên 1000 người tuổi trên 35, hàng năm	
Người không hút thuốc lá	0,07
Người hút thuốc lá	0,96

- $RR = 0,07/0,96$
- $RR = 0,96/0,07$.
- $AR = (0,96 - 0,07)/0,96$
- Không thể tính toán được với số liệu trên

10. Để nghiên cứu căn nguyên gây phù, tăng huyết áp, protein niệu, tiền sản giật và sản giật. một nhà nghiên cứu chọn 150 bà mẹ không bị hội chứng nêu trên trong thời kỳ có thai (dựa vào hồ sơ lưu trữ tại bệnh viện) và 150 bà mẹ có hội chứng nêu trên rồi khai thác tiền sử ăn uống những thức ăn giàu muối để đánh giá sự kết hợp giữa lượng muối ăn và tình trạng bệnh. Đây là một thí dụ về:
- nghiên cứu bệnh chứng.
 - nghiên cứu thuần tập hồi cứu
 - nghiên cứu mô tả chùm bệnh
 - nghiên cứu ngang

11. Từ nghiên cứu trên, giả sử kết quả thu được như sau:

	Có bệnh	Không bệnh	tổng số
1.lượng muối ăn từ 10gr/ngày trở lên	100	20	120
2. lượng muối ăn 2-10 gr/ngày	35	40	75
3. lượng muối ăn dưới 2 gr/ngày	15	110	125
	150	150	300

Có thể tính toán nguy cơ giữa nhóm 1 và nhóm 3 như sau:

- $RR = (100/120)/(15/125)$
 - $RR = 100 - (20/120)$
 - $OR = (100 \times 110)/(20 \times 15)$.
 - $OR = (100 \times 150)/(20 \times 150)$
12. Trong một nghiên cứu bệnh chứng người ta tính được nguy cơ qui thuộc phần trăm (AR%) của một yếu tố nguy cơ với bệnh là 30%. Điều đó có nghĩa là:
- có 30% số người phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ bị bệnh
 - có 30% số người phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ không bị mắc bệnh
 - 30% số người mắc bệnh là do yếu tố nguy cơ gây ra.
 - Chênh lệch về số người phơi nhiễm bị bệnh lớn hơn số người không phơi nhiễm bị bệnh là 30%
13. Một nghiên cứu bệnh chứng về sự thiếu hụt canxi trong khẩu phần ăn và tình trạng bệnh của bà mẹ trong thời kỳ mang thai. kết quả cho thấy sự chênh lệch về thiếu hụt canxi trong chế độ ăn của hai nhóm có bệnh và không có bệnh là 5. Điều đó có nghĩa là:
- thiếu hụt canxi chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh lý ở thai phụ
 - không phù hợp với nghiên cứu.

- c. nhóm phụ nữ mang thai mà thiếu canxi có nguy cơ mắc bệnh gấp 5 lần nhóm ăn đủ canxi
- d. cứ 10 phụ nữ mang thai thiếu hụt canxi trong khẩu phần ăn thì có 5 phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh
14. Nhà nghiên cứu cũng tính được nguy cơ qui thuộc trong nghiên cứu này là 80%. Điều đó có nghĩa là:
- a. trong số những phụ nữ bị bệnh 80% là do ăn thiếu canxi lúc mang thai
- b. 80% những phụ nữ mang thai bị bệnh trong nhóm ăn thiếu canxi là do chính chế độ ăn thiếu hụt canxi gây ra. nếu cung cấp đủ canxi trong chế độ ăn của phụ nữ mang thai sẽ giảm được 80% trường hợp bệnh.
- c. vẫn có 20% phụ nữ ăn thiếu canxi mà không bị bệnh
- d. vẫn có 20% phụ nữ bị bệnh mà không phải do thiếu canxi lúc mang thai
15. Trong một nghiên cứu tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim được tiến hành ở nhóm đàn ông có gia đình và nhóm đàn ông sống độc thân. Kết quả thu được như sau:
- Bảng : Tỷ lệ bị nhồi máu cơ tim ở đàn ông 40-64 tuổi (tỷ lệ chuẩn hoá theo tuổi)*

	Tỷ lệ mới mắc 100000 năm người	Tỷ lệ tử vong 100000 năm người
Nhóm có gia đình	1371	498
Nhóm sống độc thân	1228	683

Nguy cơ tương đối mắc nhồi máu cơ tim của nhóm đàn ông có gia đình và nhóm đàn ông sống độc thân là $RR = 1371/1228 = 1,1$. Và nguy cơ tương đối tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim ở đàn ông có gia đình và đàn ông sống độc thân là $498/683 = 0,7$. Điều này có nghĩa là :

- a. tỷ lệ mắc nhồi máu cơ tim ở đàn ông có gia đình thấp hơn so với đàn ông sống độc thân
- b. có sự kết hợp liên quan giữa về tỷ lệ tử vong do bệnh nhồi máu giữa đàn ông có gia đình và đàn ông sống độc thân
- c. nhồi máu cơ tim ở đàn ông có gia đình nhẹ hơn so với nhóm độc thân hay họ được chăm sóc tốt hơn.
- d. tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim ở đàn ông có gia đình thấp hơn so với tỷ lệ tử vong ở đàn ông sống độc thân

Chọn câu trả lời đúng/sai phù hợp với mỗi câu sau:

STT	Câu hỏi	Đ	S
1.	Nguy cơ tương đối đo lường sau 1 nghiên cứu có nhóm so sánh		
2.	Nguy cơ qui thuộc chỉ tính toán được sau một nghiên cứu thuần tập		
3.	Trong các nghiên cứu dịch tễ học cần lựa chọn số đo bệnh trạng thích hợp, đo lường chính xác cho phép hạn chế được các ước lượng trội hoặc ước lượng non của nguy cơ		
4.	Nguy cơ tương đối được tính trực tiếp trong các nghiên cứu bệnh chứng		
5.	Chỉ suất chênh được tính toán trong các nghiên cứu thuần tập		
6.	Nếu kết quả nghiên cứu tính toán được $RR=4,5$. Điều đó có nghĩa là có sự kết hợp giữa yếu tố nguy cơ và bệnh. Nhóm có phơi nhiễm có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 4,5 so với nhóm không phơi nhiễm.		
7.	Kết quả nghiên cứu bệnh chứng tính toán được $AR\% = 25\%$. Điều đó có nghĩa là 25% bệnh có phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ do chính yếu tố nguy cơ gây ra. Nếu loại bỏ được sự phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ thì tỷ lệ mắc bệnh giảm 25%		
8.	trong nghiên cứu thuần tập về kết hợp bệnh mạch vành với sử dụng NTT sau mãn kinh, tính $AR\% = -11\%$. Điều đó có nghĩa là có 11% số trường hợp bệnh của nhóm phơi nhiễm được giảm đi nhờ chính vào việc dùng NTT sau mãn kinh		

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

1. Nguy cơ tương đối được tính theo công thức $RR = \frac{\dots}{\dots}$
2. Nguy cơ qui thuộc phần trăm $AR\% = \dots / \dots \times 10^2$
3. Chỉ suất chênh $OR = \dots / \dots$
4. Nguy cơ tuyệt đối để đo lường.....
5. Nguy cơ tương đối đo lường

6. nguy cơ qui thuộc là số đo về ảnh hưởng tác động của (a).....
đối với (b)nếu kết hợp quan sát là có giá trị nhân quả.

Nghiên cứu dịch tễ học mô tả

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất

1. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả có thể được lựa chọn khi cần
 - a. đánh giá chiều hướng sức khỏe cộng đồng, so sánh giữa các vùng trong một nước hay nhiều nước.
 - b. đánh giá sự kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh
 - c. đánh giá hiệu quả của các giải pháp can thiệp dự phòng
 - d. đánh giá tỷ lệ quần thể có phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ
2. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả cho phép nhận định
 - a. giả thiết có sự kết hợp giữa yếu tố nguy cơ và bệnh.
 - b. kết luận chắc chắn về sự kết hợp giữa yếu tố nguy cơ và bệnh
 - c. xác định tỷ lệ bệnh hiếm gặp
 - d. xác định được mức độ phơi nhiễm ở từng cá thể
3. Nghiên cứu mô tả cho phép thu thập thông tin nhằm
 - a. cung cấp thông tin làm cơ sở cho hoạch định kế hoạch và đánh giá các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe.
 - b. xác định chi phí dịch vụ y tế
 - c. xác định mức độ bệnh ở mỗi cá thể nghiên cứu
 - d. xác định mức độ lây lan của các bệnh nhiễm trùng
4. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả thích hợp cho các nghiên cứu về:
 - a. bệnh hiếm gặp
 - b. phơi nhiễm hiếm gặp
 - c. khai thác quan hệ nhân quả nhanh và rẻ
 - d. lập kế hoạch cho các chăm sóc y tế.
5. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả gồm các thiết kế sau:
 - a. nghiên cứu chùm bệnh.
 - b. nghiên cứu can thiệp
 - c. nghiên cứu phân tích
 - d. nghiên cứu ca bệnh hiếm gặp có đối chứng
6. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả chỉ cần thu thập số liệu từ quần thể đặc biệt đối với thiết kế nghiên cứu sau:
 - a. nghiên cứu tương quan.

- b. nghiên cứu chùm bệnh
 - c. nghiên cứu ngang
 - d. nghiên cứu ca bệnh mới, hiếm gặp
7. Trong một nghiên cứu vào năm 1974, Creech và John mô tả bệnh ung thư mạch gan ở 3 công nhân tiếp xúc vinyl chlorid. Số trường hợp ung thư này trong một quần thể nhỏ trong một khoảng thời gian nghiên cứu là bất thường. Và dẫn đến giả thiết là tiếp xúc nghề nghiệp với vinyl chlorid gây ung thư mạch gan. Đây là một thí dụ về thiết kế nghiên cứu
- a. nghiên cứu tương quan
 - b. nghiên cứu chùm bệnh.
 - c. nghiên cứu ngang
 - d. nghiên cứu phân tích so sánh
8. Mô tả hình thái tử vong do động mạch vành có liên quan đến số thuốc lá bán ra trên đầu người năm 1960 ở 44 bang của Mỹ, cho thấy tỷ lệ tử vong do động mạch vành cao nhất ở các bang có thuốc lá bán ra nhiều nhất và thấp nhất ở các bang có thuốc lá bán ra ít nhất. Đây là một thí dụ về thiết kế nghiên cứu:
- a. nghiên cứu phân tích so sánh
 - b. nghiên cứu tương quan.
 - c. nghiên cứu ngang
 - d. nghiên cứu chùm bệnh
9. Nghiên cứu tương quan cho thấy sự tương quan nghịch chiều mạnh mẽ giữa tiêu thụ rượu và tỷ lệ tử vong do động mạch vành, ở những nước có tiêu thụ rượu cao nhất thì tỷ lệ tử vong do động mạch vành thấp nhất và ngược lại. Điều này được lý giải là:
- a. nghiên cứu tương quan chỉ mô tả phơi nhiễm trung bình của một quần thể mà không mô tả mức phơi nhiễm của từng cá thể. Và liệu mức độ tiêu thụ rượu ở mỗi cá thể có thể ảnh hưởng đến kết hợp âm tính hay dương tính giữa tiêu thụ rượu và tỷ lệ tử vong do bệnh mạch vành.
 - b. thông tin không đủ và không thể so sánh được
 - c. không loại trừ được các yếu tố nhiễu ở mỗi cá thể
 - d. thông tin về bệnh không giống nhau ở mỗi nước.
10. Sản phẩm của thiết kế nghiên cứu ngang là:
- a. tỷ lệ hiện mắc điểm.
 - b. tỷ lệ mới mắc
 - c. tốc độ mới mắc

- d. kết luận về kết hợp nhân quả
11. Một nhà nghiên cứu muốn xác định mối liên quan giữa bệnh sốt rét và thói quen không nằm màn. Nhà nghiên cứu chọn 100 bệnh nhân bị sốt rét và 100 người chưa bị sốt rét bao giờ cùng tuổi với bệnh nhân. Sau đó điều tra tiền sử nằm màn của những người đó để đánh giá. Đây là ví dụ về nghiên cứu :
 - a. nghiên cứu mô tả
 - b. nghiên cứu bệnh chứng.
 - c. nghiên cứu thuần tập
 - d. nghiên cứu tương quan
12. Cần thiết kế nghiên cứu nào cho phù hợp với mục đích xác định tỷ lệ viêm đường hô hấp trên và mô tả đặc điểm bệnh theo nhóm nghề, tuổi, giới, mức độ ô nhiễm bụi tại một làng nghề dệt thảm trong năm 2004.
 - a. thiết kế nghiên cứu ngang.
 - b. thiết kế nghiên cứu tương quan vì nhanh có thông tin và rẻ
 - c. thiết kế nghiên cứu mô tả trên cơ sở lựa chọn các trường hợp bệnh được chẩn đoán tại trạm y tế trong năm 2004
 - d. thiết kế nghiên cứu thuần tập
13. Thiết kế nghiên cứu ngang thường được áp dụng khi lần đầu tiên nghiên cứu về một bệnh trên một cộng đồng mới chưa có thông tin vì :
 - a. xác định được tỷ lệ mắc và phơi nhiễm cùng một thời điểm hình thành giả thiết về kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh.
 - b. thu thập thông tin về bệnh và phơi nhiễm trên cùng cá thể lên có thể xác định được yếu tố nguy cơ thường xảy ra trước và bệnh là hậu quả
 - c. thiết kế nhanh, rẻ, có thể nghiên cứu trên cộng đồng rộng
 - d. là thiết kế bắt buộc khi bắt đầu nghiên cứu về một bệnh.
14. Thông tin thu thập trong một nghiên cứu ngang là
 - a. thông tin có sẵn từ quần thể
 - b. thông tin về phơi nhiễm và bệnh ở mỗi cá thể.
 - c. thông tin về bệnh phải dựa kết quả chẩn đoán chắc chắn tại các bệnh viện
 - d. thông tin về phơi nhiễm phải được đo lường chính xác theo các mức độ khác nhau
15. Đặc điểm cần mô tả trong một nghiên cứu dịch tễ học mô tả :
 - a. mô tả đặc điểm bệnh theo giới, tuổi, tình trạng hôn nhân, sử dụng thuốc...
 - b. mô tả ai bị bệnh ? ở đâu ? khi nào ?.
 - c. mô tả bệnh xảy ra ở đâu ?

- d. bệnh xảy ra khi nào ?
16. nghiên cứu tương quan về số lượng tivi bán ra ở các bang khác nhau và tỷ lệ béo phì ở trẻ em có thể cho nhận định trội của kết hợp số tivi bán ra và bệnh béo phì ở trẻ em vì :
- không kiểm soát được các yếu tố nhiễu như chế độ ăn, chế độ vận động...
 - không mô tả được mức độ thời gian xem tivi ở mỗi cá nhân
 - bị ảnh hưởng bởi chính sự phát triển khác nhau giữa các bang
 - thông tin từ quần thể không chính xác
17. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả được áp dụng nhiều vì :
- dễ dàng lựa chọn được nhóm nghiên cứu
 - thiết lập được giả thiết về nhân quả căn nguyên.
 - dễ thực hiện ở các nghiên cứu cộng đồng
 - không gây tâm lý lo lắng cho đối tượng nghiên cứu
18. Kết quả nghiên cứu ngang cho phép tính toán các chỉ số bệnh trạng :
- tỷ lệ hiện mắc.
 - tỷ lệ mới mắc
 - nguy cơ tương đối
 - nguy cơ qui thuộc
19. Kết quả nghiên cứu ngang được sử dụng :
- lập kế hoạch cho các hoạt động dịch vụ y tế.
 - kết luận về kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh
 - chứng minh về kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh trên cơ sở các số đo bệnh trạng thu được
 - căn cứ cho một liệu trình điều trị

Chọn câu trả lời đúng/sai phù hợp với mỗi câu sau:

STT	Câu hỏi	Đ	S
1.	Nghiên cứu dịch tễ học mô tả là nghiên cứu ban đầu khi muốn nghiên cứu về một bệnh trạng tại một cộng đồng chưa có thông tin đầy đủ.		
2.	nghiên cứu dịch tễ học mô tả chỉ áp dụng khi nghiên cứu trên phạm vi rộng, số lượng mẫu lớn không thể tiến hành được các nghiên cứu phân tích		
3.	Nghiên cứu đợt bệnh áp dụng khi nghiên cứu xác định bắt đầu dịch hay một bệnh mới		

4.	Một trong những hạn chế của nghiên cứu đợt bệnh là không tính toán được tỷ lệ hiện mắc		
5.	Một trong những hạn chế của nghiên cứu tương quan là không có khả năng kết nối giữa phơi nhiễm và bệnh ở từng cá thể riêng biệt		
6.	Trong nghiên cứu ngang, thông tin về bệnh và phơi nhiễm có thể khai thác trực tiếp ở mỗi cá thể		
7.	hạn chế của nghiên cứu ngang là không xác định được trật tự liên quan giữa phơi nhiễm và bệnh		
8.	trong các thiết kế nghiên cứu mô tả, nghiên cứu tương quan là nghiên cứu duy nhất sử dụng 1 nguồn thông tin từ quần thể		

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

- Nghiên cứu dịch tễ học mô tả là nghiên cứu về hình thái xuất hiện bệnh có liên quan đến các biến số như (a), (b), (c)
- Ứng dụng quan trọng của nghiên cứu dịch tễ học mô tả là..... và được kiểm nghiệm ở các nghiên cứu phân tích sau này.
- Điều tra ngang là cung cấp hình ảnh (a) về (b).....và các yếu tố ảnh hưởng tại một thời điểm
- Điều tra ngang là xác định tỷ lệ (a), bệnh và phơi nhiễm được đánh giá đồng thời tại (b)
- Trong thiết kế nghiên cứu chùm bệnh, đối tượng nghiên cứu được lựa chọn là
- Trong thiết kế nghiên cứu ngang, đối tượng được chọn nghiên cứu là một quần thể trong đó bao gồm cả
- thiết kế nghiên cứu chùm bệnh không kiểm định được giả thiết nhân quả vì không có.....
- Thiết kế nghiên cứu ngang không kiểm định được giả thiết nhân quả vì không thể xác định được giữa phơi nhiễm và bệnh.

Sàng tuyển phát hiện bệnh sớm

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

1. Kỹ thuật sàng tuyển là một kỹ thuật
 - a. chẩn đoán sơ bộ bệnh
 - b. chẩn đoán phân biệt bệnh
 - c. phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.
 - d. chẩn đoán mức độ bệnh
2. Người ta tiến hành lấy mẫu xét nghiệm soi tươi đờm trực khuẩn lao bằng cách ngoáy họng hàng loạt người. Kết quả sẽ có nhóm người nghi ngờ có trực khuẩn lao và có những người không có trực khuẩn lao. Đây là một:
 - a. kỹ thuật sàng tuyển.
 - b. một biện pháp chẩn đoán bệnh sớm
 - c. biện pháp áp dụng trước khi thực hiện liệu trình điều trị lao
 - d. kỹ thuật xét nghiệm phát hiện trực khuẩn lao dễ dàng áp dụng cho nhiều đối tượng
3. Tất cả những trường hợp nghi ngờ có trực khuẩn lao đến phòng khám lao đều được khám tử mĩ và nuôi cấy đờm để xác định chính xác người bệnh lao. Đây là một:
 - a. biện pháp chẩn đoán bệnh.
 - b. kỹ thuật sàng tuyển
 - c. biện pháp chẩn đoán cộng đồng
 - d. biện pháp kiểm định độ tin cậy của xét nghiệm soi tươi tìm trực khuẩn lao
4. Kỹ thuật sàng tuyển được dùng để phát hiện sớm các bệnh:
 - a. bệnh trầm trọng khụng thể chữa khỏi được
 - b. có khả năng phát hiện sớm ở giai đoạn tiềm tàng.
 - c. bệnh hiếm gặp
 - d. bệnh nhẹ dễ can thiệp điều trị
5. Âm tính giả là
 - a. các cá thể không mắc bệnh nhưng sàng tuyển cho kết quả dương tính
 - b. các cá thể không mắc bệnh nhưng sàng tuyển cho kết quả âm tính
 - c. các cá thể có mắc bệnh nhưng sàng tuyển cho kết quả âm tính.
 - d. các cá thể có bệnh nhưng sàng tuyển cho kết quả dương tính
6. Dương tính giả là:
 - a. các cá thể không mắc bệnh nhưng sàng tuyển cho kết quả dương tính.

- b. các cá thể không mắc bệnh nhưng sàng tuyển cho kết quả âm tính
 - c. các cá thể có bệnh nhưng sàng tuyển cho kết quả âm tính
 - d. các cá thể có bệnh nhưng sàng tuyển cho kết quả dương tính
7. Giá trị tiên đoán của kỹ thuật sàng tuyển phụ thuộc vào
- a. độ nhạy
 - b. độ đặc hiệu
 - c. mức độ phổ biến của bệnh
 - d. cả 3 khả năng trên.
8. Dùng biện pháp có độ nhạy cao khi tiến hành sàng tuyển đối với bệnh có đặc điểm sau :
- a. bệnh rất nguy hiểm, nhưng phát hiện sớm có thể chữa khỏi.
 - b. dương tính giả có ảnh hưởng nhiều đến tâm lý người bệnh
 - c. âm tính giả làm thay đổi các hành vi liên quan tới giáo dục dự phòng
 - d. quá trình điều trị không gây hậu quả nghiêm trọng cho những trường hợp dương tính giả
9. Dùng kỹ thuật sàng tuyển có độ đặc hiệu cao khi tiến hành sàng tuyển đối với bệnh có đặc điểm sau :
- a. bệnh trầm trọng khó điều trị khỏi.
 - b. âm tính thật làm thay đổi các hành vi không có lợi liên quan tới giáo dục dự phòng
 - c. bệnh phổ biến trong cộng đồng
 - d. bệnh có tính lây nhiễm cao trong cộng đồng
10. Trong chương trình phát hiện bệnh đái đường, nồng độ đường máu ở mức độ sàng tuyển đối với xét nghiệm A là 160mg/100ml và đối với xét nghiệm B là 130mg/100ml. Điều này có nghĩa là:
- a. Độ nhạy của xét nghiệm A lớn hơn so với xét nghiệm B
 - b. Độ đặc hiệu của xét nghiệm A lớn hơn so với xét nghiệm B.
 - c. số dương tính giả ở xét nghiệm A lớn hơn so với xét nghiệm B
 - d. không có khả năng nào ở trên là đúng
11. Trong một chương trình phát hiện bệnh đái đường, mức sàng tuyển đối với đường máu ở 1 thử nghiệm là 160mg/100ml và ở thử nghiệm 2 là 130/100ml. Điều này có nghĩa :
- a. độ nhạy ở thử nghiệm 1 lớn hơn ở thử nghiệm 2
 - b. độ nhạy ở thử nghiệm 2 lớn hơn thử nghiệm 1.
 - c. độ nhạy phụ thuộc vào cỡ mẫu nghiên cứu từ quần thể
 - d. độ nhạy phụ thuộc vào tỷ lệ hiện mắc đái đường tại quần thể

12. Trong chương trình sàng tuyển bệnh tiểu đường, một kỹ thuật sàng tuyển được áp dụng cho 10000 người. Những cá thể có lượng đường máu từ 180mg/l được coi là tiểu đường. Kết quả được trình bày ở bảng sau:

Kết quả	Bệnh tiểu đường	Không bệnh	Tổng số
Dương tính	34	20	54
âm tính	116	9830	9946
Tổng số	150	9850	10000

- a. $S_e = \frac{34}{150} = 22,6\%$.
- b. $S_p = \frac{9850}{9946} = 99\%$
- c. $S_e = \frac{54}{150} = 36\%$
- d. $S_p = \frac{9830}{9946} = 98,8\%$
13. Kết quả trên có thể tính toán giá trị dự đoán dương tính như sau
- a. $PV(+) = \frac{34}{54} = 63\%$.
- b. $PV(+) = \frac{34}{150} = 22,6\%$
- c. $PV(+) = \frac{54}{150} = 36\%$
- d. $PV(+) = \frac{54}{10000} = 0,54\%$
14. Khi ta giảm nồng độ đường máu coi là dương tính từ 180 xuống 130mg/dl, ảnh hưởng nào đã xảy ra trên kết quả dương tính giả, kết quả âm tính giả và kết quả giá trị tiên đoán dương tính?
- a. tăng dương tính giả.
- b. tăng âm tính giả
- c. tăng giá trị tiên đoán dương tính
- d. giảm dương tính giả
15. và khi ta giảm nồng độ đường máu coi là dương tính từ 180 xuống 130mg/dl ảnh hưởng đến độ nhạy và độ đặc hiệu :
- a. Độ nhạy tăng và độ đặc hiệu giảm.
- b. độ nhạy giảm và độ đặc hiệu tăng

- c. độ nhạy tăng và độ đặc hiệu tăng
 d. độ nhạy giảm và độ đặc hiệu giảm
16. nghiệm pháp coi là dương tính khi nồng độ đường máu từ 180mg/dl trở lên, sẽ ảnh hưởng đến độ nhạy và độ đặc hiệu :
- a. độ nhạy giảm và độ đặc hiệu tăng.
 b. độ nhạy tăng và độ đặc hiệu giảm
 c. độ nhạy tăng và độ đặc hiệu tăng
 d. độ nhạy giảm và độ đặc hiệu giảm
17. nghiệm pháp coi là dương tính khi nồng độ đường máu từ 180mg/dl trở lên, sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ âm tính giả và dương tính giả :
- a. âm tính giả tăng và dương tính giả giảm.
 b. âm tính giả giảm và dương tính giả tăng
 c. âm tính giả giảm và dương tính giả giảm
 d. âm tính giả tăng và dương tính giả tăng
18. Đánh giá một chương trình sàng tuyển cần phải luôn cân nhắc 1 yếu tố quan trọng, đó là:
- a. tính khả thi của chương trình sàng tuyển về các vấn đề như: sự chấp nhận của cộng đồng đối với trắc nghiệm sàng tuyển; số người cần làm sàng tuyển và tỷ lệ của họ trong quần thể với khả năng sàng tuyển; khả năng theo dõi sau sàng tuyển đối với tất cả các trường hợp sàng tuyển dương tính
 b. tính hiệu quả của chương trình sàng tuyển như có làm giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ chết đối với bệnh làm sàng tuyển.
 c. tính tỷ lệ mắc và tỷ lệ chết của cộng đồng làm sàng tuyển
 d. tỷ lệ hiện mắc trong cộng đồng phải đủ lớn
19. Các thiết kế nghiên cứu có thể sử dụng để đánh giá chương trình sàng tuyển là:
- a. nghiên cứu ngang.
 b. nghiên cứu phân tích quan sát
 c. nghiên cứu can thiệp phân bổ ngẫu nhiên
 d. nghiên cứu mô tả nhóm dương tính với trắc nghiệm

Chọn câu trả lời đúng/sai phù hợp với mỗi câu sau:

STT	Câu hỏi	Đ	S
1.	Kỹ thuật sàng tuyển được áp dụng để phát hiện sớm bệnh trong các		

	nghiên cứu cộng đồng		
2.	Độ nhạy là xác suất xuất hiện trắc nghiệm dương tính ở những cơ thể thực sự ở trong tình trạng tiền lâm sàng cần phát hiện.		
3.	Độ đặc hiệu là xác suất xuất hiện âm tính đối với trắc nghiệm ở những cơ thể thực sự không ở trong tình trạng tiền lâm sàng cần phát hiện.		
4.	Giá trị tiên đoán dương tính của một trắc nghiệm không chỉ phụ thuộc vào độ nhạy, độ đặc hiệu của trắc nghiệm mà còn liên quan tới tỷ lệ hiện mắc của bệnh		
5.	Một test sàng tuyển bệnh tiểu đường có độ nhạy là 90% và độ đặc hiệu là 95%. Người ta định áp dụng test này để phát hiện bệnh cho 3 cộng đồng, mỗi cộng đồng có tỷ lệ hiện mắc như sau: Cộng đồng A $p=20\%$ tính được $PV(+) = 0,97$ Cộng đồng B $p = 1\%$ tính được $PV(+) = 0,15$ Cộng đồng C $p = 10\%$ tính được $PV(+) = 0,94$ Có thể chọn cộng đồng A và C để sàng lọc vì độ nhạy, độ đặc hiệu và tỷ lệ hiện mắc cao cho phép phát hiện các cá thể mắc bệnh.		
6.	thiết kế nghiên cứu tương quan có thể áp dụng để đánh giá chương trình sàng tuyển.		

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

1. Sơ đồ ma trận của nghiệm pháp sàng tuyển

Kết quả nghiệm pháp sàng tuyển	Chẩn đoán bằng xét nghiệm chuẩn		Tổng số
	Có bệnh	Không có bệnh	
Dương tính	a	b	a+b
Âm tính	c	d	c+d
Tổng số	a+c	b+d	a+b+c+d

Độ nhạy $S_e = \dots / \dots$

Độ đặc hiệu $S_p = \dots / \dots$

2. Độ nhạy là xác suất xuất hiện trắc nghiệm (a) ở những cơ thể thực sự (b) cần phát hiện

3. Độ đặc hiệu là xác suất xuất hiện trắc nghiệm (a)ở những cơ thể thực sự (b)cần phát hiện
4. Một trắc nghiệm có độ đặc hiệu cao là một trắc nghiệm có rất ít cá thểđược coi là dương tính ở trắc nghiệm đó (dương tính giả).
5. Một trắc nghiệm có độ nhạy cao là trắc nghiệm có xác suất xuất hiện dương tính cao và có rất ít trường hợpâm tính với trắc nghiệm đó (âm tính giả).
6. thiết kế nghiên cứu tương quan trong đánh giá chương trình sàng tuyển là mô tả sự tương quan giữa (a)trong quần thể với (b) trong quần thể đó.

Chẩn đoán cộng đồng

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất

1. Chẩn đoán cộng đồng nhằm:
 - a. phát hiện sớm từ cộng đồng trường hợp bệnh trạng còn ở giai đoạn tiền lâm sàng.
 - b. đưa ra một liệu trình điều trị thích hợp
 - c. sử dụng các kỹ thuật xét nghiệm chính xác
 - d. giảm chi phí cho nghiên cứu xác định tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng
2. Chẩn đoán cộng đồng và chẩn đoán lâm sàng có những điểm giống nhau về:
 - a. đối tượng chẩn đoán
 - b. thông tin thu thập từ cá thể.
 - c. chỉ định nghiên cứu trên cùng một bệnh trạng, cùng giai đoạn bệnh
 - d. chi phí tính chi tiết là tương đương
3. Chẩn đoán cộng đồng có đặc điểm sau:
 - a. mô tả trường hợp mắc bệnh hiếm gặp được phát hiện từ cộng đồng
 - b. khi có chỉ định về một bệnh
 - c. chi phí nghiên cứu rẻ, được cộng đồng chấp nhận.
 - d. đối tượng điều tra **chỉ** gồm những người bị bệnh giai đoạn tiền lâm sàng
4. Mục tiêu của chẩn đoán cộng đồng là:
 - a. Đưa ra được giải pháp phòng và khống chế phát triển bệnh trong cộng đồng.
 - b. Đưa ra liệu trình điều trị phù hợp
 - c. Điều trị khỏi đối với người bệnh
 - d. Đánh giá kỹ thuật chẩn đoán đối với nhiều cá thể.
1. Chẩn đoán cộng đồng là:
 - a. phương pháp chẩn đoán bệnh
 - b. xác định tỷ lệ mắc 1 bệnh trạng trong cộng đồng ở giai đoạn sớm.
 - c. phương pháp chẩn đoán bệnh chính xác
 - d. phương pháp chẩn đoán bệnh hiếm gặp
2. Thiết kế nghiên cứu ngang được sử dụng trong chẩn đoán cộng đồng vì:
 - a. hình thành được giả thiết nhân quả.
 - b. tính nguy cơ tương đối
 - c. thông tin có thể khai thác từ cá thể
 - d. chi phí rẻ, nhanh.

3. Nghiên cứu ngang áp dụng trong điều tra chẩn đoán cộng đồng cho phép tính toán được:
 - a. tỷ lệ hiện mắc bệnh trạng vào thời điểm điều tra.
 - b. tính dự đoán được tỷ lệ hiện mắc kỳ trong khoảng thời gian từ 1 năm trước đến sau 1 năm thực hiện điều tra cộng đồng
 - c. hồi cứu tần xuất phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ
 - d. tỷ lệ mới mắc ở nhóm không tiếp xúc với nguy cơ trong cộng đồng
4. Thiết kế nghiên cứu phù hợp trong điều tra chẩn đoán cộng đồng là:
 - a. nghiên cứu thuần tập vì vào thời điểm nghiên cứu chưa có trường hợp nào mắc bệnh
 - b. nghiên cứu ngang.
 - c. nghiên cứu bệnh chứng vì các trường hợp bệnh là đại diện cho cộng đồng
 - d. nghiên cứu chùm bệnh
5. Nghiên cứu ngang thường được lựa chọn trong các điều tra chẩn đoán cộng đồng nhằm
 - a. đảm bảo có thể chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên
 - b. có kết quả nghiên cứu ngay.
 - c. xác định tỷ lệ hiện mắc một bệnh trong cộng đồng
 - d. thiết lập giả thiết về bệnh và yếu tố nguy cơ
6. Thu thập thông tin khi thiết kế nghiên cứu ngang trong chẩn đoán cộng đồng:
 - a. về bệnh và phơi nhiễm ở mỗi cá thể tại thời điểm nghiên cứu
 - b. hồi cứu về bệnh và thông tin phơi nhiễm tại thời điểm nghiên cứu
 - c. thông tin phơi nhiễm tại thời điểm nghiên cứu và theo dõi phát hiện ca bệnh trong một khoảng thời gian ít nhất là 5 năm
 - d. hồi cứu về phơi nhiễm và thông tin về bệnh tại thời điểm nghiên cứu
7. Cách chọn mẫu thường được áp dụng nhiều nhất trong chẩn đoán cộng đồng khi địa bàn điều tra rộng :
 - a. chọn mẫu ngẫu nhiên đơn
 - b. chọn mẫu hệ thống
 - c. chọn mẫu phân tầng
 - d. chọn mẫu chùm
8. Xác xuất một trẻ dưới 5 tuổi được chọn vào mẫu nghiên cứu với $n = 500$ theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn từ một quần thể 3000 trẻ dưới 5 tuổi là :
 - a. $50/3$
 - b. $1/5$

- c. $1/6$
 - d. $3/5$
9. Mẫu ngẫu nhiên đơn có ưu điểm là :
- a. tính ngẫu nhiên cao
 - b. kết quả có tính tổng quát thấp, tính giá trị cao
 - c. tập trung được đối tượng nghiên cứu
 - d. áp dụng cho những nghiên cứu trên địa bàn rộng
10. Khung mẫu để chọn mẫu ngẫu nhiên đơn có thể dựa vào danh sách:
- a. số xã trong huyện
 - b. nhân khẩu tại địa bàn
 - a. hộ gia đình
 - b. Sổ hộ khẩu
11. Đơn vị mẫu trong mẫu ngẫu nhiên đơn với nghiên cứu đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi tại một huyện là:
- a. hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi
 - b. trẻ dưới 5 tuổi
 - c. nhà trẻ
 - d. cụm dân cư
12. Khoảng cách mẫu trong mẫu hệ thống với số đối tượng nghiên cứu là $n = 60$ được lấy từ quần thể có $N = 300$ đối tượng là:
- a. 5
 - b. 18
 - c. 20
 - d. 60
13. Số đầu tiên được chọn khi chọn mẫu hệ thống là một số ngẫu nhiên được lấy ra từ:
- a. khoảng cách mẫu thứ nhất
 - b. quần thể nghiên cứu
 - c. $2 \times$ (khoảng cách mẫu)
 - d. $3 \times$ (khoảng cách mẫu)
14. Chọn mẫu theo phương pháp chọn mẫu hệ thống, tính ngẫu nhiên rơi vào:
- a. từng tầng nghiên cứu
 - b. cá thể trong tầng
 - c. từng chùm nghiên cứu
 - d. từng lớp nghiên cứu

15. Hạn chế của một số phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên là cần phải có khung mẫu.
Trong phương pháp chọn mẫu:
- ngẫu nhiên đơn
 - mẫu chùm
 - mẫu hệ thống
 - phương pháp PPS
16. Phương pháp chọn mẫu chùm cần có ít nhất:
- 15 chùm
 - 20 chùm
 - 25 chùm
 - 30 chùm
17. Mẫu chùm có đặc điểm
- kích thước các chùm như nhau
 - kích thước các chùm không đều nhau
 - các cá thể trong mỗi chùm có đặc điểm hoàn toàn giống nhau
 - đơn vị mẫu là cá thể trong mỗi chùm
18. Bước đầu tiên cần tiến hành trong chẩn đoán cộng đồng là :
- xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng
 - thiết kế phương pháp thu thập số liệu
 - thảo luận với lãnh đạo cộng đồng
 - xác định mục tiêu
19. Lựa chọn ưu tiên khi thiết kế chẩn đoán cộng đồng:
- bệnh phổ biến và có khả năng điều trị khi phát hiện sớm
 - bệnh có tính lây truyền cao
 - bệnh hiếm gặp, không có phương pháp điều trị
 - cộng đồng ủng hộ

Lựa chọn câu trả lời đúng sai cho phù hợp

STT	Câu hỏi	Đ	S
1.	Kết quả điều tra chẩn đoán cộng đồng có thể cho phép bắt đầu một liệu trình điều trị		
2.	Một bệnh được tiến hành chẩn đoán cộng đồng nếu những trường hợp bệnh được phát hiện từ một nghiên cứu cộng đồng có khả năng điều trị được khi phát hiện sớm		

3.	Đối tượng được chọn vào trong nghiên cứu cộng đồng là những trường hợp bệnh đã được xác định rõ ràng		
4.	Kỹ thuật chẩn đoán áp dụng trong chẩn đoán cộng đồng phải đảm bảo dễ áp dụng cho nhiều người và sai lệch giữa các lần tiến hành thấp		
5.	Khi cân nhắc lựa chọn phương pháp chọn mẫu, nếu cỡ mẫu lớn, địa bàn rộng cần chọn mẫu chùm		
6.	Phương pháp chọn mẫu PPS chính là chọn mẫu chùm		
7.	Những giải pháp can thiệp cộng đồng được áp dụng càng sớm càng tốt căn cứ chủ yếu vào hiệu quả của giải pháp mà không cần xem xét tính chấp nhận và ủng hộ của cộng đồng.		

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

1. Đối tượng của nghiên cứu chẩn đoán cộng đồng là.....trong khi đối tượng của chẩn đoán lâm sàng là.....
2. Mục tiêu của chẩn đoán cộng đồng là phát hiện.....
3. Kết quả nghiên cứu chẩn đoán cộng đồng cho phép.....
4. Chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên đơn, mỗi cá thể trong quần thể có cơ hộiđược chọn vào mẫu nghiên cứu
5. Hạn chế của chọn mẫu ngẫu nhiên đơn là

Các kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin

Chọn câu trả lời đúng nhất:

1. Kỹ thuật thu thập thông tin là:

- a. Phương tiện được sử dụng để thu thập thông tin về đối tượng và vấn đề nghiên cứu
- b. Biện pháp thu thập có hệ thống những thông tin về đối tượng và vấn đề nghiên cứu
- c. Quá trình tìm kiếm, đánh giá thông tin sẵn có.
- d. Quá trình quan sát, đo lường, ghi chép, mô tả các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu.

2. Kỹ thuật thu thập thông tin sẵn có là:

- a. Hoạt động quan sát, đo lường, ghi chép mô tả những đặc điểm bình thường, không bình thường của đối tượng nghiên cứu.
- b. Một kỹ thuật thu thập thông tin định tính thông qua việc thảo luận với một nhóm người về một chủ đề
- c. Việc sử dụng các thông tin đã thu thập được, đã công bố hay chưa công bố.
- d. Việc thu thập thông tin bằng việc sử dụng các câu hỏi và ghi nhận câu trả lời trực tiếp của đối tượng nghiên cứu.

3. Kỹ thuật quan sát là:

- a. Hoạt động quan sát, đo lường, ghi chép mô tả những đặc điểm bình thường, không bình thường của đối tượng nghiên cứu.
- b. Một kỹ thuật thu thập thông tin định tính thông qua việc thảo luận với một nhóm người về một chủ đề
- c. Việc sử dụng các thông tin đã thu thập được, đã công bố hay chưa công bố.
- d. Việc thu thập thông tin bằng việc sử dụng các câu hỏi và ghi nhận câu trả lời trực tiếp của đối tượng nghiên cứu.

4. Kỹ thuật phỏng vấn là:

- a. Hoạt động quan sát, đo lường, ghi chép mô tả những đặc điểm bình thường, không bình thường của đối tượng nghiên cứu.
- b. Một kỹ thuật thu thập thông tin định tính thông qua việc thảo luận với một nhóm người về một chủ đề
- c. Việc sử dụng các thông tin đã thu thập được, đã công bố hay chưa công bố.

d. Việc thu thập thông tin bằng việc sử dụng các câu hỏi và ghi nhận câu trả lời trực tiếp của đối tượng nghiên cứu.

5. Kỹ thuật phỏng vấn là:

a. Hoạt động quan sát, đo lường, ghi chép mô tả những đặc điểm bình thường, không bình thường của đối tượng nghiên cứu.

b. Một kỹ thuật thu thập thông tin định tính thông qua việc thảo luận với một nhóm người về một chủ đề

c. Việc sử dụng các thông tin đã thu thập được, đã công bố hay chưa công bố.

d. Việc thu thập thông tin bằng việc sử dụng các câu hỏi và ghi nhận câu trả lời trực tiếp của đối tượng nghiên cứu.

6. Trong kỹ thuật thu thập thông tin sẵn có cần phải thực hiện giai đoạn:

a. Lập danh sách các thông tin trực tiếp và cần thiết phù hợp với mục tiêu nghiên cứu

b. Tìm kiếm, đánh giá thông tin sẵn có theo các tiêu chuẩn : tính phù hợp, yếu tố thời gian, tính có thể so sánh được và tính tin cậy.

c. Xây dựng câu hỏi cho phép thu thập thông tin mỗi phần.

d. Kiểm tra và ước tính thời gian hoàn thành việc trả lời phỏng vấn

7. Trong kỹ thuật thu thập thông tin sẵn có cần phải thực hiện giai đoạn:

a. Xây dựng câu hỏi cho phép thu thập thông tin mỗi phần.

b. Kiểm tra câu hỏi đề ra có cho phép thu thập và ghi lại toàn bộ những thông tin cần thiết cho nghiên cứu không

c. Sử dụng thông tin hiện có để thu thập những thông tin bổ sung

d. Kiểm tra và ước tính thời gian hoàn thành việc trả lời phỏng vấn

8. Trong kỹ thuật thu thập thông tin sẵn có cần phải thực hiện giai đoạn:

a. Viết danh sách những mục đích quan trọng nhất của nghiên cứu đang chuẩn bị tiến hành một cách ngắn gọn.

b. Lập danh sách các thông tin trực tiếp và cần thiết phù hợp với mục tiêu nghiên cứu

d. Kiểm tra và ước tính thời gian hoàn thành việc trả lời phỏng vấn

c. Tìm kiếm các thông tin hiện có

9. Tiêu chuẩn không sử dụng để tìm kiếm và đánh giá các thông tin sẵn có là:

- a. Tính chấp nhận của cộng đồng
- b. Tính phù hợp và yếu tố thời gian.
- c. Tính có thể so sánh được
- d. Tính tin cậy được

10. Các bước sử dụng thông tin hiện có để thu thập những thông tin bổ sung **không** bao gồm bước sau:

- a. Tổ chức thực hiện
- b. Kiểm tra chất lượng của thông tin
- c. Xác định giá trị của thông tin
- d. Kiểm tra và ước tính thời gian hoàn thành việc phỏng vấn

11. Khi áp dụng kỹ thuật phỏng vấn chúng ta bắt buộc phải:

- a. Sử dụng bộ câu hỏi
- b. Quan sát mô tả
- c. Tổ chức các thông tin hiện có
- d. Thảo luận với một nhóm người về một chủ đề

12. Khi áp dụng kỹ thuật thảo luận nhóm, người nghiên cứu:

- a. Không tham gia vào quá trình thảo luận, chỉ đứng ngoài quan sát, ghi nhận thông tin
- b. Tham gia vào quá trình thảo luận với vai trò hướng dẫn viên, nhận định khách quan các ý kiến thảo luận.
- c. Tham gia trực tiếp vào quá trình thảo luận như các thành viên khác.
- d. Điều khiển quá trình thảo luận, đóng góp các ý kiến và quan điểm cá nhân.

13. Việc lựa chọn kỹ thuật thu thập thông tin **không** phụ thuộc vào các yếu tố quyết định sau:

- a. Mục tiêu nghiên cứu và các biến số
- b. Người sẽ tham gia thu thập thông tin
- c. Đối tượng nghiên cứu, quan sát, đo lường
- d. Nguồn thông tin thu thập

14. Kỹ thuật thu thập thông tin tương ứng với công cụ thu thập số liệu là phiếu điền, khung số liệu là:

- a. Quan sát, thăm khám, xét nghiệm
- b. Sử dụng thông tin sẵn có
- c. Tự điền vào phiếu hỏi
- d. Phỏng vấn, thảo luận nhóm

15. Kỹ thuật thu thập thông tin tương ứng với công cụ thu thập số liệu là cảm quan, giấy, bút, bảng kiểm, bệnh án và các phương tiện kỹ thuật cần thiết là:

- a. Quan sát, thăm khám, xét nghiệm
- b. Sử dụng thông tin sẵn có
- c. Tự điền vào phiếu hỏi
- d. Phỏng vấn, thảo luận nhóm

16. Kỹ thuật thu thập thông tin tương ứng với công cụ thu thập số liệu là phiếu hướng dẫn phỏng vấn, phiếu hỏi, băng ghi âm là:

- a. Quan sát, thăm khám, xét nghiệm
- b. Sử dụng thông tin sẵn có
- c. Tự điền vào phiếu hỏi
- d. Phỏng vấn, thảo luận nhóm

17. Kỹ thuật thu thập thông tin tương ứng với công cụ thu thập số liệu là bộ câu hỏi là:

- a. Quan sát, thăm khám, xét nghiệm
- b. Sử dụng thông tin sẵn có
- c. Tự điền vào phiếu hỏi
- d. Phỏng vấn, thảo luận nhóm

18. Lựa chọn công cụ thu thập thông tin phù hợp với kỹ thuật thu thập thông tin là sử dụng thông tin sẵn có:

- a. cảm quan, giấy, bút, bảng kiểm, bệnh án và các phương tiện kỹ thuật cần thiết
- b. phiếu điền, khung số liệu
- c. bộ câu hỏi
- d. phiếu hướng dẫn phỏng vấn, phiếu hỏi, băng ghi âm

19. Lựa chọn công cụ thu thập thông tin phù hợp với kỹ thuật thu thập thông tin quan sát, thăm khám, xét nghiệm:

- a. cảm quan, giấy, bút, bảng kiểm, bệnh án và các phương tiện kỹ thuật cần thiết
- b. phiếu điền, khung số liệu
- c. bộ câu hỏi
- d. phiếu hướng dẫn phỏng vấn, phiếu hỏi, băng ghi âm

20. Lựa chọn công cụ thu thập thông tin phù hợp với kỹ thuật thu thập thông tin phỏng vấn, thảo luận nhóm:

- a. cảm quan, giấy, bút, bảng kiểm, bệnh án và các phương tiện kỹ thuật cần thiết
- b. phiếu điền, khung số liệu
- c. bộ câu hỏi
- d. phiếu hướng dẫn phỏng vấn, phiếu hỏi, băng ghi âm

21. Thu thập thông tin với kỹ thuật tự điền vào phiếu hỏi thì công cụ thu thập thông tin phù hợp là :

- a. cảm quan, giấy, bút, bảng kiểm, bệnh án và các phương tiện kỹ thuật cần thiết
- b. phiếu điền, khung số liệu
- c. bộ câu hỏi
- d. phiếu hướng dẫn phỏng vấn, phiếu hỏi, băng ghi âm

22. Loại công cụ thu thập thông tin hay được sử dụng nhất là

- a. Bộ câu hỏi và phiếu hỏi
- b. Khung số liệu, phiếu điền
- c. Bệnh án
- d. Phiếu ghi chép kết quả xét nghiệm

23. Sai số thường gặp trong quá trình thu thập thông tin là:

- a. Sai số ngẫu nhiên
- b. Sai số hệ thống
- c. Sai số do nhiều
- d. Cả ba loại trên

24. Sai số có thể gặp trong thu thập thông tin là:

- a. Do công cụ thu thập thông tin thiếu chính xác
- b. Do sai lầm của người thu thập thông tin
- c. Sai lầm của người cung cấp thông tin
- d. Gặp cả ba loại trên

25. Biện pháp quan trọng nhất để loại trừ các sai số hệ thống là:

- Chọn mẫu ngẫu nhiên, xác định cỡ mẫu đủ lớn
- Thiết kế nghiêm ngặt và tuân thủ triệt để qui trình nghiên cứu
- Phân tích tầng.
- Cả ba biện pháp trên

Đánh dấu vào cột Đ nếu câu trả lời là đúng và đánh dấu vào cột S nếu câu trả lời là sai:

	Đ	S
Nguyên tắc lựa chọn phương pháp thu thập thông tin là:		
1. Đơn giản, dễ sử dụng đặc biệt khi triển khai trên diện rộng		
2. Có giá trị khoa học cao, ít sai số trong quá trình thu thập		
3. Không nhất thiết phải dễ dàng xử lý, phân tích số liệu thu được		
4. Sử dụng tối đa các nguồn lực		
5. Mục tiêu nghiên cứu không quyết định việc lựa chọn kỹ thuật thu thập thông tin		
6. Các biến số quyết định việc lựa chọn kỹ thuật thu thập thông tin		
7. Đối tượng nghiên cứu, quan sát, đo lường quyết định việc lựa chọn kỹ thuật thu thập thông tin		
8. Loại nghiên cứu không quyết định việc lựa chọn kỹ thuật thu thập thông tin		
9. Nguồn thu thập số liệu quyết định việc lựa chọn kỹ thuật thu thập thông tin		

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

1. Liệt kê bốn kỹ thuật thu thập thông tin cơ bản:

-
-
-
-

2. Bốn tiêu chuẩn của thông tin khi áp dụng kỹ thuật thu thập thông tin sẵn có:

-
-

- c.
 - d.
3. Trình bày ba tiêu chuẩn của một bộ câu hỏi tốt:
- a.
 - b.
 - c.

Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng

Chọn câu trả lời đúng nhất:

1. Nghiên cứu bệnh chứng là:
 - a. Nghiên cứu quan sát
 - b. Nghiên cứu thực nghiệm.
 - c. Nghiên cứu cắt ngang.
 - d. Nghiên cứu chùm bệnh.

2. Nghiên cứu bệnh chứng là:
 - a. Nghiên cứu mô tả.
 - b. Nghiên cứu phân tích
 - c. Nghiên cứu thực nghiệm
 - d. Nghiên cứu cắt ngang

3. Nghiên cứu bệnh chứng là:
 - a. Nghiên cứu cắt ngang.
 - b. Nghiên cứu tương quan.
 - c. Nghiên cứu tương lai
 - d. Nghiên cứu hồi cứu

4. Trong nghiên cứu bệnh chứng, các đối tượng nghiên cứu được xác định dựa trên.
 - a. Tình trạng bệnh.
 - b. Tình trạng phơi nhiễm.
 - c. Tình trạng bệnh hoặc phơi nhiễm đều được.
 - d. Chọn ngẫu nhiên bất kỳ.

5. Trong nghiên cứu bệnh chứng, các nhóm nghiên cứu
 - a. Được áp dụng một loại thuốc điều trị mới
 - b. Được khai thác và so sánh tiền sử tiếp xúc với yếu tố nguy cơ.
 - c. Được can thiệp một phương pháp điều trị nào đó
 - d. Được theo dõi sự phát triển bệnh trong một thời gian dài

6. Đặc điểm của nghiên cứu bệnh chứng là

- a. Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu tất cả các sự kiện cần nghiên cứu (tình trạng phơi nhiễm và bệnh) chưa xảy ra.
- b. Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu các cá thể đã có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ nhưng chưa phát triển bệnh.
- c. Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu tất cả các sự kiện cần nghiên cứu (tình trạng phơi nhiễm và bệnh) đã xảy ra.
- d. Cả ba ý trên đều đúng

7. Trong nghiên cứu bệnh chứng, nhóm chủ cứu (nhóm bệnh) được lựa chọn là những người:

- a. Không tiếp xúc với yếu tố nguy cơ
- b. Có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ
- c. Có bệnh mà ta nghiên cứu
- d. Không có bệnh mà ta nghiên cứu

8. Trong nghiên cứu bệnh chứng, nhóm chứng được lựa chọn là những người:

- a. Không tiếp xúc với yếu tố nguy cơ
- b. Có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ
- c. Có bệnh mà ta nghiên cứu
- d. Không có bệnh mà ta nghiên cứu

9. Vấn đề quan trọng đầu tiên trong thiết kế nghiên cứu bệnh chứng là:

- a. Lựa chọn quần thể có phơi nhiễm
- b. Lựa chọn nhóm so sánh bên ngoài (không phơi nhiễm)
- c. Lựa chọn nhóm so sánh đặc biệt (có phơi nhiễm đặc biệt)
- d. Định nghĩa bệnh và lựa chọn nhóm bệnh

10. Khi lựa chọn nhóm bệnh ta phải:

- a. Định nghĩa bệnh hay hậu quả mà ta quan tâm
- b. Xác lập tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nghiêm ngặt
- c. Xác định rõ ràng nguồn lựa chọn nhóm bệnh
- d. Phải tiến hành cả ba bước trên

11. Các nguồn lựa chọn nhóm bệnh có thể là:

- a. Bệnh viện, quần thể
- b. Bệnh viện, quần thể và nhóm đặc biệt
- c. Bệnh viện và nhóm đặc biệt
- d. Quần thể và nhóm đặc biệt

12. Ưu điểm của việc lựa chọn nhóm bệnh từ bệnh viện:

- a. Tránh được sai số lựa chọn
- b. Dễ thực hiện, không tốn kém
- c. Có tính đại diện cao
- d. Mô tả được bức tranh toàn diện của bệnh trong quần thể.

13. Nhược điểm của việc lựa chọn nhóm bệnh từ quần thể:

- a. Tốn kém, khó thực hiện
- b. Gặp phải sai số lựa chọn
- c. Kết quả không có tính đại diện cho quần thể
- d. Không tính trực tiếp được tỷ lệ bệnh ở nhóm phơi nhiễm và không phơi nhiễm

14. Các nguồn lựa chọn nhóm chứng có thể là:

- a. Bệnh viện, quần thể
- b. Bệnh viện, quần thể và nhóm đặc biệt
- c. Bệnh viện và nhóm đặc biệt
- d. Quần thể và nhóm đặc biệt

15. Ưu điểm của việc lựa chọn nhóm chứng từ bệnh viện

- a. Đại diện cho sự phân bố phơi nhiễm của quần thể mà từ đó nhóm bệnh được chọn ra
- b. Phơi nhiễm giống như những người bình thường trong quần thể
- c. Dễ tập hợp đủ số lượng cần có, ít tốn kém
- d. Có cả ba ưu điểm trên

Nhược điểm của lựa chọn nhóm chứng từ bệnh viện

- a. Khó tập hợp nên thường tốn kém
- b. Không đại diện cho sự phân bố của quần thể mà từ đó nhóm bệnh được chọn ra
- c. Tăng nguy cơ gặp sai lệch hồi tưởng, sai lệch lựa chọn và sai lệch không đáp ứng
- d. Ít hợp tác tham gia nghiên cứu hơn so với nghiên cứu từ quần thể

16. Ưu điểm của việc lựa chọn nhóm chứng từ quần thể

- a. Ít tốn kém về kinh phí và thời gian hơn nghiên cứu từ bệnh viện
- b. Đảm bảo sự so sánh tốt nhất vì họ xuất phát từ cùng một dân số nguồn mà từ đó chọn nhóm bệnh
- c. Có động cơ hợp tác tham gia nghiên cứu hơn nghiên cứu từ bệnh viện
- d. Ít gặp sai sót nhớ lại hơn nghiên cứu từ bệnh viện

17. Lý tưởng nhất là có:

- a. Một nhóm chứng thích hợp với nhóm bệnh
- b. Hai nhóm chứng thích hợp với nhóm bệnh
- c. Ba nhóm chứng thích hợp với nhóm bệnh
- d. Bốn nhóm chứng thích hợp với nhóm bệnh

Một nhà nghiên cứu quan tâm tới sự liên quan giữa hút thuốc lá và ung thư phổi. Để nghiên cứu vấn đề này ông chọn 150 người đã được chẩn đoán là ung thư phổi được điều trị tại một số bệnh viện trong khu vực và 150 người không bị ung thư phổi ở khu vực đó tại cùng thời điểm đó. Sau đó ông khai thác tiền sử hút thuốc lá của 150 người này và thu được kết quả là trong 150 người bị ung thư phổi thì có 130 người có hút thuốc lá, còn trong 150 người không bị ung thư phổi thì có 110 người hút thuốc lá.

	Có ung thư phổi	Không ung thư phổi	Tổng
Có hút thuốc lá	130	100	230
Không hút thuốc lá	20	50	70
Tổng	150	150	300

18. Đây là ví dụ về:

- a. Nghiên cứu ngang mô tả.
- b. Nghiên cứu thuần tập
- c. Nghiên cứu bệnh chứng
- d. Nghiên cứu thực nghiệm

19. Từ kết quả trên ta không thể tính được:

- a. Nguy cơ tương đối (RR).
- b. Tỷ suất chênh (OR).

- c. Nguy cơ quy thuộc % (AR%)
- d. Nguy cơ quy thuộc quần thể % (PAR%)

20. Tỷ suất chênh được tính như sau:

- a. $OR = (130/230) : (20/70)$
- b. $OR = (130/20) : (100/50)$
- c. $OR = (130/150) : (100/150)$
- d. $OR = (20/130) : (50/100)$

21. Giả sử ta tính được $OR=2,5$, ta có thể kết luận là:

- a. Tỷ lệ những người hút thuốc lá trong số những người bị ung thư phổi cao gấp 2,5 lần so với những người không bị ung thư phổi.
- b. Tỷ lệ những người không hút thuốc lá trong nhóm không ung thư phổi cao gấp 2,5 lần so với nhóm ung thư phổi
- c. Nguy cơ bị ung thư phổi ở những người hút thuốc lá cao gấp 2,5 lần so với những người không hút thuốc lá
- d. Khả năng không ung thư phổi ở những người hút thuốc lá kém 2,5 lần so với những người không hút thuốc lá

22. Giả sử trong một nghiên cứu về mối liên quan giữa hút thuốc lá và ung thư phổi ta tính được nguy cơ quy thuộc phần trăm (AR%) là 60%, ta có thể kết luận là:

- a. 60% những người hút thuốc lá sẽ bị ung thư phổi và có thể giảm tỷ lệ ung thư phổi nếu ngừng hút thuốc lá.
- b. 60% những người bị ung thư phổi là do hút thuốc lá và có thể giảm được tỷ lệ ung thư phổi nếu ngừng hút thuốc lá.
- c. 60% những người ung thư phổi không phải là do hút thuốc lá, còn lại 40% những người bị ung thư phổi là do hút thuốc lá và có thể giảm được tỷ lệ ung thư phổi nếu ngừng hút thuốc lá.
- d. 60% những người không ung thư phổi là do không hút thuốc lá.

23. Trong nghiên cứu bệnh - chứng, loại sai số gặp phải khi những người đủ tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu nhưng không tình nguyện tham gia hay không được chọn vào nghiên cứu là:

- a. Sai lệch quan sát

- b. Sai lệch lựa chọn
- c. Sai lệch hồi tưởng
- d. Sai lệch phân loại

24. Trong nghiên cứu bệnh - chứng, loại sai lệch trong sự thu thập thông tin về tình trạng phơi nhiễm và bệnh là:

- a. Sai lệch quan sát
- b. Sai lệch lựa chọn
- c. Sai lệch hồi tưởng
- d. Sai lệch phân loại

25. Trong nghiên cứu bệnh - chứng, loại sai lệch trong việc phân loại sai tình trạng phơi nhiễm và bệnh là:

- a. Sai lệch quan sát
- b. Sai lệch lựa chọn
- c. Sai lệch hồi tưởng
- d. Sai lệch phân loại

26. Trong nghiên cứu bệnh - chứng, loại sai lệch về sự nhớ lại tần số phơi nhiễm ở hai nhóm bệnh và chứng:

- a. Sai lệch quan sát
- b. Sai lệch lựa chọn
- c. Sai lệch hồi tưởng
- d. Sai lệch phân loại

27. Ưu điểm của nghiên cứu bệnh - chứng là:

- a. Hiệu quả khi nghiên cứu các phơi nhiễm hiếm
- b. Thực hiện tương đối nhanh, ít tốn kém so với các nghiên cứu phân tích khác
- c. Có thể tính toán trực tiếp tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm phơi nhiễm và nhóm không phơi nhiễm
- d. Không gặp sai lệch lựa chọn

28. Ưu điểm của nghiên cứu bệnh - chứng là:

- a. Hiệu quả khi nghiên cứu các phơi nhiễm hiếm

- b. Không gặp sai lệch hồi tưởng
- c. Có thể tính toán trực tiếp tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm phơi nhiễm và nhóm không phơi nhiễm
- d. Đặc biệt thích hợp cho nghiên cứu những bệnh có thời kỳ ủ bệnh dài, tối ưu khi nghiên cứu các bệnh hiếm

29. Nhược điểm của nghiên cứu bệnh - chứng là:

- a. Nhạy cảm với các sai lệch đặc biệt sai lệch chọn và sai lệch hồi tưởng
- b. Thực hiện lâu, tốn kém so với các nghiên cứu phân tích khác
- c. Không thích hợp cho nghiên cứu những bệnh có thời kỳ ủ bệnh dài và nghiên cứu các bệnh hiếm
- d. Không thể điều tra ảnh hưởng của nhiều yếu tố căn nguyên.

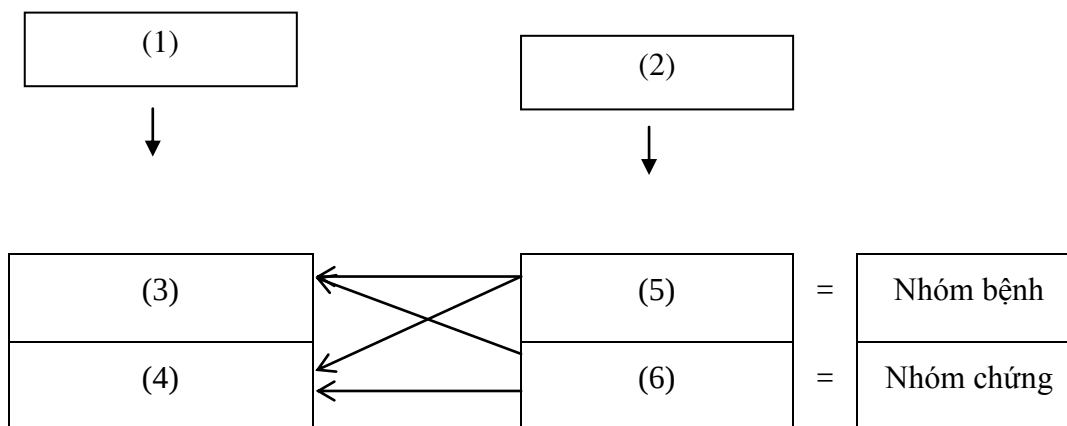
Đánh dấu vào cột Đ nếu câu trả lời là đúng và đánh dấu vào cột S nếu câu trả lời là sai:

	Đ	S
1. Nghiên cứu bệnh chứng là nghiên cứu dịch tễ học mô tả		
2. Nghiên cứu bệnh chứng là nghiên cứu phân tích		
3. Nghiên cứu bệnh chứng là nghiên cứu quan sát		
4. Nghiên cứu bệnh chứng là nghiên cứu tương lai		
5. Nghiên cứu bệnh chứng là nghiên cứu hồi cứu		
6. Trong nghiên cứu bệnh chứng, các nhóm nghiên cứu được lựa chọn trên cơ sở có bệnh hay không có bệnh ta cần nghiên cứu		
7. Trong nghiên cứu bệnh chứng, các nhóm nghiên cứu được lựa chọn trên cơ sở có phơi nhiễm hay không có phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ		
8. Trong nghiên cứu bệnh chứng, các nhóm nghiên cứu được so sánh về tiền sử tiếp xúc với yếu tố nguy cơ		
9. Trong nghiên cứu bệnh chứng, các nhóm nghiên cứu được theo dõi trong thời gian dài và so sánh về sự phát triển bệnh mà ta nghiên cứu		
10. Mục đích của nghiên cứu bệnh chứng là hình thành giả thuyết		
11. Mục đích của nghiên cứu bệnh chứng là kiểm định giả thuyết		

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

1. Nghiên cứu bệnh chứng là một nghiên cứu dịch tễ học(1).....(2)
trong đó đối tượng nghiên cứu được chọn trên cơ sở có bệnh hoặc không có
..... (3). Các nhóm này được so sánh về(4) với một
yếu tố hay một đặc trưng có thể là căn nguyên của bệnh
2. Liệt kê các bước trong thiết kế và thực hiện nghiên cứu bệnh chứng:
 - a.
 - b.
 - c.

3. Điền các từ thích hợp còn trống vào sơ đồ thiết kế nghiên cứu bệnh chứng sau



4. Liệt kê bốn loại sai số thường gặp trong nghiên cứu bệnh chứng

-
-
-
-

5. Liệt kê bốn ưu điểm chính của nghiên cứu bệnh chứng

- Thực hiện tương đối, ít tốn kém so với các nghiên cứu phân tích khác
- Đặc biệt thích hợp cho nghiên cứu những
- Tối ưu khi nghiên cứu các bệnh
- Có khả năng điều tra ảnh hưởng của nhiều yếu tố Khởi đầu cho việc xác định các yếu tố nguyên nhân của bệnh còn chưa rõ

6. Liệt kê ba nhược điểm chính của nghiên cứu bệnh chứng

- Không hiệu quả khi nghiên cứu các
- Không thể tính toán trực tiếp ở nhóm phơi nhiễm và nhóm không phơi nhiễm trừ khi nghiên cứu trên quần thể
- Nhạy cảm với (1).....đặc biệt (2)..... và (3).....

Phương pháp nghiên cứu thuần tập

Chọn câu trả lời đúng nhất:

1. Nghiên cứu thuần tập là:
 - a. Nghiên cứu quan sát
 - b. Nghiên cứu thực nghiệm.
 - c. Nghiên cứu cắt ngang.
 - d. Nghiên cứu ca bệnh.
2. Nghiên cứu thuần tập là:
 - a. Nghiên cứu mô tả.
 - b. Nghiên cứu phân tích
 - c. Nghiên cứu thực nghiệm
 - d. Nghiên cứu cắt ngang
3. Trong nghiên cứu thuần tập, các đối tượng nghiên cứu được xác định dựa trên.
 - a. Tình trạng bệnh
 - b. Tình trạng phơi nhiễm
 - c. Tình trạng bệnh hoặc phơi nhiễm đều được.
 - d. Chọn ngẫu nhiên bất kỳ
4. Nghiên cứu thuần tập là nghiên cứu mà:
 - a. Nhà nghiên cứu không chỉ định tình trạng phơi nhiễm của các đối tượng nghiên cứu, họ chỉ quan sát và ghi nhận lại.
 - b. Nhà nghiên cứu chỉ định tình trạng phơi nhiễm của các đối tượng nghiên cứu.
 - c. Các đối tượng nghiên cứu được áp dụng một loại thuốc điều trị mới
 - d. Các đối tượng nghiên cứu được can thiệp một phương pháp điều trị nào đó.
5. Trong nghiên cứu thuần tập, các nhóm nghiên cứu được
 - a. So sánh hiệu quả của phương pháp điều trị mới với phương pháp điều trị cũ
 - b. Khai thác và so sánh tiền sử tiếp xúc với yếu tố nguy cơ.
 - c. So sánh tỷ lệ hiện mắc giữa nhóm phơi nhiễm và không phơi nhiễm
 - d. Theo dõi sự phát triển bệnh trong một thời gian dài
6. Nghiên cứu thuần tập là nghiên cứu:
 - a. Cung cấp hình ảnh chụp nhanh về tình trạng sức khỏe cộng đồng và các yếu tố liên quan

- b. Chủ yếu hình thành giả thuyết
 - c. Kiểm định giả thuyết đã được đặt ra trước đó.
 - d. Hình thành và kiểm định giả thuyết.
7. Nghiên cứu thuần tập mà tất cả các sự kiện cần nghiên cứu (tình trạng phơi nhiễm và bệnh) đã xảy ra tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu là:
- a. Nghiên cứu thuần tập tương lai
 - b. Nghiên cứu thuần tập hồi cứu
 - c. Nghiên cứu thuần tập vừa hồi cứu, vừa tương lai
 - d. Nghiên cứu thuần tập lồng nghiên cứu bệnh chứng
8. Nghiên cứu thuần tập mà tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu các cá thể nghiên cứu đã có phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ nhưng chưa xuất hiện bệnh và được theo dõi một thời gian dài trong tương lai là:
- a. Nghiên cứu thuần tập tương lai
 - b. Nghiên cứu thuần tập hồi cứu
 - c. Nghiên cứu thuần tập vừa hồi cứu, vừa tương lai
 - d. Nghiên cứu thuần tập lồng nghiên cứu bệnh chứng
9. Một ví dụ nghiên cứu thuần tập về ảnh hưởng có hại của chất độc màu da cam trên những phi công Mỹ tham gia chiến tranh ở Việt Nam . Nhóm phơi nhiễm gồm 1264 phi công Mỹ có liên quan đến việc rải chất độc này ở Việt Nam trong thời gian 1962-1967. Nhóm không phơi nhiễm gồm 1264 phi công làm nhiệm vụ vận chuyển hàng đến vùng Đông Nam á cùng thời gian này. Những số liệu được phân tích hồi cứu so sánh ở hai nhóm về hậu quả phơi nhiễm sau một thời gian ngắn như: các bệnh ngoài da, quái thai, thay đổi chức năng gan, rối loạn tâm thần. Các nhóm này cũng được theo dõi tương lai trong một thời gian dài hậu quả phát triển các bệnh ác tính. Đây là một ví dụ về:
- a. Nghiên cứu thuần tập tương lai
 - b. Nghiên cứu thuần tập hồi cứu
 - c. Nghiên cứu thuần tập vừa hồi cứu, vừa tương lai
 - d. Nghiên cứu thuần tập lồng nghiên cứu bệnh chứng
10. Trong nghiên cứu thuần tập, nhóm chủ cứu được lựa chọn là những người:

- a. Không tiếp xúc với yếu tố nguy cơ
- b. Có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ
- c. Có bệnh mà ta nghiên cứu
- d. Không có bệnh mà ta nghiên cứu

11. Trong nghiên cứu thuần tập, nhóm so sánh được lựa chọn là những người:

- a. Không tiếp xúc với yếu tố nguy cơ
- b. Có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ
- c. Có bệnh mà ta nghiên cứu
- d. Không có bệnh mà ta nghiên cứu

12. Trong nghiên cứu thuần tập, nhóm phơi nhiễm có thể được lựa chọn từ

- a. Quần thể tổng quát
- b. Quần thể đặc biệt
- c. Từ bệnh viện và quần thể tổng quát
- d. Quần thể tổng quát và quần thể đặc biệt

13. Đối với các phơi nhiễm tương đối phổ biến như hút thuốc lá, uống cà phê thì ta có thể chọn nhóm chủ cứu từ:

- a. Quần thể tổng quát
- b. Quần thể đặc biệt
- c. Từ bệnh viện và quần thể tổng quát
- d. Quần thể tổng quát và quần thể đặc biệt

14. Với các phơi nhiễm hiếm như yếu tố phơi nhiễm nghề nghiệp thì ta có thể chọn đối tượng phơi nhiễm từ:

- a. Quần thể tổng quát
- b. Quần thể đặc biệt
- c. Từ bệnh viện và quần thể tổng quát
- d. Quần thể tổng quát và quần thể đặc biệt

15. Nếu nghiên cứu thuần tập dựa trên một nhóm thuần tập tổng quát và các cá thể được chia thành các mức độ phơi nhiễm khác nhau; độ mạnh của kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh được xác lập theo mức độ phơi nhiễm thì người ta áp dụng nhóm so sánh đó là:

- a. Nhóm so sánh bên ngoài
- b. Nhóm so sánh bên trong
- c. Nhóm so sánh đặc biệt
- d. Nhiều nhóm so sánh

16. Khi nghiên cứu thuần tập có sử dụng nhóm có phơi nhiễm đặc biệt như nhóm nghề nghiệp, nhóm người sống trong một môi trường đặc biệt, người ta không thể xác định một nhóm so sánh mà hoàn toàn không có phơi nhiễm, khi đó người ta có thể áp dụng nhóm so sánh như là quần thể tổng quát ở vùng mà nhóm phơi nhiễm sống, đó là:

- a. Nhóm so sánh bên ngoài
- b. Nhóm so sánh bên trong
- c. Nhóm so sánh đặc biệt
- d. Nhiều nhóm so sánh

Trong một nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc uống tránh thai và nhiễm khuẩn tiết niệu ở phụ nữ 16-49 tuổi, một nghiên cứu được tiến hành trên 2390 phụ nữ trong độ tuổi này. Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu có 482 phụ nữ có sử dụng thuốc tránh thai và 1908 phụ nữ không sử dụng thuốc tránh thai và chưa có ai mắc bệnh. Người ta tiến hành theo dõi các phụ nữ này trong một thời gian và thấy có 27 trong số 482 phụ nữ có sử dụng thuốc tránh thai và 77 trong số 1908 phụ nữ không sử dụng thuốc tránh thai bị nhiễm khuẩn tiết niệu. Kết quả nghiên cứu được trình bày như trong bảng sau:

	Có bệnh	Không bệnh	Tổng
Uống thuốc tránh thai	27	455	482
Không uống thuốc tránh thai	77	1831	1908
Tổng	104	2286	2390

17. Đây là một ví dụ về
- a. Nghiên cứu ngang
 - b. Nghiên cứu bệnh chứng
 - c. Nghiên cứu thuần tập
 - d. Nghiên cứu thực nghiệm

18. Từ kết quả trên ta có thể tính được:

- a. Tỷ suất chênh (OR)
- b. Nguy cơ tương đối (RR)
- c. Tỷ lệ mật độ mới mắc.
- d. Cả ba số đo trên

19. Nếu tính được nguy cơ tương đối từ số liệu trên thì nguy cơ tương đối có thể được tính là:

- a. (27/77): (455/1831)
- b. (27/482) : (77/1908)
- c. (455/428) : (1831/1908)
- d. (27/104) : (455/2286)

20. Giả sử tính được $RR=1,4$; ta có thể nhận xét rằng:

- a. Nguy cơ bị nhiễm khuẩn tiết niệu ở những phụ nữ có sử dụng thuốc tránh thai cao gấp 1,4 lần so với các phụ nữ không sử dụng thuốc tránh thai.
- b. Nguy cơ không bị nhiễm khuẩn tiết niệu ở những phụ nữ không sử dụng thuốc tránh thai cao gấp 1,4 lần so với các phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai.
- c. Tỷ lệ phụ nữ uống thuốc tránh thai trong nhóm nhiễm khuẩn tiết niệu cao gấp 1,4 lần so với nhóm không nhiễm khuẩn tiết niệu
- d. Tỷ lệ phụ nữ bị nhiễm khuẩn tiết niệu cao gấp 1,4 lần tỷ lệ phụ nữ không bị nhiễm khuẩn tiết niệu.

21. Yếu tố không phải là ưu điểm của nghiên cứu thuần tập:

- a. Rất có giá trị trong và tối ưu khi nghiên ảnh hưởng của các phơi nhiễm hiếm gặp
- b. Hiệu quả với nghiên cứu các bệnh hiếm gặp
- c. Có thể kiểm định ảnh hưởng nhiều mặt của một phơi nhiễm đến sự phát triển nhiều bệnh
- d. Có thể xác định khoảng thời gian phơi nhiễm và bệnh

22. Yếu tố không phải là ưu điểm của nghiên cứu thuần tập:

- a. Có thể kiểm định ảnh hưởng nhiều mặt của một phơi nhiễm đến sự phát triển nhiều bệnh
- b. Hạn chế được sai số hệ thống với ng/cứu thuần tập tương lai
- c. Tính toán trực tiếp tỷ lệ mới mắc ở hai nhóm

d. Ít tốn kém về kinh tế và thời gian.

23. Yếu tố không phải là nhược điểm của nghiên cứu thuần tập:

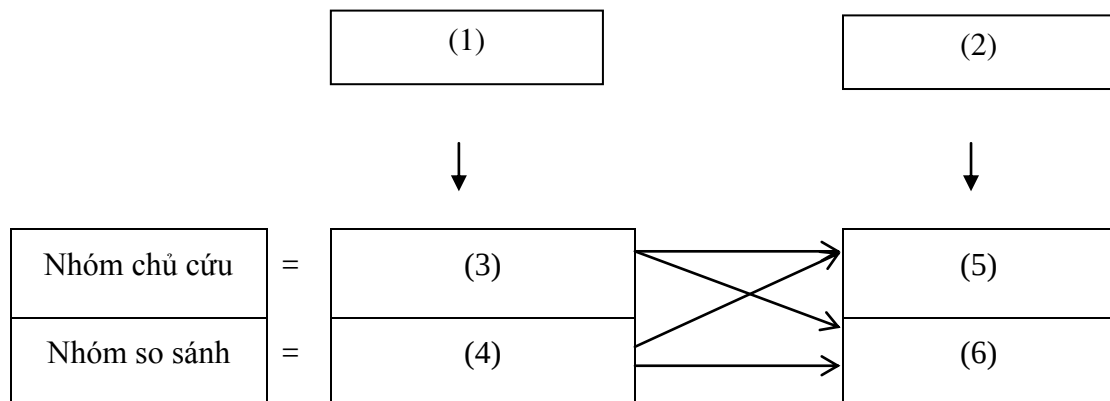
- a. Tốn kém về kinh tế và thời gian đặc biệt với nghiên cứu thuần tập tương lai
- b. Không có hiệu quả với nghiên cứu các bệnh hiếm gặp
- c. Không có hiệu quả khi nghiên cứu ảnh hưởng của các phơi nhiễm hiếm gặp
- d. Giá trị của kết quả nghiên cứu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất các đối tượng nghiên cứu

Đánh dấu vào cột Đ nếu câu trả lời là đúng và đánh dấu vào cột S nếu câu trả lời là sai:

	Đ	S
1. Nghiên cứu thuần tập là nghiên cứu dịch tễ học mô tả		
2. Nghiên cứu thuần tập là nghiên cứu phân tích		
3. Nghiên cứu thuần tập là nghiên cứu quan sát		
4. Các nhóm nghiên cứu được lựa chọn trên cơ sở có phơi nhiễm hay không có phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ		
5. Trong nghiên cứu thuần tập, các nhóm nghiên cứu được so sánh về sự phát triển bệnh mà ta nghiên cứu		
6. Thực tế là không có nhóm so sánh nào là tối ưu, đặc biệt khi không có một nhóm so sánh nào có đủ những đặc trưng giống nhau so với nhóm có phơi nhiễm thì việc sử dụng nhiều nhóm so sánh rất có ích.		
7. Nguyên tắc chủ yếu của việc lựa chọn nhóm so sánh là nhóm so sánh được lựa chọn phải giống nhóm có phơi nhiễm ở tất cả các yếu tố khác có thể liên quan đến bệnh trừ yếu tố phơi nhiễm nghiên cứu.		
8. Việc sử dụng nhóm so sánh bên ngoài có thể kiểm soát được yếu tố nhiễu từ quần thể tổng quát		
9. Ưu điểm của việc sử dụng nguồn thông tin về phơi nhiễm từ hồ sơ có từ trước là ít tốn kém, đáng tin cậy, khách quan, không gặp phải sai số hệ thống về tình trạng phơi nhiễm		
10. Để có được thông tin thích hợp về phơi nhiễm trong nghiên cứu thuần tập người ta thường có phải sử dụng phối hợp nhiều thông tin		

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

1. Nghiên cứu thuần tập (cohort studies) hay còn gọi là nghiên cứu theo dõi (follow up studies) là loại nghiên cứu(1) trong đó một hay nhiều nhóm cá thể được chọn trên cơ sở là có(2) hay không(3) Tại thời điểm nghiên cứu tình trạng phơi nhiễm được xác định, tất cả các đối tượng nghiên cứu mà..... (4)ta nghiên cứu và được theo dõi trong một thời gian để đánh giá sự xuất hiện bệnh đó.
2. Liệt kê các bước trong thiết kế và thực hiện nghiên cứu thuần tập:
 - d.
 - e.
 - f.
3. Điền các từ thích hợp còn trống vào sơ đồ thiết kế nghiên cứu thuần tập sau



4. Liệt kê các nguồn thông tin về bệnh:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Phương pháp nghiên cứu can thiệp

Chọn câu trả lời đúng nhất:

1. Nghiên cứu can thiệp là thiết kế :
 - a. Nghiên cứu quan sát
 - b. Nghiên cứu cắt ngang.
 - c. Nghiên cứu hồi cứu.
 - d. Nghiên cứu thực nghiệm.

2. Nghiên cứu can thiệp là thiết kế :
 - a. Nghiên cứu tương lai.
 - b. Nghiên cứu quan sát
 - c. Nghiên cứu cắt ngang.
 - d. Nghiên cứu hồi cứu.

3. Trong nghiên cứu can thiệp, các đối tượng nghiên cứu được xác định dựa trên.
 - a. Tình trạng bệnh
 - b. Tình trạng phơi nhiễm
 - c. Tình trạng bệnh hoặc phơi nhiễm đều được.
 - d. Chọn ngẫu nhiên bất kỳ

4. Thông thường, nghiên cứu can thiệp là nghiên cứu:
 - a. Tình trạng phơi nhiễm của các đối tượng nghiên cứu xảy ra tự nhiên, người nghiên cứu chỉ quan sát và ghi nhận lại.
 - b. Tình trạng phơi nhiễm của các đối tượng nghiên cứu do chính họ lựa chọn.
 - c. Tình trạng phơi nhiễm của các đối tượng nghiên cứu do người nghiên cứu chỉ định.
 - d. Cả ba tình huống trên đều được.

5. Thử nghiệm lâm sàng là:
 - a. Thử nghiệm được áp dụng ở những bệnh nhân bị một bệnh nào đó để xác định khả năng giảm bớt triệu chứng, giảm nguy cơ chết vì bệnh đó của một loại thuốc hay một phương pháp điều trị
 - b. Thử nghiệm để đánh giá tác dụng của thuốc trên một phạm vi lớn

- c. Điều trị ban đầu ảnh hưởng lâm sàng của thuốc điều trị
 - d. Thử nghiệm nhằm đánh giá tác dụng của một tác nhân hay một phương pháp làm giảm nguy cơ phát triển bệnh ở những người khỏe mạnh có nguy cơ mắc bệnh
6. Thử nghiệm phòng bệnh là:
- a. Thử nghiệm được áp dụng ở những bệnh nhân bị một bệnh nào đó để xác định khả năng giảm bớt triệu chứng, giảm nguy cơ chết vì bệnh đó của một loại thuốc hay một phương pháp điều trị.
 - b. Thử nghiệm để đánh giá tác dụng của thuốc trên một phạm vi lớn.
 - c. Điều trị ban đầu ảnh hưởng lâm sàng của thuốc điều trị.
 - d. Thử nghiệm nhằm đánh giá tác dụng của một tác nhân hay một phương pháp làm giảm nguy cơ phát triển bệnh ở những người khỏe mạnh có nguy cơ mắc bệnh
7. Trong thử nghiệm thuốc điều trị, giai đoạn nghiên cứu tính an toàn chứ không phải tính hiệu quả của thuốc và sau đó xác định liều sử dụng thích hợp là giai đoạn:
- a. Điều trị ban đầu ảnh hưởng lâm sàng của thuốc điều trị.
 - b. Dược lý lâm sàng và độc tính.
 - c. Giám sát thuốc trên thị trường.
 - d. Đánh giá tác dụng của thuốc trên phạm vi lớn.
8. Giai đoạn điều tra trên một phạm vi nhỏ hiệu quả và sự an toàn của thuốc là giai đoạn:
- a. Điều trị ban đầu ảnh hưởng lâm sàng của thuốc điều trị.
 - b. Dược lý lâm sàng và độc tính.
 - c. Giám sát thuốc trên thị trường.
 - d. Đánh giá tác dụng của thuốc trên phạm vi lớn.
9. Giai đoạn điều xác định tính hiệu quả của thuốc, so sánh với các phương pháp khác hiện đang áp dụng đối với cùng một bệnh trên một số lớn bệnh nhân là giai đoạn:
- a. Điều trị ban đầu ảnh hưởng lâm sàng của thuốc điều trị.
 - b. Dược lý lâm sàng và độc tính.
 - c. Giám sát thuốc trên thị trường.
 - d. Đánh giá tác dụng của thuốc trên phạm vi lớn.

10. Giai đoạn nhằm giám sát các ảnh hưởng phụ của thuốc, các nghiên cứu bổ sung lâu dài trên phạm vi lớn về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong và sự quan tâm chú ý sử dụng thuốc của các thầy thuốc đang điều trị là giai đoạn:
- Điều trị ban đầu ảnh hưởng lâm sàng của thuốc điều trị.
 - Dược lý lâm sàng và độc tính.
 - Giám sát thuốc trên thị trường.
 - Đánh giá tác dụng của thuốc trên phạm vi lớn.
11. Giai đoạn thực chất đồng nghĩa với khái niệm “thử nghiệm lâm sàng” là giai đoạn:
- Điều trị ban đầu ảnh hưởng lâm sàng của thuốc điều trị.
 - Dược lý lâm sàng và độc tính.
 - Giám sát thuốc trên thị trường.
 - Đánh giá tác dụng của thuốc trên phạm vi lớn.
12. Cỡ mẫu nghiên cứu phù hợp cho giai đoạn dược lý lâm sàng và độc tính là:
- 10-20 người
 - 20-80 người
 - 100-200 người
 - Trên 200 người
13. Cỡ mẫu nghiên cứu phù hợp cho giai đoạn điều trị ban đầu ảnh hưởng lâm sàng của thuốc điều trị là:
- 10-20 người
 - 20-80 người
 - 100-200 người
 - Trên 200 người
14. Thử nghiệm lâm sàng thường được áp dụng ở:
- Các cá thể.
 - Các nhóm cá thể đặc biệt.
 - Toàn bộ quần thể.
 - Các cá thể hoặc toàn bộ quần thể.
15. Thử nghiệm phòng bệnh thường được áp dụng ở:

- a. Các cá thể.
- b. Các nhóm cá thể đặc biệt.
- c. Toàn bộ quần thể.
- d. Các cá thể hoặc toàn bộ quần thể.

16. Các yêu cầu khi lựa chọn quần thể nghiên cứu:

- a. Phải có đủ số người phát triển bệnh hay một hậu quả mà ta nghiên cứu để cho phép so sánh có ý nghĩa giữa các phương pháp điều trị khác nhau trong một khoảng thời gian hợp lý
- b. Phải đảm bảo khả năng thu thập được thông tin theo dõi đầy đủ và chính xác trong thời gian nghiên cứu.
- c. Các đối tượng phải được mời tham gia vào nghiên cứu sau khi được thông báo đầy đủ về mục tiêu của thử nghiệm, qui trình thử nghiệm, lợi ích và nguy cơ có thể xảy ra
- d. Cả ba yêu cầu trên

17. Quần thể nghiên cứu là:

- a. Những người đủ tiêu chuẩn đề ra.
- b. Những người tham gia nghiên cứu
- c. Những người tham gia nghiên cứu và đủ tiêu chuẩn đề ra.
- d. Quần thể thực nghiệm.

18. Việc liệu những người tham gia nghiên cứu có đại diện cho toàn thể quần thể thực nghiệm hay không sẽ:

- a. không ảnh hưởng đến tính giá trị của kết quả, nhưng có thể ảnh hưởng đến khả năng khái quát hóa kết quả cho nhóm quần thể thực nghiệm hay quần thể có liên quan
- b. có ảnh hưởng đến tính giá trị của kết quả, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng khái quát hóa kết quả cho nhóm quần thể thực nghiệm hay quần thể có liên quan
- c. không ảnh hưởng đến tính giá trị của kết quả và không ảnh hưởng đến khả năng khái quát hóa kết quả cho nhóm quần thể thực nghiệm hay quần thể có liên quan
- d. Có ảnh hưởng đến tính giá trị của kết quả và có thể ảnh hưởng đến khả năng khái quát hóa kết quả cho nhóm quần thể thực nghiệm hay quần thể có liên quan

19. Lưu ý trong việc chỉ định các nhóm điều trị khác nhau:

- a. tiến hành ngẫu nhiên để tăng khả năng so sánh các nhóm nhận các can thiệp khác nhau

- b. chỉ được tiến hành sau khi các đối tượng nghiên cứu được xác định là đủ tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu.
- c. chỉ được tiến hành sau khi các đối tượng nghiên cứu được xác định là đủ tiêu chuẩn và tình nguyện tham gia nghiên cứu.
- d. (a) và (c) đúng

20. Ưu điểm của chỉ định ngẫu nhiên trong thử nghiệm lâm sàng là:

- a. Loại trừ được các sai lệch do chỉ định nhóm điều trị và sự khác nhau quan sát được không phải là do lựa chọn bệnh nhân nhận một can thiệp nào đó.
- b. Các nhóm nghiên cứu có thể so sánh được nhiều biến số trừ can thiệp nghiên cứu.
- c. Cỡ mẫu nghiên cứu càng lớn, quá trình lấy ngẫu nhiên và phân bố như nhau các yếu tố gây nhiễu biết rõ và chưa biết rõ ở các nhóm điều trị càng đạt được kết quả.
- d. Cả ba ưu điểm trên

21. Biện pháp làm “mù đơn” là:

- a. Chỉ có người trực tiếp điều trị và theo dõi và người xử lý và phân tích số liệu biết được tình trạng can thiệp.
- b. Chỉ có đối tượng nghiên cứu biết được tình trạng can thiệp.
- c. Chỉ có người xử lý và phân tích số liệu biết được tình trạng can thiệp.
- d. Chỉ có người trực tiếp điều trị và theo dõi biết được tình trạng can thiệp.

22. Biện pháp làm “mù kép” là:

- a. Chỉ có người trực tiếp điều trị và theo dõi biết được tình trạng can thiệp.
- b. Chỉ có đối tượng nghiên cứu biết được tình trạng can thiệp.
- c. Chỉ có người xử lý và phân tích số liệu biết được tình trạng can thiệp.
- d. Không ai trong ba đối tượng trên biết được tình trạng can thiệp.

23. Biện pháp làm “mù ba” là:

- a. Chỉ có người trực tiếp điều trị và theo dõi biết được tình trạng can thiệp.
- b. Chỉ có đối tượng nghiên cứu biết được tình trạng can thiệp.
- c. Chỉ có người xử lý và phân tích số liệu biết được tình trạng can thiệp.
- d. Không ai trong ba đối tượng trên biết được tình trạng can thiệp.

24. Để loại trừ yếu tố may rủi trong nghiên cứu can thiệp cần:

- a. Xác định cỡ mẫu đủ lớn.
- b. Chọn mẫu ngẫu nhiên
- c. Áp dụng biện pháp làm mù
- d. Không loại trừ khỏi phân tích các đối tượng không đủ tiêu chuẩn hay không tuân thủ chế độ nghiên cứu sau khi được chọn ngẫu nhiên

25. Để loại trừ sai số hệ thống trong nghiên cứu can thiệp cần:

- a. Chọn mẫu ngẫu nhiên
- b. Áp dụng biện pháp làm mù
- c. Không loại trừ khỏi phân tích các đối tượng không đủ tiêu chuẩn hay không tuân thủ chế độ nghiên cứu sau khi được chọn ngẫu nhiên
- d. Cả ba biện pháp trên

26. Ưu điểm của nghiên cứu can thiệp là:

- a. Cho phép chứng minh giả thuyết về mối liên quan giữa bệnh và yếu tố nguy cơ cần nghiên cứu.
- b. Không nhất thiết số lượng bệnh nhân phải ổn định
- c. Kết quả nghiên cứu không bị ảnh hưởng bởi sự tuân thủ chế độ can thiệp của đối tượng nghiên cứu
- d. Cả ba ưu điểm trên

Đánh dấu vào cột Đ nếu câu trả lời là đúng và đánh dấu vào cột S nếu câu trả lời là sai:

	Đ	S
1. Để làm tăng sự tuân thủ của các đối tượng nghiên cứu trong thử nghiệm lâm sàng, người nghiên cứu phải thường xuyên tiếp xúc với đối tượng nghiên cứu ở nhà hay ở bệnh viện.		
2. Việc sử dụng các gói thuốc có ghi lịch có thể làm tăng sự tuân thủ của các đối tượng nghiên cứu trong thử nghiệm lâm sàng.		
3. Thiết kế giai thừa có khả năng trả lời hai hay nhiều câu hỏi ở trong cùng một thử nghiệm mà giá thành lại không cao.		
4. Thiết kế giai thừa không cho phép kiểm định một giả thuyết chưa chín muồi mà ta đã có những bằng chứng đáng tin cậy để chứng minh.		
5. Không cần thiết phải duy trì sự tuân thủ cao chế độ nghiên cứu ở tất cả		

những người tham gia nghiên cứu		
6. Để duy trì mức độ tuân thủ cao, cần phải theo dõi các đối tượng nghiên cứu ở mức cao nhất và thu thập thông tin của tất cả những người đã được chọn ngẫu nhiên		
7. Về mặt thực hành, không nên thực hiện những thử nghiệm mà chế độ nghiên cứu quá phức tạp và không thuận tiện cho dù điều trị có hiệu quả đến đâu đi chăng nữa		

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

1. Nghiên cứu can thiệp là một trong những nghiên cứu
2. Nghiên cứu can thiệp có thể được coi là nghiên cứu vì các đối tượng nghiên cứu được xác định dựa trên tình trạng phơi nhiễm sau đó theo dõi sự phát triển bệnh của họ.
3. Khác với nghiên cứu thuần tập, trong nghiên cứu can thiệp, tình trạng phơi nhiễm của các đối tượng nghiên cứu là do
4. Nghiên cứu can thiệp được coi là phương pháp nghiên cứu dịch tễ học cung cấp bằng chứng đáng tin cậy và có giá trị nhất về
5. Hai loại nghiên cứu can thiệp là:
 - a.
 - b.
6. Hai loại thử nghiệm lâm sàng là:
 - a.
 - b.
7. Thử nghiệm thuốc điều trị trong công nghiệp dược phẩm thường được chia làm 4 giai đoạn:
 - a. Giai đoạn 1:
 - b. Giai đoạn 2:
 - c. Giai đoạn 3:
 - d. Giai đoạn 4:

8. Mức độ không tuân thủ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng phụ thuộc vào(1) nghiên cứu và.....(2) của qui trình nghiên cứu.
9. Biện pháp có nghĩa là cố gắng đến mức tối đa không cho đối tượng nghiên cứu hoặc người điều tra biết được tình trạng can thiệp cho đến khi số liệu được thu thập đầy đủ
10. Các sai số có thể gặp trong nghiên cứu can thiệp
 - a.
 - b.
 - c.

Các sai số trong nghiên cứu dịch tễ học, xác định mối quan hệ nhân quả

Chọn câu trả lời đúng nhất:

1. Sai số ngẫu nhiên là sai số:

- a. Do các yếu tố nhiễu gây ra.
- b. Nảy sinh khi có vai trò của các yếu tố may rủi xen vào kết quả nghiên cứu.
- c. Nảy sinh khi chọn không đúng các cá thể vào trong nghiên cứu theo mẫu
- d. Bao gồm bất kỳ sai lầm nào có tính chất hệ thống trong nghiên cứu, trong bất kỳ bước tiến hành nghiên cứu nào.

2. Sai số hệ thống là sai số:

- a. Do các yếu tố nhiễu gây ra.
- b. Nảy sinh khi có vai trò của các yếu tố may rủi xen vào kết quả nghiên cứu.
- c. Nảy sinh khi chọn không đúng các cá thể vào trong nghiên cứu theo mẫu
- d. Bao gồm bất kỳ sai lầm nào có tính chất hệ thống trong nghiên cứu, trong bất kỳ bước tiến hành nghiên cứu nào.

3. Sai số do nhiễu là sai số

- a. Do các yếu tố nhiễu gây ra.
- b. Nảy sinh khi có vai trò của các yếu tố may rủi xen vào kết quả nghiên cứu.
- c. Nảy sinh khi chọn không đúng các cá thể vào trong nghiên cứu theo mẫu
- d. Bao gồm bất kỳ sai lầm nào có tính chất hệ thống trong nghiên cứu, trong bất kỳ bước tiến hành nghiên cứu nào.

4. Các yếu tố liên quan tới sai số ngẫu nhiên là:

- a. Tính biến thiên của mẫu và cỡ mẫu
- b. Phương tiện nghiên cứu không chính xác
- c. Người nghiên cứu chưa được huấn luyện đầy đủ
- d. Không xác định rõ ràng các tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu

5. Các sai số hệ thống bao gồm:

- a. Các sai số không thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu

- b. Các sai số có thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu; nếu vẫn tồn tại có thể chỉnh được vào lúc tiến hành phân tích sau này.
- c. Các sai số có thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu nhưng không thể chỉnh lý được khi phân tích
- d. Các sai số có thể tránh được từ lúc thiết kế, có thể chỉnh lý được hoặc không thể chỉnh lý được vào lúc tiến hành phân tích sau này

6. Trong các sai số hệ thống, sai số vi phạm là sai số:

- a. Các sai số không thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu và không thể chỉnh lý được khi phân tích.
- b. Các sai số không thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu và có thể chỉnh được vào lúc tiến hành phân tích sau này.
- c. Các sai số có thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu; nếu vẫn tồn tại có thể chỉnh được vào lúc tiến hành phân tích sau này.
- d. Các sai số có thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu nhưng không thể chỉnh lý được khi phân tích

7. Sai số chọn là sai số:

- a. Các sai số không thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu và không thể chỉnh lý được khi phân tích.
- b. Các sai số không thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu và có thể chỉnh được vào lúc tiến hành phân tích sau này.
- c. Các sai số có thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu; nếu vẫn tồn tại có thể chỉnh được vào lúc tiến hành phân tích sau này.
- d. Các sai số có thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu nhưng không thể chỉnh lý được khi phân tích

8. Sai số thông tin (sai số quan sát) là sai số:

- a. Các sai số không thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu và không thể chỉnh lý được khi phân tích.
- b. Các sai số không thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu và có thể chỉnh được vào lúc tiến hành phân tích sau này.
- c. Các sai số có thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu; nếu vẫn tồn tại có thể chỉnh được vào lúc tiến hành phân tích sau này.
- d. Các sai số có thể tránh được từ lúc thiết kế, xây dựng qui trình nghiên cứu nhưng không thể chỉnh lý được khi phân tích

9. Các ví dụ về tính tuổi sai hoặc huyết áp thiết kế không chuẩn hóa là một ví dụ về:

- a. Sai số chọn
- b. Sai số điều tra
- c. Sai số xếp lần thông tin
- d. Sai số vi phạm

10. Sai số chọn là sai số nảy sinh:

- a. Do chất lượng dữ liệu có sẵn không so sánh được
- b. Do trí nhớ của các cá thể trong nghiên cứu chính xác khác nhau về sự kiện nghiên cứu
- c. Khi chọn không đúng các cá thể vào trong các nhóm nghiên cứu theo mẫu do không xác định rõ ràng các tiêu chuẩn chọn hoặc không tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn này
- d. Do hiểu biết về bệnh làm sai lệch lịch sử phơi nhiễm trước đây của những người dự cuộc

11. Sai số thường do các thầy thuốc hoặc các điều tra viên gây ra khi họ được biết về mối quan hệ nhân quả cần nghiên cứu là:

- a. Sai số sống sót chọn lọc
- b. Sai số chẩn đoán
- c. Sai số từ chối hoặc không trả lời
- d. Sai số nhập viện

12. Sai số khi các nghiên cứu được tiến hành ở bệnh viện (thường những người có phơi nhiễm hoặc các trường hợp bệnh nặng dễ dàng được thu nhận vào bệnh viện hơn) là:

- a. Sai số sống sót chọn lọc
- b. Sai số chẩn đoán
- c. Sai số từ chối hoặc không trả lời
- d. Sai số nhập viện

13. Sai số khi tiến hành các nghiên cứu bệnh có tỷ lệ tử vong cao, do chỉ quan sát kết hợp giữa những người còn sống sót, mà không chú ý đến những người đã chết với cùng một phơi nhiễm là:

- a. Sai số sống sót chọn lọc
- b. Sai số chẩn đoán
- c. Sai số từ chối hoặc không trả lời
- d. Sai số nhập viện

14. Sai số nảy sinh khi có sự chênh lệch về tỷ lệ trả lời giữa nhóm chủ cứu và nhóm chứng là loại sai số

- a. Sai số sống sót chọn lọc
- b. Sai số chẩn đoán
- c. Sai số từ chối hoặc không trả lời
- d. Sai số nhập viện

15. Sai số nảy sinh do trí nhớ của các cá thể trong nghiên cứu chính xác khác nhau về sự kiện nghiên cứu hoặc nhận thức của họ khác nhau giữa những người có mắc và không mắc bệnh là loại:

- a. Sai số điều tra
- b. Sai số nhớ lại
- c. Sai số xếp lần thông tin
- d. Sai số do chất lượng dữ liệu có sẵn không so sánh được

16. Sai số do những hiểu biết về bệnh làm sai lệch lịch sử phơi nhiễm trước đây của những người dự cuộc là loại:

- a. Sai số điều tra
- b. Sai số nhớ lại
- c. Sai số xếp lần thông tin
- d. Sai số bỏ cuộc

17. Sai số chỉ gặp trong nghiên cứu thuần tập do nghiên cứu viên không theo dõi được những cá thể khó tìm kiếm hoặc do chính những người dự cuộc không còn muốn tham gia vào nghiên cứu là loại:

- a. Sai số nhớ lại
- b. Sai số bỏ cuộc
- c. Sai số xếp lần thông tin
- d. Sai số nói dối

18. Sai số nảy sinh khi những thông tin từ những người dự cuộc bị khai thác một cách nhầm lẫn nên các cá thể đáng lẽ được xếp ở nhóm này lại sang nhóm khác là loại:

- a. Sai số bỏ cuộc
- b. Sai số nói dối
- c. Sai số xếp lần thông tin
- d. Sai số do chất lượng dữ liệu có sẵn không so sánh được

19. Sai số nảy sinh trong những nghiên cứu về những yếu tố có liên quan đến đời tư của người dự cuộc, thường họ sẽ cân nhắc để trả lời sai cho điều tra viên là loại:

- a. Sai số bỏ cuộc
- b. Sai số nói dối
- c. Sai số xếp lẫn thông tin
- d. Sai số do chất lượng dữ liệu có sẵn không so sánh được

20. Nhiều là tất cả các yếu tố:

- a. Không có quan hệ với bệnh và yếu tố nguy cơ trong mối quan hệ nhân quả mà ta khảo sát.
- b. Vừa có quan hệ với bệnh vừa có quan hệ với yếu tố nguy cơ trong mối quan hệ nhân quả mà ta khảo sát.
- c. Không có quan hệ với bệnh nhưng có quan hệ với yếu tố nguy cơ trong mối quan hệ nhân quả mà ta khảo sát.
- d. Có quan hệ với bệnh nhưng không có quan hệ với yếu tố nguy cơ trong mối quan hệ nhân quả mà ta khảo sát.

21. Các biện pháp loại trừ sai số hệ thống có thể áp dụng ở giai đoạn:

- a. Chọn mẫu ngẫu nhiên và cỡ mẫu đủ lớn
- b. Chọn nhóm nghiên cứu phù hợp
- c. Chuẩn hóa các phương pháp và công cụ thu thập số liệu nghiên cứu
- d. Cả (b) và (c) đều đúng

22. Trong nghiên cứu bệnh chứng, nếu nhóm chứng được lựa chọn ở bệnh viện sẽ tăng tính giống nhau của nhóm này so với nhóm bệnh về mong muốn tham gia nghiên cứu, các yếu tố ảnh hưởng đến sự nhập viện, nhận thức về nguy cơ và bệnh, đó là biện pháp làm giảm:

- a. Sai số ngẫu nhiên
- b. Sai số hệ thống
- c. Sai số do nhiễu
- d. Cả ba loại sai số trên

23. Trong nghiên cứu thuần tập tương lai và các thử nghiệm lâm sàng nếu chọn những người dễ theo dõi, ít có nguy cơ bỏ cuộc và chọn quần thể có nguy cơ phát triển bệnh cao cuối cuộc nghiên cứu là biện pháp làm giảm:

- a. Sai số ngẫu nhiên
- b. Sai số hệ thống
- c. Sai số do nhiễu

d. Cả ba loại sai số trên

24. Kỹ thuật không áp dụng để phòng ngừa và loại trừ nhiễu ở giai đoạn thiết kế là:

- a. Kỹ thuật ngẫu nhiên hóa.
- b. Kỹ thuật thu hẹp tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu.
- c. Kỹ thuật ghép cặp.
- d. Chuẩn hóa các phương pháp và công cụ thu thập số liệu nghiên cứu

25. Trong quá trình phân tích, để phòng ngừa và loại trừ nhiễu có thể sử dụng kỹ thuật:

- a. Kỹ thuật ngẫu nhiên hóa.
- b. Kỹ thuật phân tích tầng và phân tích đa biến
- c. Kỹ thuật thu hẹp tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu.
- d. Kỹ thuật ghép cặp.

26. Kết hợp sai do may rủi hoặc do một vài sai sót hệ thống trong phương pháp nghiên cứu là:

- a. Kết hợp không phải là căn nguyên
- b. Kết hợp giả tạo
- c. Kết hợp căn nguyên
- d. Kết hợp giả tạo và kết hợp không căn nguyên.

27. Kết hợp gián tiếp, xảy ra trong trường hợp một yếu tố và bệnh có liên quan kết hợp với nhau chỉ vì cả yếu tố và bệnh đều liên quan đến một vài điều kiện nổi bật là:

- a. Kết hợp không phải là căn nguyên
- b. Kết hợp giả tạo
- c. Kết hợp căn nguyên
- d. Kết hợp giả tạo và kết hợp không căn nguyên.

28. Yếu tố không phải là điều kiện cần và đủ để một yếu tố A là nguyên nhân của B là:

- a. A xảy ra trước B
- b. Sự thay đổi của A có liên quan đến sự thay đổi của B.
- c. Ngược lại, sự thay đổi của B có liên quan đến sự thay đổi của A.
- d. Sự tương quan này không những xảy ra chỉ ở chính A và B mà còn có thể có tương quan ở một vài điều kiện khác nữa.

29. Bước đầu tiên cho một phiên giải nghiên cứu phân tích dịch tễ học là trả lời cho câu hỏi:

- a. Có một thống kê không?
- b. Có một thống kê có giá trị không?
- c. Kết hợp thống kê có đủ mạnh không?
- d. Kết hợp thống kê có giá trị có thể đem luận giải nhân quả không?
30. Để xác định xem một thống kê có giá trị không cần phải cân nhắc các yếu tố sau ngoại trừ:
- a. Kết hợp đó có phải do may rủi
- b. Độ lớn của kết hợp
- c. Kết hợp đó có phải là do sai số hệ thống
- d. Kết hợp đó có phải do nhiễu
31. Trong nghiên cứu dịch tễ học phân tích, tiêu chuẩn được dùng rộng rãi đánh giá một kết hợp là một nguyên nhân:
- a. Độ mạnh của kết hợp: biểu hiện bằng tỷ suất các tỷ lệ bệnh ở nhóm có phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ làm giả thuyết với tỷ lệ bệnh ở nhóm không phơi nhiễm.
- b. Quan hệ đáp ứng: quan hệ nguyên nhân càng mạnh khi hiệu quả liều đáp ứng được chứng minh: đó là tăng phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ thì thấy sự gia tăng tương ứng của bệnh
- c. Tính ổn định của kết hợp
- d. Cả ba tiêu chuẩn trên.
32. Trong nghiên cứu dịch tễ học phân tích, tiêu chuẩn được dùng rộng rãi đánh giá một kết hợp là một nguyên nhân:
- a. Quan hệ thời gian - đáp ứng
- b. Tính đặc hiệu của kết hợp
- c. Tính tin cậy sinh học
- d. Cả ba tiêu chuẩn trên.

Đánh dấu vào cột Đ nếu câu trả lời là đúng và đánh dấu vào cột S nếu câu trả lời là sai:

	Đ	S
Tiêu chuẩn để một yếu tố được coi là nhiễu là:		
1. Không phải là một yếu tố nguy cơ đối với bệnh		
2. Phải có liên quan với phơi nhiễm nhưng lại không phụ thuộc vào phơi		

nhiễm		
3. Không phải là yếu tố trung gian giữa yếu tố phơi nhiễm và bệnh		
4. Phải thực sự tác động lên mối tương quan giữa phơi nhiễm và bệnh tức tỷ suất chênh thô phải khác với tỷ suất chênh hiệu chỉnh hoặc nguy cơ tương đối thô phải khác với nguy cơ tương đối hiệu chỉnh		
5. Nhiều và yếu tố phơi nhiễm không thể đổi chỗ cho nhau tùy mục đích của người nghiên cứu		

Trong nghiên cứu dịch tễ học phân tích, các tiêu chuẩn được dùng rộng rãi đánh giá một kết hợp là một nguyên nhân:		
6. Độ mạnh của kết hợp: biểu hiện bằng tỷ suất các tỷ lệ bệnh ở nhóm có phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ làm giả thuyết với tỷ lệ bệnh ở nhóm không phơi nhiễm.		
7. Quan hệ đáp ứng: quan hệ nguyên nhân càng mạnh khi hiệu quả liệu đáp ứng được chứng minh: đó là tăng phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ thì thấy sự gia tăng tương ứng của bệnh		
8. Tính không ổn định của kết hợp		
9. Không nhất thiết phải có quan hệ thời gian đáp ứng		
10. Tính đặc hiệu của kết hợp		
11. Tính tin cậy sinh học		

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

- Ba loại sai số có thể gặp trong các nghiên cứu dịch tễ học là:
 -
 -
 -
- Sai số hệ thống không được có mặt trong(1) do đó tất cả những nguồn tiềm ẩn của sai số hệ thống cần được loại trừ bằng(2) và(3).
- Các loại sai số chọn trong nghiên cứu dịch tễ học:
 -

- b.
- c.
- d.
4. Các loại sai số thông tin trong nghiên cứu dịch tễ học:
- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
5. Để hạn chế được vai trò của các yếu tố may rủi đến mức tối thiểu có thể chấp nhận được thì cần phải:
- a. Đảm bảo kỹ thuật
- b. Cỡ mẫu
6. Để đánh giá vai trò của may rủi người ta sử dụng hai kỹ thuật riêng biệt liên quan với nhau là:
- a.
- b.
7. có thể tạo ra các kết hợp giả tạo, ngay cả trong thiết kế nghiên cứu, trong các phương pháp sử dụng để thu thập số liệu hoặc trong việc chọn nhóm nghiên cứu.
8., khi làm giảm yếu tố trong kết hợp gián tiếp này đi thì tần số bệnh vẫn không giảm trong khi điều kiện chung nổi bật vẫn giữ nguyên như thế.

Giám sát dịch tễ học

Chọn câu trả lời đúng nhất:

1. Giám sát dịch tễ học là quá trình:
 - a. Thu thập thông tin
 - b. Phân tích thông tin
 - c. Giải thích thông tin
 - d. Thu thập, phân tích, giải thích và phân bổ thông tin
2. Trong giám sát dịch tễ học, quá trình thu thập thông tin được tiến hành:
 - a. Định kỳ
 - b. Liên tục có hệ thống
 - c. Liên tục
 - d. Hệ thống
3. Các thông tin thu thập trong dịch tễ học giám sát là các thông tin về:
 - a. sự phân bố và chiều hướng của một nhiễm trùng
 - b. sự phân bố và chiều hướng của một sự kiện có liên quan đến sức khỏe
 - c. sự phân bố và chiều hướng của một nhiễm trùng hay một bệnh đặc biệt hay một sự kiện có liên quan đến sức khỏe
 - d. Mối liên quan giữa một bệnh và các yếu tố nguy cơ
4. Bước cuối cùng của chuỗi giám sát là:
 - a. Áp dụng các dữ liệu đã thu thập, phân tích, giải thích và phổ biến đó để phòng chống và kiểm soát các vấn đề sức khỏe.
 - b. Phổ biến các thông tin cho cộng đồng.
 - c. Triển khai và đánh giá các hoạt động y tế công cộng.
 - d. Viết báo cáo
5. Sự theo dõi liên tục về bệnh và các yếu tố được thực hiện dưới góc nhìn:
 - a. Bệnh xảy ra ở quần thể nào.
 - b. Bệnh xảy ra ở đâu
 - c. Bệnh xảy ra bao giờ
 - d. Cả ba yếu tố trên
6. Để đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp cần phải:
 - a. Theo dõi sự xuất hiện của bệnh.
 - b. Theo dõi sự diễn biến của bệnh.

- c. Theo dõi tỷ lệ tăng giảm của bệnh qua tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ chết.
 - d. Theo dõi kinh phí cho các biện pháp can thiệp
7. Các mục đích của giám sát dịch tễ học là:
- a. Xác định qui mô của bệnh, đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp tại khu vực giám sát.
 - b. Lập kế hoạch, triển khai các hoạt động y tế công cộng
 - c. Đánh giá các hoạt động y tế công cộng
 - d. Cả (a) và (b) đều đúng
8. Giám sát mà thu thập thông tin về bệnh qui ước khai báo định kỳ cả khi không có bệnh là
- a. Giám sát bị động
 - b. Giám sát chủ động
 - c. Giám sát bệnh thường xuyên
 - d. Giám sát chủ động và bị động
9. Giám sát được tiến hành với các dữ kiện ngoài kế hoạch qui ước thường xuyên, có thể do nhân viên giám sát hoặc địa phương xảy ra bệnh khởi xướng là:
- a. Giám sát bị động
 - b. Giám sát chủ động
 - c. Giám sát bệnh thường xuyên
 - d. Giám sát chủ động và bị động
10. Dữ kiện về chết có thể phản ánh sự phát sinh của bệnh đối với :
- a. Các bệnh gây chết nhiều.
 - b. Các bệnh thường không gây chết.
 - c. Các bệnh truyền nhiễm
 - d. Tất cả các loại bệnh.
11. Đặc điểm của số ghi tử vong là:
- a. Số đo tử vong và nguyên nhân chết thường chính xác
 - b. Số đo tử vong và nguyên nhân chết thường không chính xác
 - c. Số đo tử vong thường không chính xác còn nguyên nhân chết thường chính xác

d. Số đo tử vong thường chính xác còn nguyên nhân chết thường không chính xác

12. Yếu tố không phải là yếu tố thuận lợi của báo cáo mắc bệnh là:

- a. Các báo cáo được thầy thuốc chẩn đoán chính xác bệnh
- b. Có thể có các xét nghiệm xác nhận chẩn đoán
- c. Thường có một tổ chức tập hợp lại và báo cáo
- d. Báo cáo thường định kỳ, đúng kỳ hạn nên kịp thời thông báo dịch.

13. Giám sát dịch tễ học dựa vào báo cáo mắc bệnh có yếu tố bất lợi là:

- a. Thiếu nhiều bệnh do virus trong danh sách báo cáo
- b. Thường báo cáo dưới mức nảy sinh và lưu hành của bệnh
- c. Chẩn đoán ít chính xác (không có kết quả của các xét nghiệm) đặc biệt với các bệnh do virus.
- d. Cả ba yếu tố trên

14. Giám sát dịch tễ học dựa vào báo cáo mắc bệnh có yếu tố bất lợi là:

- a. a. Các báo cáo được thầy thuốc chẩn đoán không chính xác bệnh
- b. b. Thường không có các xét nghiệm xác nhận chẩn đoán.
- c. Báo cáo thường không kịp thời, đúng kỳ hạn nên thường làm tăng thời gian của dịch.
- d. d. Các tổ chức tập hợp lại và báo cáo lại thường không đầy đủ, sai lệch thông tin.

15. Ngày nay, việc xác định dịch dễ dàng đối với:

- a. Tất cả các loại bệnh
- b. Các bệnh mà đa số các trường hợp bệnh là điển hình
- c. Cả các bệnh nhiễm khuẩn phần lớn thể nhẹ hoặc không triệu chứng
- d. Cả các bệnh xảy ra ở những nơi nền y tế chưa hoàn thiện

16. Cần thành lập một đội điều tra dịch tại thực địa khi:

- a. Có sự gia tăng tỷ lệ mắc.
- b. Có sự gia tăng tỷ lệ chết.
- c. Có sự giảm tỷ lệ mắc hoặc chết
- d. Có sự gia tăng tỷ lệ mắc hoặc chết.

17. Khi tổ chức các đội điều tra dịch tại thực địa cần:

- a. Triển khai những kỹ thuật chẩn đoán nhanh như ELISA, kỹ thuật trên da
- b. Không thể chẩn đoán trực tiếp tác nhân gây bệnh tại thực địa
- c. Không cần thiết phải phân tích dịch và đánh giá các chương trình miễn dịch
- d. Cả (a) và (c) đúng

18. Khi tìm hiểu về cơ cấu dân cư khu vực giám sát cần đặc biệt chú ý:

- a. Tuổi, giới, chủng tộc.
- b. Nghề nghiệp.
- c. Sự biến động dân số.
- d. Phong tục tập quán

19. Khi giám sát các bệnh do súc vật truyền sang người cần mô tả :

- a. những súc vật bị nhiễm theo thời gian, địa điểm, cách thức bị nhiễm
- b. các điều kiện địa lý.
- c. điều kiện khí hậu.
- d. điều kiện thời tiết.

20. Hệ thống báo cáo và giám sát các bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam bao gồm các hoạt động:

- a. Chỉ báo cáo các vụ dịch.
- b. Báo cáo các bệnh truyền nhiễm theo qui định hàng tháng, theo tuyến cơ sở, tỉnh, trung ương, kiểm tra và đánh giá qui trình giám sát.
- c. Khi phát hiện nghi ngờ trường hợp bệnh truyền nhiễm qui định giám sát ưu tiên phải báo cáo theo chế độ báo cáo dịch.
- d. Cả (b) và (c) đều đúng

21. Hạn chế của giám sát nói chung

- a. Hoạt động cần nhiều nhân công
- b. Sự sắp xếp thành bảng và phân tích tốn nhiều thời gian
- c. Hạn chế một vài chỉ số chính
- d. Cả ba yếu tố trên

22. Hạn chế của giám sát nói chung

- a. Để xác định xu hướng của bệnh cần thu thập thông tin vài năm

- b. Khó khăn trong việc đánh giá tác động nếu quần thể nhỏ hoặc không có nhóm chứng
- c. Việc báo cáo từ giám sát thường không đầy đủ
- d. Cả ba yếu tố trên

23. Hạn chế trong hệ thống báo cáo sát các bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam là

- a. Số liệu báo cáo bệnh truyền nhiễm hàng tháng không thể phân biệt được theo nhóm tuổi, giới.
- b. Số liệu không tận dụng để phân tích sâu được
- c. Báo cáo theo đường bưu điện thường chậm
- d. Cả (a), (b) và (c) đều đúng

24. Các biện pháp khắc phục hạn chế của hệ thống giám sát ở Việt nam là

- a. Không cần thay đổi gì vì hiện nay hoạt động đã rất hiệu quả
- b. Kết nối mạng hệ thống báo cáo, có chương trình quản lý phân tích số liệu phù hợp
- c. Bổ sung nhân lực cho công việc giám sát
- d. Cả (b) và (c) đều đúng

Đánh dấu vào cột Đ nếu câu trả lời là đúng và đánh dấu vào cột S nếu câu trả lời là sai:

	Đ	S
Những dữ kiện về điều kiện môi trường hoàn cảnh bên ngoài cần được hiểu biết và thu thập bao gồm:		
1. Cơ cấu của khu vực giám sát		
2. Trình độ phát triển kinh tế xã hội		
3. Các thông tin về hệ thống giáo dục		
4. Điều kiện địa lý, khí hậu, thời tiết		
5. Các ổ chứa tự nhiên trong súc vật, vector truyền bệnh		
6. Giám sát bệnh do súc vật truyền sang người		
7. Các thông tin về hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền		
8. Các thông tin về bệnh tật nói chung		
9. Vệ sinh môi trường		
10. Các thông tin về công nghiệp hóa		
11. Các thông tin về cơ cấu, tổ chức mạng lưới y tế		

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

1. Giám sát dịch tễ học là việc thu thập(1) các thông tin về sự phân bố và chiều hướng của một nhiễm trùng hay một bệnh đặc biệt hay một sự kiện có liên quan đến sức khỏe,(2), (3), và(4) những thông tin đó, nhằm mục đích xác định ưu tiên và giúp cho việc lập kế hoạch, thực hiện đánh giá các chương trình can thiệp.
2. Nếu các biện pháp can thiệp có hiệu quả thì tỷ lệ mới mắc hoặc chết sẽ
3. Bốn chức năng chủ yếu của giám sát dịch tễ học là:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
4. Các nguồn số liệu được sử dụng trong giám sát dịch tễ học là.
 - (1). Tỷ lệ
 - (2). Tỷ lệ
 - (3). Báo cáo.....
 - (4).
 - (5). Điều tra.....
 - (6). Điều tra.....
 - (7). Điều tra
 - (8). Nghiên cứu.....
 - (9).các sinh vật phẩm và thuốc men.
 - (10). Các dữ liệu về (a).....và (b)
 - (11).

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

5. Mười nội dung hoạt động của giám sát là:

- (1).vànhững dữ kiện về điều kiện môi trường hoàn cảnh bên ngoài
- (2).những số liệu thích hợp để giám sát bệnh
- (3). Giám sát dịch tễ học
- (4). Giám sát dịch tễ học
- (5). Nghiên cứu
- (6). Giám sát trong
- (7). Giám sát
- (8). Giám sát
- (9). Sử dụng kết quả giám sát dịch tễ học để
- (10). Trình bày dự án

Nguyên lý dịch tễ học các bệnh nhiễm trùng

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào ký tự trong các câu hỏi sau:

1. Quá trình dịch được thường được vận dụng đối với:
 - a. các bệnh nhiễm trùng
 - b. các bệnh lây truyền từ người sang người
 - c. các bệnh lây truyền từ động vật sang người
 - d. các bệnh lây truyền sang người qua vật chủ trung gian truyền bệnh
2. Quá trình dịch được xác định khi:
 - a. khi một dãy những ổ dịch có liên quan với nhau
 - b. khi xuất hiện một trường hợp mắc bệnh có khả năng lây nhiễm cao trong cộng đồng
 - c. khi tỷ lệ mắc một bệnh truyền nhiễm tương đương giữa các năm
 - d. khi tỷ lệ mắc/chết của một bệnh truyền nhiễm tăng.
3. Những yếu tố nào không thuộc mắt xích của quá trình dịch :
 - a. nguồn truyền nhiễm
 - b. đường truyền nhiễm
 - c. khối cảm thụ
 - d. khả năng sinh vật tồn tại kéo dài ngoài môi trường
4. Trường hợp nào sau đây không là nguồn truyền nhiễm
 - a. người bệnh
 - b. người mang trùng
 - c. động vật bị bệnh
 - d. người khỏi bệnh về phương diện vi sinh.
5. Những bệnh nào sau đây có ổ chứa thiên nhiên:
 - a. lao
 - b. dịch hạch
 - c. sởi
 - d. ho gà
6. Những bệnh nào sau đây có ổ chứa thiên nhiên
 - a. sốt rét
 - b. viêm gan
 - c. bạch hầu

- d. bại liệt
1. Đường truyền nhiễm được hiểu là:
 - a. môi trường thuận lợi cho vi khuẩn tồn tại và phát triển
 - b. môi trường vận chuyển tác nhân gây bệnh đến cơ thể lành
 - c. môi trường mà vi khuẩn có thể tồn tại
 - d. gồm các môi trường ngoài cơ thể mà vi khuẩn tồn tại được
 2. Trường hợp nào sau đây là đường truyền nhiễm của bệnh tả:
 - a. bọ chét
 - b. nước
 - c. ruồi
 - d. muỗi
 3. Trường hợp nào sau đây **không** coi là đường truyền nhiễm của các bệnh truyền nhiễm nói chung:
 - a. đường tình dục
 - b. đường máu
 - c. đường da và niêm mạc
 - d. đường hô hấp
 4. Trường hợp nào sau đây **không** coi là đường truyền nhiễm của các bệnh truyền nhiễm nói chung:
 - a. đường lây nhiễm qua ghép tạng
 - b. đường máu
 - c. đường tiêu hoá
 - d. đường da và niêm mạc
 5. Khái niệm của một bệnh truyền nhiễm được định nghĩa là :
 - a. gồm tất cả những người khoẻ mạnh chưa có miễn dịch với bệnh
 - b. gồm tất cả những người khoẻ mạnh đã có miễn dịch tự nhiên
 - c. gồm tất cả những người mắc bệnh khi dịch xảy ra
 - d. gồm những người yếu dễ có nguy cơ mắc bệnh hơn người khoẻ.
 6. Miễn dịch thụ động đối với một bệnh truyền nhiễm có được khi :
 - a. miễn dịch do mẹ truyền cho con
 - b. miễn dịch có được do sống ở trong vùng có dịch nhưng không bị bệnh
 - c. miễn dịch có được sau khi tiêm phòng vaccin
 - d. miễn dịch có được sau khi mắc bệnh
 7. Miễn dịch chủ động nhân tạo đối với một bệnh truyền nhiễm có được khi:

- a. sau khi mắc bệnh
 - b. sau khi tiêm kháng huyết thanh
 - c. sau khi tiêm phòng vaccin
 - d. truyền từ mẹ sang con.
8. Miễn dịch tự nhiên chủ động đối với một bệnh truyền nhiễm có được khi:
- a. sau khi mắc bệnh
 - b. sau khi tiêm kháng huyết thanh
 - c. sau khi tiêm phòng vaccin
 - d. miễn dịch của con trong vòng 6 tháng đầu
15. Những trường hợp nào sau đây có miễn dịch chủ động đối với một bệnh truyền nhiễm
- a. miễn dịch của con trong vòng 6 tháng đầu
 - b. sau khi mắc một bệnh
 - c. sau khi tiêm kháng huyết thanh
 - d. cả 3 trường hợp trên
16. Những yếu tố nào sau đây **không** trực tiếp gây nên quá trình dịch
- a. người chưa có miễn dịch
 - b. đường truyền nhiễm
 - c. người bệnh
 - d. khí hậu nóng
17. Dịch có thể xảy ra mà **không** cần có yếu tố nào sau đây
- a. người bệnh
 - b. đường truyền nhiễm
 - c. người chưa có miễn dịch
 - d. điều kiện vệ sinh xã hội thấp kém
18. Quá trình dịch có thể **không** xảy ra nếu thiếu yếu tố nào sau đây:
- a. không có tác nhân gây bệnh trong cộng đồng
 - b. cộng đồng chưa có miễn dịch với bệnh
 - c. đường truyền nhiễm phù hợp
 - d. hệ thống chăm sóc y tế phát triển
19. Yếu tố nào sau đây là yếu tố trực tiếp của quá trình dịch :
- a. người lành mang trùng
 - b. hệ thống chăm sóc y tế lạc hậu
 - c. khu vực khí hậu thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát triển
 - d. cộng đồng có trình độ văn hoá thấp.

20. Một bệnh truyền nhiễm trở thành dịch khi hệ số năm dịch là
- trên 90%
 - trên 100%
 - trên 150%
 - trên 200%
21. Xác định một bệnh truyền nhiễm trở thành dịch cần dựa vào :
- hệ số năm dịch
 - tỷ lệ mới mắc
 - tỷ lệ hiện mắc một bệnh
 - hệ số mùa dịch
22. Xác định mùa dịch của một bệnh truyền nhiễm cần dựa vào:
- tỷ lệ hiện mắc
 - tỷ lệ mới mắc
 - tính toán theo chỉ số mắc trung bình theo tháng
 - tính toán theo chỉ số mắc trung bình theo ngày
23. Cơ chế truyền nhiễm được hiểu là :
- cơ chế đảm bảo cho vi khuẩn sau khi ra ngoài môi trường có thể tồn tại và phát triển
 - cơ chế đảm bảo cho vi khuẩn từ vật chủ này sang sinh trưởng và phát triển ở vật chủ khác
 - cơ chế đảm bảo cho vi khuẩn có thể chuyển từ trạng thái ngủ sang trạng thái hoạt động và gây bệnh
 - cơ chế mà người bệnh chuyển từ trạng thái mắc bệnh sang trạng thái mang trùng.
24. Cơ chế truyền nhiễm không bao gồm giai đoạn nào:
- tác nhân gây bệnh tách khỏi vật chủ
 - tác nhân gây bệnh tồn tại ngoài môi trường
 - tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể mới
 - tác nhân gây bệnh tồn tại và phát triển ở cơ thể mới.
25. Những bệnh nào sau đây có nhiều đường truyền nhiễm
- HIV/AIDS
 - viêm gan B
 - lao
 - bệnh than
26. Bệnh nào sau đây có một đường truyền nhiễm:

- a. bệnh than
 - b. bệnh dịch hạch
 - c. HIV/AIDS
 - d. viêm gan B
27. Bệnh nào sau đây có nhiều phương thức truyền nhiễm:
- a. viêm gan B
 - b. leptospira
 - c. bệnh dại
 - d. bệnh bò điên
28. Bệnh nào sau đây lây truyền theo đường tiêu hoá
- a. bò điên
 - b. bệnh dại
 - c. bệnh viêm gan C
 - d. bệnh than
29. Bệnh nào sau đây chỉ lây nhiễm theo đường máu:
- a. HIV/AIDS
 - b. Bệnh than
 - c. Bệnh dịch hạch
 - d. Bệnh uốn ván
30. Bệnh nào sau đây chỉ lây nhiễm theo đường tiêu hoá
- a. lao
 - b. lỵ
 - c. bạch hầu
 - d. viêm não nhật bản B
31. Bệnh nào sau đây có cơ chế lây nhiễm theo đường hô hấp
- a. bạch hầu
 - b. viêm não nhật bản B
 - c. sốt rét
 - d. dengue xuất huyết
32. Bệnh nào sau đây chỉ lây nhiễm theo đường da và niêm mạc :
- a. bệnh dại
 - b. bệnh than
 - c. dịch hạch
 - d. bò điên

33. Những biện pháp Nhà nước trong công tác chống dịch thường là biện pháp cụ thể đối với :
- đường truyền nhiễm
 - nguồn truyền nhiễm
 - tiêm phòng toàn dân
 - qui định về thông báo dịch
34. Biện pháp chống dịch nào sau đây thuộc biện pháp Nhà nước:
- qui định về vùng cách ly
 - qui định về thời gian cách ly cho bệnh nhân
 - qui định về trang bị bảo hộ khi tiếp xúc với người bệnh
 - qui định những đối tượng cần giám sát sinh vật trong vùng có dịch
35. Biện pháp chống dịch nào sau đây là biện pháp Nhà nước đối với việc phòng chống dịch SARS:
- cách ly mọi đối tượng nhập cảnh từ vùng có dịch trong vòng 15 ngày
 - qui định về theo dõi nhiệt độ ở những người nghi ngờ
 - qui định về tiêu chuẩn chẩn đoán SARS
 - qui định về thời gian cách ly tại bệnh viện
36. Biện pháp dự phòng nào sau đây chỉ thực hiện được khi việc tổ chức giáo dục sức khỏe thực hiện tốt
- thói quen rửa tay trước khi ăn
 - tiêm phòng
 - khám bệnh khi có triệu chứng nghi ngờ
 - giám sát vi sinh sau khi khỏi bệnh
37. Biện pháp y tế tác động vào nguồn truyền nhiễm để phòng và dập dịch là:
- phát hiện sớm và điều trị triệt để cho người bệnh
 - tiêm chủng toàn dân
 - xử lý chất thải của bệnh nhân
 - rửa tay trước khi cho bệnh nhân ăn.
38. Biện pháp y tế tác động vào nguồn truyền nhiễm để phòng và dập dịch là:
- giám sát vi khuẩn đối với người tiếp xúc trong ổ dịch
 - diệt muỗi
 - thả bọ gậy
 - không dùng chung đồ chung với bệnh nhân
39. Biện pháp y tế tác động vào đường truyền nhiễm để phòng và dập dịch là:

- a. tiêm vaccin phòng bệnh
- b. điều trị dự phòng bằng hoá trị liệu
- c. giám sát người lành mang trùng
- d. nằm màn

40. Biện pháp y tế tác động vào khối cảm thụ để phòng và dập dịch là:

- a. tiêm phòng vaccin
- b. ăn uống hợp vệ sinh
- c. nằm màn
- d. điều trị hoá trị liệu dự phòng

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng hoặc sai trong các câu hỏi sau :

STT	Câu hỏi	Đ	S
1.	Quá trình dịch là một khái niệm thường vận dụng cho các bệnh truyền nhiễm.		
2.	Quá trình dịch là sự xuất hiện các trường hợp bệnh truyền nhiễm liên tục và kéo dài trong năm và liên tục trong các năm.		
3.	Quá trình dịch được qui định bởi 3 yếu tố trực tiếp là nguồn truyền nhiễm, khối cảm thụ và điều kiện vệ sinh của cộng đồng.		
4.	Quá trình dịch chỉ xảy ra khi mất đồng thời 3 yếu tố nguồn truyền nhiễm, đường truyền nhiễm, người khoẻ chưa có miễn dịch.		
5.	Dịch bạch hầu có thể xảy ra trong một quần thể khi có trường hợp mắc bệnh mặc dù toàn bộ quần thể đã tiêm phòng đầy đủ vaccin		
6.	Cơ chế truyền nhiễm là một cơ chế đảm bảo cho vi khuẩn gây bệnh từ vật chủ này sang sinh trưởng và phát triển ở vật chủ khác mà không nhất thiết có biểu hiện bệnh		
7.	Các bệnh truyền nhiễm đều có cùng cơ chế truyền nhiễm như nhau		
8.	Tác nhân gây bệnh có thể tồn tại ngoài môi trường hoặc ký sinh ở các vật chủ trung gian trước khi xâm nhập vào cơ thể mới		
9.	Biện pháp Nhà nước trong công tác chống dịch thường là những qui định được rút ra sau mỗi vụ dịch.		
10.	Nâng cao nhận thức của nhân dân về phương thức truyền nhiễm bệnh và xây dựng thói quen nằm màn trong nhân dân có thể phòng được bệnh		

	sốt xuất huyết		
11.	Rửa tay trước khi ăn là một biện pháp bảo vệ khỏi cảm thụ trong các bệnh lây truyền theo đường tiêu hoá		
12.	Tiêm phòng vaccin là biện pháp cắt nguồn truyền nhiễm có hiệu quả nhất đối với các bệnh truyền nhiễm		
13.	Biện pháp y tế trong công tác phòng chống dịch có hiệu quả đối với mọi bệnh truyền nhiễm là cắt đường truyền nhiễm		
14.	Xử lý phân và chất thải của bệnh nhân là một biện pháp cắt đường truyền nhiễm		

Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào khoảng trống sau :

1. Quá trình dịch là, ổ dịch này phát sinh từ ổ dịch khác, với mối liên quan bên trong của chúng được quyết định bởi điều kiện sống của xã hội loài người.

2. Nguồn truyền nhiễm là người
.....

3. Nguồn truyền nhiễm là (1).....
trong đó vi sinh vật gây bệnh (2)

4. Ba mắt xích trực tiếp của quá trình dịch là :

1.
2.
3.

5. Hai yếu tố gián tiếp của quá trình dịch là :

1.
2.

6. Hệ số năm dịch

$$HSND = \frac{\text{.....}}{\text{.....}}$$

7. Hệ số mùa dịch

$$HSMD = \frac{\text{.....}}{\text{.....}}$$

8. Các bệnh truyền nhiễm được phân loại theo 4 đường truyền nhiễm, đó là :

1.
2.
3.
4.

9. Kể tên 2 bệnh có nhiều đường truyền nhiễm :

1.
2.

10. Kể tên 3 bệnh lây nhiễm theo đường tiêu hoá

1.
2.
3.

11. Kể tên 3 bệnh lây nhiễm theo đường hô hấp :

1.
2.
3.

12. Kể tên 3 bệnh lây nhiễm theo da và niêm mạc :

1.
2.
3.

13. Kể tên 3 bệnh lây nhiễm theo đường máu :

1.
2.
3.

14. Kể tên 2 bệnh lây nhiễm theo đường máu nhưng có nhiều phương thức lây nhiễm khác nhau :

1.
2.

15. Biện pháp Nhà nước trong công tác phòng chống dịch chính là :.....

16. Biện pháp y tế tác động vào các khâu của quá trình dịch là :

1.
2.
3.

17. Kể tên 3 biện pháp y tế áp dụng đối với nguồn truyền nhiễm :

1.
2.
3.

18. Kể tên 4 biện pháp y tế áp dụng với đường truyền nhiễm :

1.
2.
3.
4.

Dịch tể học nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào ký tự trong các câu hỏi sau :

1. Bệnh nào sau đây lây truyền qua đường hô hấp :
 - a. não mô cầu
 - b. lỵ
 - c. đại
 - d. leptospira
2. Bệnh nào sau đây **không** lây nhiễm qua đường hô hấp;
 - a. thủy đậu
 - b. não mô cầu
 - c. quai bị
 - d. sốt rét
3. Tác nhân gây bệnh nào sau đây có khả năng tồn tại lâu nhất ở ngoại cảnh trong điều kiện khí hậu khô lạnh :
 - a. bạch hầu
 - b. thủy đậu
 - c. quai bị
 - d. cúm
4. Thời kỳ ủ bệnh của virus sởi thường trong khoảng thời gian
 - a. dưới 3 ngày
 - b. 12-14 ngày
 - c. 21 ngày
 - d. 30 ngày
5. Trong các bệnh sau, bệnh nào có nguồn truyền nhiễm duy nhất là người bệnh :
 - a. sởi
 - b. cúm
 - c. bạch hầu
 - d. viêm màng não phát dịch
6. Trong các bệnh sau bệnh nào có nguồn truyền nhiễm bao gồm cả người lành mang trùng
 - a. ho gà

- b. đậu mùa
 - c. thủy đậu
 - d. bạch hầu
7. Thời gian mang trùng đối với các bệnh truyền nhiễm theo đường hô hấp có đặc điểm:
- a. hoàn toàn giống nhau giữa các bệnh
 - b. khác nhau giữa các bệnh và khác nhau giữa các nguồn truyền nhiễm
 - c. khác nhau giữa người khỏi bệnh và người lành mang trùng
 - d. thời gian mang trùng của người bệnh, người khỏi bệnh và người lành mang trùng là như nhau.
8. Bệnh nào sau đây có nguy cơ lây nhiễm gián tiếp cao nhất qua dụng cụ, đồ chơi :
- a. sởi
 - b. cúm
 - c. đậu mùa.
 - d. bạch hầu
9. Bệnh nào sau đây miễn dịch không bền vững:
- a. cúm
 - b. đậu mùa
 - c. ho gà
 - d. bạch hầu
10. Những người có nguy cơ cao mắc các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp:
- a. người chưa có miễn dịch
 - b. người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân
 - c. nhân viên y tế
 - d. con của người bệnh
11. Bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp có tỷ lệ trẻ em mắc cao nhóm khác vì lý do chính là :
- a. sức đề kháng của trẻ em thấp
 - b. trẻ em có nhạy cảm hơn với các bệnh đường hô hấp
 - c. người lớn và trẻ lớn đã tiếp xúc hoặc đã mắc bệnh
 - d. trẻ em sống tập trung hơn.
12. Bệnh lây nhiễm theo đường hô hấp có tỷ lệ mắc cao ở khu vực đông dân và đô thị hơn vùng nông thôn vì lý do chính là:
- a. tiếp xúc gần
 - b. do dùng nhiều kháng sinh, vi khuẩn kháng thuốc

- c. do không được tiêm chủng đầy đủ
 - d. thường khó phát hiện và phát hiện muộn
13. Bệnh lây nhiễm theo đường hô hấp có tính chất mùa, thường tăng cao trong các tháng lạnh, ẩm vì :
- a. bệnh đường hô hấp chỉ xảy ra vào các tháng lạnh
 - b. khí hậu thuận lợi cho việc phát sinh bệnh
 - c. tăng mức độ tiếp xúc tại các nhà trẻ vào kỳ nhập học
 - d. sức đề kháng giảm hơn vào các tháng mùa lạnh, ẩm
14. Dịch sởi có tính chất chu kỳ 3-4 lần dịch bùng phát thành dịch lớn vì:
- a. tích lũy số trẻ không có miễn dịch với bệnh với số lượng đủ lớn để bùng phát thành dịch
 - b. hiệu quả của công tác phòng chống dịch giảm
 - c. công tác giám sát phát hiện dịch không tập trung
 - d. kháng thể của mẹ giảm khi tuổi cao.
9. Bệnh sởi cần cách ly :
- a. trong khi sốt và suốt thời kỳ nổi ban
 - b. bắt buộc cách ly tại bệnh viện
 - c. trong thời gian có sốt
 - d. cho đến sau khi ban sởi bay hết 2 tuần.
16. Bệnh ho gà cần cách ly:
- a. bắt buộc tại bệnh viện
 - b. thời gian chảy nước mũi và trong vòng 15 ngày của thời kỳ ho rũ
 - c. thời gian 3 tháng kể từ khi mắc bệnh
 - d. thời gian 6 tháng kể từ khi mắc bệnh
17. Thời gian theo dõi cách ly tại nhà đối với người tiếp xúc với bệnh nhân ho gà là:
- a. 1 tuần
 - b. 2 tuần
 - c. 3 tuần
 - d. 4 tuần
18. Thời gian cách ly trẻ bị thủy đậu cần:
- a. 3 ngày sau khi nốt thủy đậu đóng vảy
 - b. 7 ngày kể từ khi phát bệnh
 - c. 14 ngày kể từ khi phát bệnh
 - d. bắt buộc tại bệnh viện

19. Bệnh bạch hầu cần cách ly :
- bắt buộc tại bệnh viện
 - tại nhà
 - bệnh nhân cho ra viện hết triệu chứng lâm sàng và kết quả xét nghiệm dịch họng 2 lần mỗi lần cách nhau 8 ngày không có vi khuẩn
 - cho ra viện khi khỏi các dấu hiệu lâm sàng 16 ngày.
20. Thời gian cách ly đối với người tiếp xúc bệnh nhân đậu mùa là :
- 7 ngày từ khi tiếp xúc
 - 14 ngày từ khi tiếp xúc
 - 21 ngày từ khi tiếp xúc
 - 30 ngày từ khi tiếp xúc
21. Bệnh nhân quai bị cần cách ly :
- hết triệu chứng lâm sàng
 - hết sốt
 - sau 14 ngày từ khi phát bệnh
 - sau 21 ngày từ khi phát bệnh
22. Thời gian cách ly theo dõi đối với trẻ dưới 10 tuổi tiếp xúc với bệnh nhân bị quai bị là :
- 7 ngày
 - 14 ngày
 - 21 ngày
 - 30 ngày
23. Bệnh nào sau đây không nhất thiết phải tiêm phòng cho trẻ dưới 1 tuổi
- bạch hầu
 - ho gà
 - sởi
 - viêm não phát dịch
24. Biện pháp phòng dịch các bệnh lây nhiễm theo đường hô hấp tác động hiệu quả nhất là :
- khử khuẩn khu vực có bệnh nhân
 - tiêm vaccin
 - phát hiện bệnh nhân sớm và cách ly
 - mang khẩu trang khi chăm sóc bệnh nhân

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng hoặc sai phù hợp trong các câu hỏi sau :

STT	Câu hỏi	Đ	S
1.	Bệnh quai bị là một bệnh lây nhiễm theo đường hô hấp		
2.	Trực khuẩn ho gà bền vững ngoài cơ thể, trực khuẩn có thể tồn tại hàng tháng dưới ánh nắng mặt trời		
3.	Trực khuẩn bạch hầu có thể tồn tại lâu ngoài cơ thể, trong điều kiện lạnh khô.		
4.	Virus sởi có thể tồn tại lâu ngoài cơ thể ngay cả khi thời tiết nóng khô.		
5.	Bệnh sởi có nguồn truyền nhiễm duy nhất là người bệnh		
6.	Bệnh ho gà có nguồn truyền nhiễm gồm cả người bệnh và người lành mang trùng		
7.	Các bệnh bạch hầu, tinh hồng nhiệt có nguồn truyền nhiễm duy nhất là người bệnh		
8.	Bệnh đậu mùa có nguồn truyền nhiễm duy nhất là người bệnh		
9.	Bệnh thủy đậu, quai bị có nguồn truyền nhiễm là người bệnh và người lành mang trùng		
10.	Các bệnh bạch hầu, sởi, ho gà có miễn dịch ổn định và bền vững suốt đời		
11.	Bệnh cúm có miễn dịch ổn định và bền vững suốt đời		
12.	Lý do chính để bệnh lây theo đường hô hấp thường gặp ở lứa tuổi nhỏ là do mọi người đều có khả năng nhiễm bệnh khi còn nhỏ và trẻ em thường sinh hoạt tập trung tại các nhà trẻ.		
13.	Bệnh lây nhiễm theo đường hô hấp lần đầu tiên xuất hiện ở cộng đồng dân cư thưa thớt tỷ lệ mắc ở trẻ em là cao nhất		
14.	Bệnh sởi có tính chu kỳ 2-3 năm vì hiệu lực miễn dịch giảm ở những người không tiếp xúc bệnh		
15.	Bệnh lây nhiễm theo đường hô hấp như sởi chỉ mắc vào các tháng mùa đông, thời tiết lạnh ẩm		
16.	Biện pháp phòng dịch sởi, bạch hầu hiệu quả nhất là tiêm vaccin phòng bệnh cho trẻ		
17.	Trẻ mắc sởi cần phải cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày (từ khi sốt cho tới hết thời kỳ phát ban)		
18.	Người tiếp xúc, chăm sóc trẻ bị bạch hầu cần phải theo dõi giám sát vi khuẩn 2 lần cách nhau 2 ngày. Nếu kết quả dương tính cần cách ly 7		

	ngày không tiếp xúc với người bệnh		
--	------------------------------------	--	--

Hãy điền từ hoặc cụm từ đúng và thích hợp vào ô trống trong các câu hỏi sau:

1. Tác nhân gây bệnh sởi, thủy đậu, quai bị là
2. Tác nhân gây bệnh bạch hầu, ho gà là.....
3. Kể tên 2 bệnh lây nhiễm theo đường hô hấp và có triệu chứng bệnh đường hô hấp ở trẻ dưới 1 tuổi, có nguồn truyền nhiễm duy nhất là người bệnh :
 - 1.....
 - 2.....
4. Nguồn truyền nhiễm bệnh bạch hầu có thể có 3 nguồn là :
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
5. Các bệnh sởi, bạch hầu, ho gà sau khi mắc bệnh cơ thể có miễn dịch
(1) (2)
6. Sau khi mắc bệnh cúm, cơ thể có miễn dịch (1) (2).....
7. Tiêm phòng vaccin đối với các bệnh lây nhiễm theo đường hô hấp là
.....

DTH nhóm bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào ký tự ở đầu câu trong các câu hỏi sau:

1. Vi khuẩn thương hàn (Salmonella) có thể tồn tại :
 - a. trong thực phẩm, vi khuẩn tồn tại và phát triển
 - b. kém nhạy cảm với hoá chất diệt khuẩn
 - c. chết sau khi đun sôi 30 phút
 - d. chết nhanh trong bùn, đất
2. Những týp nào của trực khuẩn lỵ Shigella tạo ra cả nội độc tố và ngoại độc tố:
 - a. S.dysenteria
 - b. S.flexneri
 - c. S.boydii
 - d. S.sonnei
3. Trực khuẩn lỵ có thể chết khi đun ở nhiệt độ 50-60⁰C sau:
 - a. 10 ph
 - b. 20 ph
 - c. 30 ph
 - d. 60 ph
4. Vi khuẩn lỵ có thể tồn tại trong:
 - a. nước máy 1 ngày
 - b. nước ao hồ 2 ngày
 - c. phân khô 3 tháng
 - d. thực phẩm 10-15 ngày
5. Chứng vi khuẩn tả gây dịch tại Việt nam hiện nay là
 - a. V.cholerae O1
 - b. V.cholerae O139
 - c. V.cholerae O151
 - d. V.cholerae non O1.
6. Vi khuẩn tả có thể tồn tại ngoài cơ thể :
 - a. trong đất dưới 3 ngày
 - b. trong sữa 6-10 ngày
 - c. trong nước 1 ngày

- d. trong phân 3 ngày
- 7. Vi khuẩn tả chết khi :
 - a. đun 80⁰C trong 5ph
 - b. đun sôi trong 30 ph
 - c. để ở nhiệt độ thường
 - d. ngâm trong dung dịch tiệt trùng sau 3 giờ
- 8. Virus viêm gan A chết khi:
 - a. đun sôi 100⁰C sau 5 ph
 - b. đun sôi 100⁰C sau 30 ph
 - c. đun sôi 100⁰C sau 60 ph
 - d. đun sôi 100⁰C sau 90 ph
- 9. Bệnh thương hàn có nguồn truyền nhiễm
 - a. người bệnh
 - b. người lành mang trùng
 - c. người khỏi bệnh mang trùng
 - d. cả 3 trường hợp trên
- 10. Bệnh viêm gan A có nguồn truyền nhiễm là:
 - a. người bệnh
 - b. người lành mang trùng
 - c. người khỏi mang trùng
 - d. cả 3 trường hợp trên
- 11. Bệnh lỵ có nguồn truyền nhiễm là:
 - a. người bệnh
 - b. người lành mang trùng
 - c. người khỏi bệnh mang trùng
 - d. cả 3 trường hợp trên
- 12. Bệnh lây nhiễm theo đường tiêu hoá **không** lây nhiễm qua:
 - a. nước
 - b. thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh
 - c. dụng cụ chế biến sau khi tiệt khuẩn
 - d. tay người chế biến thực phẩm
- 13. Miễn dịch sau khi mắc các bệnh đường tiêu hoá nhìn chung:
 - a. ngắn, không bền vững
 - b. ổn định và bền vững

- c. có khả năng miễn dịch chéo
 - d. miễn dịch ổn định sau ít nhất 3 lần mắc bệnh
14. Bệnh bại liệt có nguồn truyền nhiễm là:
- a. người bệnh
 - b. người khỏi bệnh mang trùng
 - c. người lành mang trùng
 - d. cả 3 trường hợp trên
15. Tại các vùng dịch tả lưu hành:
- a. 100% các trường hợp nhiễm vi khuẩn đều biểu hiện triệu chứng tả điển hình
 - b. 50% các trường hợp nhiễm vi khuẩn đều biểu hiện triệu chứng tả điển hình
 - c. 30% các trường hợp nhiễm vi khuẩn đều biểu hiện triệu chứng tả điển hình
 - d. 5% các trường hợp nhiễm vi khuẩn đều biểu hiện triệu chứng tả điển hình
10. Bệnh nào sau đây có miễn dịch bền vững suốt đời :
- a. tả
 - b. thương hàn
 - c. viêm gan A
 - d. lỵ
11. Bệnh nào sau đây có thể có miễn dịch bền vững sau khi mắc bệnh:
- a. leptospira
 - b. bại liệt
 - c. lỵ
 - d. thương hàn
12. Bệnh nào sau đây có khả năng bùng nổ thành dịch lớn
- a. tả
 - b. viêm gan A
 - c. thương hàn
 - d. lỵ
19. Những bệnh sau đây bệnh nào thường xảy ra vào mùa đông xuân
- a. tả
 - b. thương hàn
 - c. viêm gan
 - d. tiêu chảy do rota virus

20. Người ta giải thích hiện tượng các bệnh truyền nhiễm theo đường tiêu hoá có tính chất theo mùa, bệnh thường có tỷ lệ mắc cao trong các tháng mùa hè. Theo bạn lý do nào là **không** phù hợp:

- a. thói quen sử dụng rau sống nhiều hơn vào mùa hè
- b. tác nhân gây bệnh có điều kiện thuận lợi hơn tồn tại ngoài cơ thể
- c. ruồi phát triển hơn vào mùa hè
- d. miễn dịch với bệnh giảm do đó số người không có miễn dịch với bệnh tăng

21. Những lý do nào **không** phù hợp khi giải thích về hiện tượng bệnh đường tiêu hoá thường lưu hành ở các nước đang phát triển

- a. xử lý chất thải sinh hoạt chưa hợp vệ sinh
- b. có số lượng người lành mang trùng đông hơn
- c. hiện tượng thức ăn đường phố bị ô nhiễm còn phổ biến
- d. thể lực yếu hơn nên miễn dịch không bền vững

22. Bệnh nhân thương hàn phải được cách ly tại bệnh viện chỉ được xuất viện khi kết quả xét nghiệm phân âm tính sau :

- a. 3 lần cách nhau 3 ngày, lần đầu sau khi hết sốt 6 ngày
- b. 2 lần cách nhau 3 ngày
- c. 1 lần sau khi hết triệu chứng lâm sàng 7 ngày
- d. 1 lần sau khi hết triệu chứng lâm sàng 21 ngày

23. Bệnh lỵ phải được cách ly tại bệnh viện, bệnh nhân được xuất viện khi kết quả xét nghiệm phân âm tính sau :

- a. 1 lần xét nghiệm sau khi hết triệu chứng lâm sàng
- b. 2 lần xét nghiệm sau khi hết triệu chứng lâm sàng, mỗi lần cách nhau 2 ngày
- c. 3 lần xét nghiệm sau khi hết triệu chứng lâm sàng, mỗi lần cách nhau 2 ngày
- d. 4 lần xét nghiệm sau khi hết triệu chứng lâm sàng, mỗi lần cách nhau 2 ngày

24. Đối với một số nghề, những người trực tiếp liên quan tới chế biến thực phẩm, sản xuất nước ăn uống cần phải định kỳ kiểm tra xét nghiệm phân với các bệnh :

- a. lỵ
- b. viêm gan A
- c. tả
- d. bại liệt

25. Trẻ em tiếp xúc với bệnh nhân bại liệt cần phải theo dõi và cách ly :

- a. 10 ngày
- b. 20 ngày

- c. 30 ngày
d. 40 ngày
26. Bệnh nhân bại liệt cần phải cách ly tại bệnh viện và chỉ được xuất viện sau thời gian kể từ khi bệnh toàn phát là :
- a. 10 ngày
b. 20 ngày
c. 30 ngày
d. 40 ngày
27. Bệnh nhân viêm gan A cần phải cách ly tại bệnh viện trong thời gian kể từ khi xuất hiện vàng da là :
- a. 7-10 ngày
b. 10 – 15 ngày
c. 15 – 20 ngày
d. 20-25 ngày
28. Bệnh nào sau đây có thể dự phòng bằng sử dụng vaccin đạt hiệu quả miễn dịch suốt đời:
- a. viêm gan A
b. lỵ
c. tả
d. thương hàn
29. Biện pháp dự phòng đối với các bệnh đường tiêu hoá hiệu quả là:
- a. tiêm phòng vaccin
b. sử dụng hoá trị điều trị dự phòng toàn dân
c. cung cấp nước sạch và vệ sinh ăn uống
d. cách ly bệnh nhân điều trị triệt để

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng hoặc sai phù hợp với những câu hỏi sau:

STT	Câu hỏi	Đ	S
1.	Phẩy khuẩn tả V.cholerae O1 có khả năng gây đại dịch		
2.	Chỉ có chủng V.cholere O1 týp sinh vật cổ điển mới có khả năng gây đại dịch		
3.	Bệnh viêm gan virus A lan truyền theo đường máu khi tiếp xúc qua niêm mạc miệng		

4.	Các bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hoá nhìn chung có biểu hiện lâm sàng rõ ràng, điển hình trên 90% trường hợp nhiễm vi khuẩn gây bệnh		
5.	Nước đóng vai trò vận chuyển tác nhân gây bệnh đối với hầu hết các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá		
6.	Khi sử dụng thức ăn chín, còn nóng thì đã loại trừ hoàn toàn khả năng lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá		
7.	Phần lớn các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá, sau khi mắc bệnh cơ thể có miễn dịch với bệnh suốt đời		
8.	Hầu hết các bệnh lây nhiễm đường tiêu hoá thường mắc vào mùa hè vì nguyên nhân duy nhất là điều kiện khí hậu không thuận lợi cho việc bảo quản thực phẩm		
9.	Bệnh lây nhiễm theo đường tiêu hoá thường xảy ra ở các nước đang phát triển vì họ không có miễn dịch với bệnh		
10.	Biện pháp dự phòng hiệu quả nhất đối với các bệnh lây nhiễm theo đường tiêu hoá là sử dụng hóa trị liệu dự phòng toàn dân		
11.	Vệ sinh ăn uống và cung cấp nước sạch là biện pháp dự phòng hiệu quả nhất đối với các bệnh lây nhiễm đường tiêu hoá		

Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống sau đây:

1. Chủng vi khuẩn tả gây đại dịch hiện nay là
2. Bệnh nhân mắc lỵ mạn tính có thể đào thải vi khuẩn trong phân.....
3. Kể tên 2 bệnh lây nhiễm theo đường tiêu hoá, cơ thể có miễn dịch suốt đời sau khi mắc bệnh :
 1.....
 2.....
4. Các bệnh lây nhiễm đường tiêu hoá nhìn chung có miễn dịch.....
5. Biện pháp dự phòng bệnh lây nhiễm đường tiêu hoá đối với nguồn truyền nhiễm.....
6. Biện pháp dự phòng bệnh lây nhiễm đường tiêu hoá đối với đường truyền nhiễm hiệu quả nhất.....

Dịch tể học nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào kí tự ở đầu câu trong

1. Vi khuẩn dịch hạch có thể tồn tại ngoài cơ thể :
 - a. Trong xác động vật thối rữa ngắn trong vòng 1 giờ
 - b. điều kiện nhiệt độ mát thuận lợi cho vi khuẩn tồn tại lâu ngoài cơ thể
 - c. chết dưới ánh nắng mặt trời sau 1 tháng
 - d. chết dưới ánh nắng mặt trời và nhiệt độ cao sau 3 tháng
2. Virus dengue có thể truyền vào cơ thể người:
 - a. trực tiếp qua tiếp xúc với máu bệnh nhân lây nhiễm
 - b. qua đường tình dục
 - c. qua muỗi truyền
 - d. qua vết da xây sát.
3. Virus viêm gan B có thể tồn tại ngoài cơ thể :
 - a. nhạy cảm với thuốc diệt khuẩn
 - b. chết sau khi đun sôi 30 phút
 - c. chết sau khi đun sôi 60 phút
 - d. chết sau khi đun sôi 120 phút
4. Virus dengue xuất huyết có 4 týp huyết thanh, có miễn dịch
 - a. ngắn, không ổn định giữa các týp huyết thanh
 - b. có miễn dịch chéo giữa các týp huyết thanh
 - c. đặc hiệu bền vững theo týp huyết thanh và không có miễn dịch chéo giữa các týp
 - d. đặc hiệu không bền vững theo týp huyết thanh và không có miễn dịch chéo giữa các týp
5. Muỗi Aedes Aegypti truyền bệnh:
 - a. viêm não nhật bản B
 - b. dengue xuất huyết
 - c. sốt rét
 - d. giun chỉ
6. Muỗi Anophene truyền bệnh:
 - a. sốt rét
 - b. dịch hạch
 - c. dengue xuất huyết

- d. viêm não nhật bản B
- 7. Muỗi culex truyền bệnh:
 - a. viêm não nhật bản B
 - b. sốt rét
 - c. dengue xuất huyết
 - d. viêm gan
- 8. Muỗi sau khi mang virus truyền bệnh, thời gian muỗi có thể truyền bệnh :
 - a. một lần duy nhất
 - b. suốt đời và truyền cho thế hệ sau
 - c. trong thời gian có dịch
 - d. trong thời kì muỗi sinh sản
- 9. Bệnh sốt rét phổ biến nhất ở Việt nam là :
 - a. P. falcifarum
 - b. P. ovale
 - c. P. falcifarum và P. vivax
 - d. P. malaria
- 10. Bệnh nào sau đây có nguồn truyền nhiễm trong tự nhiên :
 - a. viêm não nhật bản B
 - b. sốt rét
 - c. sốt xuất huyết
 - d. viêm gan B
- 11. Bệnh nào sau đây có người là nguồn truyền nhiễm duy nhất
 - a. viêm gan
 - b. dịch hạch
 - c. viêm não nhật bản B
 - d. leptospira
- 12. Bệnh dengue xuất huyết, người bệnh là nguồn truyền nhiễm nguy hiểm nhất trong vòng :
 - a. 1 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên
 - b. 7 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng
 - c. 14 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng
 - d. không phân lập được virus trong máu bệnh nhân vào thời kỳ toàn phát
- 13. Bệnh viêm gan B, có thể tìm được kháng nguyên trong máu của bệnh nhân :
 - a. Chỉ 1 tháng sau khi có triệu chứng lâm sàng

- b. chỉ 3 tháng sau khi có triệu chứng lâm sàng
 - c. chỉ 6 tháng sau khi có triệu chứng lâm sàng
 - d. suốt cuộc đời nếu bệnh nhân chuyển thành viêm gan mạn
14. Bệnh viêm gan B có nguồn truyền nhiễm là:
- a. người bệnh
 - b. người mang HbsAg có hoặc không có triệu chứng lâm sàng
 - c. người bệnh và người khỏi bệnh
 - d. người bệnh chỉ truyền bệnh trong giai đoạn có vàng da
15. Nguồn truyền nhiễm bệnh sốt rét là người mang kí sinh trùng lạnh. Đó là những người
- a. người nhiễm kí sinh trùng sốt rét khi lần đầu tiên đến vùng sốt rét
 - b. bị nhiễm kí sinh trùng từ nhỏ tại vùng sốt rét lưu hành và không có biểu hiện bệnh
 - c. người đang trong giai đoạn ủ bệnh
 - d. người khỏi bệnh về lâm sàng nhưng còn mang trùng trong máu
16. Bệnh nhân sơ nhiễm sốt rét (*P. falcifarum*) là nguồn truyền bệnh khi có giao bào trong máu từ :
- a. từ sau 10 ngày sau khi nhiễm kí sinh trùng
 - b. 5 ngày sau khi nhiễm kí sinh trùng
 - c. 2 ngày sau khi nhiễm kí sinh trùng
 - d. 1 ngày sau khi nhiễm kí sinh trùng
17. Viêm gan B **không** lây nhiễm qua:
- a. mẹ truyền cho con
 - b. quan hệ tình dục với người mang HbsAg
 - c. muỗi đốt
 - d. tiêm chung bơm kim tiêm
18. Bệnh dịch hạch **không** lây nhiễm qua:
- a. dịch tiết phế quản
 - b. bọt chét đốt
 - c. dịch tiết sinh dục
 - d. cả a và b.
19. Viêm gan B **không** lây nhiễm qua:
- a. sử dụng công trình vệ sinh công cộng
 - b. mẹ truyền cho con
 - c. truyền máu
 - d. dịch tiết sinh dục

20. Bệnh nào sau đây không có miễn dịch sau khi mắc bệnh
- HIV/AIDS
 - viêm gan B
 - viêm não nhật bản B
 - viêm gan A
21. Bệnh lây truyền theo đường máu nhìn chung là bệnh có tính chất theo mùa vì :
- mùa hè dân có tiếp xúc mật thiết hơn
 - mùa của các côn trùng sinh sản và phát triển
 - mùa có khí hậu thuận lợi cho tác nhân gây bệnh tồn tại ngoài cơ thể
 - sau khi có dịch các biện pháp phòng chống dịch tích cực hiệu quả nhưng không duy trì kéo dài
22. Bệnh nào sau đây không có ổ chứa trong thiên nhiên:
- viêm gan
 - dịch hạch
 - viêm não nhật bản B
 - sốt rét
23. Dịch hạch có đặc điểm:
- dịch hạch ở người chắc chắn xảy ra sau dịch hạch ở chuột
 - dịch hạch ở người thường xảy ra sớm hơn so với dịch ở chuột
 - dịch hạch ở người có thể xảy ra hoặc không sau dịch hạch ở chuột
 - dịch hạch ở chuột xảy ra như nhau vào mọi thời điểm trong năm
24. Bệnh nào sau đây được coi là bệnh nghề nghiệp
- viêm gan B
 - dengue xuất huyết
 - sốt rét
 - dịch hạch
25. Biện pháp dự phòng hữu hiệu đối với bệnh lây nhiễm đường máu là :
- cắt đường truyền nhiễm
 - điều trị hoá trị liệu
 - giám sát phát hiện bệnh nhân, điều trị và cách ly bệnh nhân
 - tiêm phòng vaccin
26. Sử dụng vaccin là biện pháp bảo vệ khỏi cảm nhiễm hiệu quả trong bệnh:
- viêm não nhật bản B
 - sốt rét

- c. dịch hạch
- d. HIV/AIDS

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng hoặc sai thích hợp trong các câu hỏi sau:

STT	Câu hỏi	Đ	S
1.	Muỗi có thể truyền bệnh sốt rét, viêm não nhật bản B trong suốt cuộc đời và truyền cho thế hệ sau		
2.	Muỗi Aedes Aegypti có thể truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết		
3.	Viêm gan B có 4 tít kháng nguyên là HbsAg, HbeAg, HbcAg, HbxAg nhưng chỉ có kháng nguyên HbsAg là có khả năng lây nhiễm		
4.	Viêm não nhật bản B có nguồn truyền nhiễm duy nhất là người bệnh		
5.	Dengue xuất huyết có ổ chứa bệnh tự nhiên		
6.	Bệnh lây nhiễm theo đường máu chỉ xuất hiện vào các tháng mùa hè vì là mùa của côn trùng phát triển và sinh sản		
7.	Đặc điểm dịch tễ các bệnh lây nhiễm đường máu thường xuất hiện lẻ tẻ, tản phát và không gây thành các vụ dịch lớn		
8.	Biện pháp phòng dịch có hiệu quả nhất đối với bệnh lây nhiễm theo đường máu là tiêm vaccin		

Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống trong những câu hỏi sau:

- Kể tên 2 loại kí sinh trùng gây bệnh sốt rét chủ yếu tại Việt nam :
 - 1.....
 - 2.....
- Kể tên 3 nguồn truyền nhiễm bệnh viêm não nhật bản B :
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
- Kể tên 3 cách thức lây nhiễm viêm gan B
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....

4. Kể tên 1 bệnh lây nhiễm theo đường máu được coi là bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm :
-
5. Kể tên 2 loại bệnh lây nhiễm đường máu có vaccin dự phòng
- 1.....
- 2.....
6. Nằm màn là biện pháp dự phòng đối với đường truyền nhiễm đối với 2 bệnh hay gặp ở nước ta là :
- 1.....
- 2.....

DTH bệnh truyền nhiễm đường da và niêm mạc

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào kí tự ở đầu câu trong các câu hỏi sau:

1. Trường hợp một người sau khi bị chó nuôi cắn vùng cẳng chân, anh/chị khuyên họ làm gì:
 - a. tiêm ngay vaccin kháng dại, không cần theo dõi chó
 - b. tiêm ngay huyết thanh kháng dại, sau 3 ngày tiêm vaccin kháng dại
 - c. theo dõi chó trong vòng 10 ngày, nếu chó ốm cần phải tiêm vaccin ngay
 - d. theo dõi chó trong 15 ngày, nếu có ốm cần phải tiêm huyết thanh kháng dại, sau đó tiêm vaccin
2. Thông thường bệnh dại có thời gian ủ bệnh sau khi bị chó cắn đến khi bệnh toàn phát là:
 - a. 2 - 3 tháng
 - b. 3 – 5 tháng
 - c. 5 – 7 tháng
 - d. 6 – 12 tháng
3. Thời gian virus dại tồn tại ngoài cơ thể động vật mang mầm bệnh là:
 - a. chết sau 1 giờ ở nhiệt độ 60⁰C
 - b. chết ngay trong vòng 1 phút khi tiếp xúc với cồn 70⁰C
 - c. chết trong vòng 1 giờ khi tiếp xúc với dung dịch sát khuẩn như phenol
 - d. chết trong vòng 2 giờ khi ngâm trong dung dịch chloramin
4. Trục khuẩn uốn ván phát triển và sinh sản nhanh hơn nhất trong trường hợp nào sau đây nếu cùng nguồn truyền nhiễm:
 - a. Vết thương rộng, bẩn, nhiều ngách được cắt lọc và băng kín
 - b. Vết thương rộng nhiều ngách được cắt lọc, rửa và để hở
 - c. Vết thương hẹp, nông
 - d. Vết thương hẹp nông được băng kín
5. Nha bào uốn ván chết sau khi đun sôi trong thời gian:
 - a. 15 phút
 - b. 30 phút
 - c. 60 phút
 - d. 120 phút

6. Thời gian ủ bệnh của bệnh than trung bình là:
 - a. 2 – 3 ngày
 - b. 5 – 7 ngày
 - c. 10 – 14 ngày
 - d. 15 – 21 ngày
7. Bào tử trực khuẩn than có thể tồn tại trong đất:
 - a. 2 – 3 ngày
 - b. 5 – 7 ngày
 - c. 10 – 14 ngày
 - d. rất lâu và có thể sinh sản phát triển
8. Trường hợp nào sau đây **không phải** là nguồn truyền nhiễm bệnh dại:
 - a. chuột
 - b. mèo
 - c. bò
 - d. người bệnh
9. Trường hợp nào sau đây người bệnh có thể là nguồn truyền nhiễm:
 - a. bệnh than
 - b. bệnh uốn ván
 - c. bệnh dại
 - d. bệnh leptospira.
10. Thời gian ủ bệnh dại từ khi bị chó nghi dại cắn đến khi phát bệnh thông thường là:
 - a. 5 – 12 ngày
 - b. 1 tháng
 - c. 3 – 6 tháng
 - d. 12 tháng
11. Trường hợp nào sau đây cơ thể tạo miễn dịch bền vững sau khi mắc bệnh:
 - a. uốn ván
 - b. dengue xuất huyết
 - c. dại
 - d. leptospira.
12. Bệnh nào sau đây có tính chất theo mùa:
 - a. bệnh than
 - b. bệnh dại
 - c. uốn ván

- d. leptospira
13. Trường hợp bệnh nào sau đây thường có tính chất tản phát không gây thành dịch:
- a. uốn ván
 - b. ly trực trùng
 - c. tả
 - d. dịch hạch
14. Trường hợp nào sau đây bệnh có xu hướng gia tăng khi có điều kiện thuận lợi cho loài tiết túc phát triển:
- a. bệnh than
 - b. uốn ván
 - c. dại
 - d. viêm gan
15. Trường hợp nào sau đây, bệnh có tính chất nghề nghiệp:
- a. ly
 - b. thương hàn
 - c. bệnh than
 - d. dengue xuất huyết
16. Trường hợp nào sau đây, bệnh có từ 2 đường truyền nhiễm trở lên:
- a. bệnh dại
 - b. bệnh than
 - c. bệnh leptospira
 - d. uốn ván
17. Trường hợp bệnh nào sau đây, người bệnh có thể là nguồn truyền nhiễm:
- a. bệnh than
 - b. bệnh dại
 - c. uốn ván
 - d. leptospira.
18. Bệnh dại có nguồn truyền nhiễm là:
- a. người bệnh
 - b. người lành mang trùng
 - c. người khỏi bệnh
 - d. không có trường hợp nào phù hợp
19. Bệnh than có nguồn truyền nhiễm chủ yếu là:
- a. người bệnh

- b. người lành mang trùng
 - c. người khỏi bệnh
 - d. tiếp xúc với gia súc bị bệnh
20. Bệnh uốn ván có nguồn truyền nhiễm chính là:
- a. người bệnh
 - b. người lành mang trùng
 - c. người khỏi bệnh
 - d. không có trường hợp nào phù hợp
21. Trường hợp bệnh nào sau đây nên tiêm phòng vaccin cho người tiếp xúc nghề nghiệp:
- a. bệnh dại
 - b. uốn ván
 - c. ly
 - d. sốt rét
22. Trường hợp nào sau đây **chỉ** nên tiêm vaccin phòng bệnh sau khi tiếp xúc nguồn lây nhiễm nguy cơ:
- a. bệnh dại
 - b. bệnh than
 - c. uốn ván
 - d. leptospira
23. Trường hợp nào sau đây vẫn có thể mắc bệnh nếu tiếp xúc với nguồn truyền nhiễm mặc dù đã tiêm vaccin đầy đủ :
- a. bệnh dại
 - b. bệnh than
 - c. uốn ván
 - d. viêm gan B
24. Trường hợp nào sau đây để phòng bệnh cho người cần phải tiêm phòng cho gia súc theo định kỳ hàng năm:
- a. bệnh dại
 - b. bệnh than
 - c. bệnh uốn ván
 - d. bệnh leptospira
25. Diệt côn trùng là biện pháp phòng bệnh đối với đường truyền nhiễm trong trường hợp nào sau đây:
- a. bệnh dại

- b. leptospira
- c. bệnh than
- d. uốn ván

26. Thời gian cách ly với người tiếp xúc với người bị bệnh than theo qui định là:

- a. 2 ngày
- b. 5 ngày
- c. 8 ngày
- d. 14 ngày

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng hoặc sai thích hợp trong những câu hỏi sau:

STT	Câu hỏi	Đ	S
1.	Mèo có thể lây truyền bệnh dại khi liếm tay người bị sâu xát		
2.	Người bệnh dại có thể truyền bệnh cho người chăm sóc khi làm dây nước bọt của người bệnh ra tay.		
3.	Súc vật có thể bị lây nhiễm bệnh than qua vết côn trùng cắn/đốt		
4.	Trực khuẩn than có thể tồn tại trong lông gia súc và có thể làm lây truyền bệnh khi tiếp xúc qua da bị sâu xát		
5.	Bệnh uốn ván có nguồn nhiễm nhiễm là người bệnh và người lành mang trùng		
6.	Bệnh dại <i>chỉ</i> gặp vào mùa hè		
7.	Bệnh uốn ván có thể bùng phát gây dịch		
8.	Người bệnh có thể là nguồn truyền nhiễm bệnh dại		
9.	Bệnh uốn ván không có nguồn truyền nhiễm bệnh trong tự nhiên		
10.	Bệnh than có thể lây nhiễm theo đường hô hấp		
11.	Phòng lây nhiễm bệnh dại đối với nguồn truyền nhiễm là phải phát hiện sớm bệnh nhân và cách ly tại bệnh viện		
12.	Phòng bệnh uốn ván đối với nguồn truyền nhiễm là phải cách ly gia súc ốm		
13.	Phòng bệnh than đối với nguồn truyền nhiễm cần phải phát hiện sớm gia súc ốm và cách ly điều trị		

Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống trong các câu hỏi sau:

1. Bệnh dại có nguồn truyền nhiễm.....

2. Dạng tồn tại bền vững của trực khuẩn gây bệnh than trong đất là.....
3. Đặc điểm dịch tễ học của các bệnh lây nhiễm đường da niêm mạc là.....
4. Nguồn truyền nhiễm bệnh dại là.....
5. Bệnh uốn ván có nguồn truyền nhiễm.....
6. Phòng bệnh uốn ván hiệu quả nhất là.....
7. Có thể dự phòng phát triển bệnh dại bằng cách

Dịch tể học và dự phòng HIV/AIDS

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào kí tự ở đầu câu trong các câu hỏi sau :

1. Những dịch sinh học nào sau đây có nguy cơ lây nhiễm HIV:
 - a. dịch âm đạo
 - b. nước tiểu
 - c. nước bọt
 - d. mồ hôi
2. HIV có thể tồn tại ngoài cơ thể:
 - a. chết nhanh ở nhiệt độ 60⁰C
 - b. chết sau khi đun sôi 10 phút
 - c. chết sau 30 phút trong dung dịch chloramin B 10%
 - d. chết sau 60 phút trong dung dịch chloramin B 10%
3. HIV/AIDS có nguồn truyền nhiễm là:
 - a. khí
 - b. người đang ở “giai đoạn cửa sổ”
 - c. động vật nuôi trong nhà
 - d. bát đĩa của người bệnh
4. HIV **không** lây nhiễm trong các giai đoạn của bệnh sau:
 - a. phơi nhiễm HIV
 - b. dưới 3 tháng sau khi phơi nhiễm
 - c. phát triển AIDS
 - d. không có trường hợp nào phù hợp
5. HIV lây nhiễm khi tiếp xúc gần với bệnh nhân trong các trường hợp sau:
 - a. sử dụng chung dao cạo râu
 - b. nằm chơi cùng giường,
 - c. ăn cùng mâm
 - d. sử dụng chung bồn tắm, toilet.
2. HIV có thể lây nhiễm qua:
 - a. muỗi đốt
 - b. vết
 - c. chó nhà cắn

- d. dùng chung bàn chải răng
- 3. HIV có thể truyền từ mẹ sang con với tỷ lệ :
 - a. dưới 25%
 - b. 25 – 50%
 - c. 40 – 60%
 - d. 50 – 70%
- 4. Tình huống nào sau đây mẹ có thể không truyền HIV cho con:
 - a. cho con ăn sữa mẹ bằng thìa
 - b. khi mang thai
 - c. khi sinh
 - d. cho con ăn sữa nhân tạo
- 5. Trường hợp nào sau đây làm lây nhiễm HIV
 - a. quan hệ tình dục an toàn
 - b. châm cứu
 - c. ngồi trên cùng ghế với bệnh nhân
 - d. bơi cùng bể bơi với bệnh nhân
- 6. Trường hợp nào sau đây có nguy cơ lây nhiễm HIV:
 - a. tiêm ma túy với bơm riêng
 - b. quan hệ tình dục an toàn
 - c. xăm trổ
 - d. truyền máu qua sàng lọc
- 7. Khi chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm HIV trong trường hợp:
 - a. máu bắn vào vùng da lành
 - b. máu bắn vào niêm mạc mắt
 - c. máu bắn vào găng tay và quần áo bảo hộ
 - d. dịch màng phổi bắn vào mắt.
- 12. Khi chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm HIV trong trường hợp :
 - a. bị kim lưu động mạch của bệnh nhân đâm xuyên khi rút kim
 - b. bị kim chuẩn bị đặt tĩnh mạch của bệnh nhân đâm xuyên sâu, chảy máu
 - c. bị kim lưu động mạch của bệnh nhân sau khi ngâm vào dung dịch chloramin 10% đâm phải khi thu gom rác thải
 - d. bị kim tiêm ngâm vào dung dịch sát khuẩn đâm xuyên nông khi thu gom rác thải

13. Khi chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, nguy cơ lây nhiễm HIV đối với nhân viên y tế cao nhất trong trường hợp nào sau đây:

- a. tổn thương qua da sâu, chảy máu nhiều do kim nòng rỗng cỡ to
- b. tổn thương da sâu xát nông, không chảy máu
- c. máu bắn vào vùng da lành
- d. máu bắn vào niêm mạc không tổn thương do viêm loét

14. Quan hệ tình dục với người nhiễm HIV trong trường hợp nào sau đây có nguy cơ lây nhiễm cao nhất:

- a. quan hệ tình dục khác giới an toàn
- b. quan hệ tình dục đồng tính nam
- c. thủ dâm
- d. quan hệ tình dục khác giới có sử dụng mũ âm đạo

15. Giai đoạn nào của bệnh nhân HIV/AIDS có nguy cơ lây nhiễm cao nhất

- a. phơi nhiễm
- b. giai đoạn bắt đầu chuyển AIDS
- c. giai đoạn cuối AIDS
- d. giai đoạn sau phơi nhiễm 1 tháng, kết quả xét nghiệm là seronegatif

16. Trường hợp bạn tình có kết quả xét nghiệm HIV dương tính, khả năng lây nhiễm HIV khi:

- a. hôn nông
- b. hôn sâu
- c. quan hệ tình dục có mang bao cao su
- d. thủ dâm

17. Yếu tố nào sau đây làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV

- a. trẻ em học cùng trường với trẻ có seropositive với HIV
- b. trẻ mắc bệnh ưu chảy máu
- c. trẻ có bố hút ma túy
- d. trẻ có anh trai chích ma túy

18. Yếu tố nào sau đây làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV

- a. tiêm chích chung bơm kim tiêm
- b. hút thuốc phiện
- c. truyền máu sàng lọc
- d. quan hệ tình dục an toàn

19. Yếu tố nào sau đây làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV:

- a. sống chung cùng nhà với người nhiễm HIV/AIDS
 - b. trẻ sinh từ mẹ có seropositive với HIV
 - c. trẻ bị lao sơ nhiễm
 - d. trẻ phải điều trị thuốc giảm miễn dịch
20. Yếu tố nào sau đây làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV
- a. quan hệ đồng tính nam
 - b. quan hệ tình dục an toàn
 - c. sử dụng bơm kim tiêm riêng, dùng một lần
 - d. quan hệ tình dục nhiều lần với 1 người duy nhất.
21. Yếu tố nào sau đây làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV:
- a. quan hệ tình dục qua đường âm đạo với nhiều người, có sử dụng mũ chụp âm đạo
 - b. quan hệ mẹ con
 - c. quan hệ anh em ruột mà 1 trong 2 người có nghiện trích máu
 - d. quan hệ tình dục có sử dụng bao cao su
22. Đối tượng nào sau đây có nguy cơ lây nhiễm HIV :
- a. nhân viên y tế
 - b. người có quan hệ anh em với người nhiễm HIV/AIDS
 - c. khi được 10 tuổi thì bố phát hiện nhiễm HIV
 - d. trẻ được 1 tuổi thì mẹ phơi nhiễm HIV có seronegative
23. Nguy cơ lây nhiễm HIV sau tai nạn kim, vật sắc nhọn sau khi dùng cho bệnh nhân HIV đối với nhân viên y tế là:
- a. 0,1%
 - b. 0,4%
 - c. 1,5%
 - d. 3%
24. Mục tiêu của việc áp dụng phương cách xét nghiệm HIV là để :
- a. giám sát HIV/AIDS
 - b. an toàn truyền máu
 - c. chẩn đoán HIV
 - d. cả 3 trường hợp a, b, c
25. Phương cách I được áp dụng trong lĩnh vực nào sau đây:
- a. truyền máu an toàn
 - b. chẩn đoán HIV

- c. giám sát HIV/AIDS
 - d. không phù hợp với cả 3 trường hợp trên
26. Mẫu huyết thanh được coi là dương tính với phương cách I khi:
- a. chỉ cần dương tính với 1 trong 3 xét nghiệm Elisa, serodia, test nhanh
 - b. dương tính với 2 trong 3 test nêu trên
 - c. dương tính đồng thời cả 3 test
 - d. bắt buộc phải dương tính với kỹ thuật Elisa.
27. Phương cách II được áp dụng trong trường hợp nào sau đây:
- a. truyền máu an toàn
 - b. chẩn đoán HIV
 - c. giám sát HIV
 - d. nghiên cứu khoa học
28. Mẫu huyết thanh được coi là dương tính với phương cách II khi:
- a. dương tính đồng thời với cả hai lần xét nghiệm với 2 loại xét nghiệm khác nhau
 - b. dương tính với cả hai lần xét nghiệm với cùng một loại kỹ thuật xét nghiệm
 - c. dương tính với 1 trong 2 kỹ thuật xét nghiệm khác nhau
 - d. dương tính với xét nghiệm thứ 2 khi xét nghiệm thứ nhất âm tính
29. Phương cách III được áp dụng trong trường hợp nào sau đây:
- a. truyền máu an toàn
 - b. chẩn đoán HIV
 - c. giám sát HIV
 - d. nghiên cứu khoa học
30. Mẫu huyết thanh được coi là dương tính với phương cách III khi:
- a. dương tính đồng thời với cả 3 lần xét nghiệm với 3 loại xét nghiệm khác nhau
 - b. dương tính với cả 3 lần xét nghiệm với cùng một loại xét nghiệm
 - c. dương tính với 1 trong 3 loại xét nghiệm khác nhau
 - d. dương tính với xét nghiệm lần thứ 3 sau khi 2 lần xét nghiệm trước âm tính
31. Đối tượng nào sau đây **không** thuộc trong nhóm của giám sát HIV trọng điểm :
- a. bệnh nhân hoa liễu
 - b. bệnh nhân lao
 - c. bệnh nhân khám nấm da
 - d. gái mại dâm
32. Đối tượng nào sau đây **không** thuộc trong nhóm giám sát HIV trọng điểm:
- a. nghiện trích ma túy

- b. phụ nữ trước đẻ
 - c. thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự
 - d. bệnh nhân bệnh máu
33. Biện pháp can thiệp dự phòng HIV nào sau đây không có hiệu quả :
- a. sàng lọc máu an toàn trong truyền máu
 - b. dùng riêng, và chọn loại bơm kim tiêm dùng một lần
 - c. dụng cụ xăm trổ có thể tráng nước sôi
 - d. dụng cụ chăm sóc móng tay được tiệt trùng ngâm trong dung dịch javen hoặc luộc sôi 10 phút
34. Biện pháp can thiệp dự phòng HIV nào sau đây **không** có hiệu quả :
- a. quan hệ tình dục với một người không rõ lai lịch nhưng có sử dụng thuốc tránh thai
 - b. quan hệ tình dục chung thủy
 - c. chỉ quan hệ tình dục với bạn tình khi đã biết rõ lai lịch và quan hệ tình dục an toàn
 - d. không quan hệ tình dục qua đường hậu môn
35. Biện pháp can thiệp nào sau đây không nằm trong chiến lược dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con:
- a. không nên có thai khi mẹ có seropositive với HIV
 - b. mổ đẻ
 - c. cho con bú mẹ càng sớm càng tốt
 - d. điều trị dự phòng bằng thuốc ARVs cho mẹ khi mang thai, trong khi sinh và cho con ngay sau khi sinh.
36. Yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến khả năng thất bại của các chiến lược can thiệp dự phòng lây nhiễm
- a. gái mại dâm đồng thời là người nghiện chích ma túy
 - b. quan hệ đồng tính nam phát triển vì xã hội phải chấp nhận vấn đề nhân quyền
 - c. lái xe đường dài có quan hệ tình dục với gái mại dâm không sử dụng bao cao su
 - d. thanh niên có quan hệ tình dục an toàn trước hôn nhân
37. Biện pháp nào sau đây không áp dụng khi xử trí vết thương do kim hoặc vật sắc nhọn sau khi chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS đâm phải:
- a. để máu chảy rửa xối dưới vòi nước
 - b. rửa bằng xà phòng
 - c. rạch rộng vết thương và rửa bằng dung dịch sát khuẩn
 - d. xét nghiệm HIV bệnh nhân nguồn

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng/sai thích hợp trong các câu hỏi sau:

STT	Câu hỏi	Đ	S
1.	HIV có thể lây nhiễm từ mẹ sang con ngay cả khi mẹ mổ đẻ và cho con ăn sữa nhân tạo		
2.	Muối có thể làm lây truyền HIV		
3.	HIV có trong máu và dịch tiết sinh dục		
4.	Quan hệ tình dục theo đường hậu môn làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV		
5.	Sử dụng mũ chụp âm đạo có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV		
6.	Phương cách I áp dụng trong giám sát HIV/AIDS		
7.	Phương cách III là áp dụng 3 loại xét nghiệm khác nhau để xác định chẩn đoán HIV		
8.	Theo qui định về giám sát trọng điểm (năm 2000) cần phải thu thập mẫu máu xét nghiệm định kỳ 2 lần trong năm		
9.	Cho đến năm 2003 việc giám sát trọng điểm HIV/AIDS được thực hiện tại 10 tỉnh/thành có số lượng người nhiễm HIV cao nhất trong cả nước		
10.	Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục là biện pháp tránh thai duy nhất có thể dự phòng lây nhiễm HIV		

Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống trong các câu hỏi sau:

- HIV là một bệnh lây truyền theo đường.....
- HIV có trong dịch và gây lây nhiễm
- Quan hệ tình dục an toànnguy cơ lây nhiễm HIV
- Sống và sinh hoạt cùng trong cộng đồng có người nhiễm HIVtăng nguy cơ lây nhiễm HIV
- Hiện nay theo qui định của Bộ y tế cóphương cách xét nghiệm HIV.
- Phương cách I áp dụng xét nghiệm HIV trong.....
- Phương cách II áp dụng xét nghiệm HIV trong.....
- Phương cách III áp dụng xét nghiệm HIV trong.....
- Kể tên 6 đối tượng chính của chương trình giám sát trọng điểm đối với HIV
 - 1.....
 - 2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

10. Trường hợp nhân viên y tế bị tai nạn do kim, vật sắc nhọn sau khi sử dụng chăm sóc cho bệnh nhân HIV/AIDS đâm xuyên gây chảy máu, biện pháp rạch rộng vết thương và nặn máuđược khuyến cáo trong dự phòng lây nhiễm nghề nghiệp.
11. Tỷ lệ lây nhiễm HIV mẹ truyền cho con khác nhau tùy theo mỗi nước và trong khoảng.....

DTH một số bệnh không lây phổ biến

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào kí tự ở đầu câu trong các câu hỏi sau :

1. Các bệnh không lây phổ biến hiện nay như đái đường, tăng huyết áp, béo phì ...có xu hướng gia tăng. Quan niệm về dự phòng bệnh nào sau đây không đúng
 - a. thay đổi hành vi cá nhân
 - b. thay đổi quan niệm của xã hội
 - c. bệnh có tính di truyền
 - d. tạo lối sống sinh hoạt lành mạnh và ăn uống hợp vệ sinh bắt đầu từ mỗi gia đình
2. Yếu tố nào sau đây **không** đúng khi nói về nguy cơ làm gia tăng các bệnh tim mạch:
 - a. hoạt động thể lực làm giảm hiệu quả điều trị bệnh tim mạch do đó làm tăng tỷ lệ mắc
 - b. ít vận động và hoạt động thể lực
 - c. Lao động tĩnh
 - d. ăn nhiều chất béo so với nhu cầu
3. Yếu tố nào sau đây là yếu tố nguy cơ cho bệnh tai biến mạch máu não:
 - a. tăng huyết áp
 - b. tuổi
 - c. giới
 - d. tiền sử gia đình có người bị tai biến mạch máu não
1. Theo kết quả của một số nghiên cứu về sự kết hợp giữ tăng huyết áp và tai biến mạch máu não (TBMMN), kết quả nào sau đây là phù hợp
 - a. $RR = 1$, không có sự kết hợp.
 - b. $RR = 4$, nguy cơ TBMMN gấp 4 lần ở những người tăng huyết áp
 - c. $RR = 0,5$, tăng huyết áp không phải là yếu tố nguy cơ TBMMN
 - d. $RR = 50$, nguy cơ TBMMN gấp 50 lần ở những người tăng huyết áp
2. Yếu tố nào sau đây **không** phải là yếu tố thuận lợi đối với tai biến mạch máu não :
 - a. đái tháo đường
 - b. tăng lipid máu
 - c. béo phì
 - d. ăn hạn chế muối
6. Yếu tố nào sau đây là yếu tố thuận lợi đối với tai biến mạch máu não :

- a. sử dụng thuốc tránh thai thường xuyên
 - b. ăn uống với lượng muối kiểm soát dưới 5 gram/ngày
 - c. sử dụng nước khoáng có ga
 - d. uống nhiều nước
7. Yếu tố nào sau đây **không** phải là yếu tố thuận lợi đối với bệnh tim mạch:
- a. hút thuốc lá
 - b. ít vận động,
 - c. uống rượu 200ml/ngày
 - d. ăn uống với lượng muối kiểm soát 10 –15 gr/ngày
8. Yếu tố nào sau đây **không** phải là yếu tố thuận lợi đối với bệnh tim mạch :
- a. béo phì
 - b. đái tháo đường
 - c. ăn hạn chế muối 15 gr/ngày
 - d. vận động thể lực hạn chế 2 giờ/ngày
9. Yếu tố nào sau đây là yếu tố thuận lợi cho bệnh đái tháo đường týp II
- a. “dáng người hình quả lê”
 - b. chỉ số IBM 18 – 23
 - c. hoạt động thể lực hạn chế 2 giờ/ngày
 - d. không có hiện tượng dung nạp đường huyết giảm
10. Yếu tố nào sau đây **không** phải là yếu tố thuận lợi bệnh đái tháo đường:
- a. suy dinh dưỡng khi còn nhỏ
 - b. tăng cholesterol máu
 - c. đái đường thai nghén
 - d. tăng huyết áp
11. Yếu tố nào sau đây là yếu tố nguy cơ đối với bệnh ung thư phổi :
- a. giới
 - b. hút thuốc lá
 - c. cao huyết áp
 - d. ít vận động
12. Yếu tố nào sau đây là yếu tố thuận lợi ung thư vú ở phụ nữ
- a. béo phì
 - b. lao động thể lực
 - c. vận động hạn chế 2 giờ/ngày
 - d. không sử dụng thuốc tránh thai

13. Dự phòng cấp I với các bệnh tim mạch là :
- thay đổi thói quen lạm dụng muối trong ăn uống và chế biến thực phẩm
 - có thể giải trí tích cực bằng chơi điện tử
 - hút thuốc lá trong các khu vực dành riêng
 - điều trị cho người cao huyết áp
14. Dự phòng cấp I đối với các bệnh ung thư :
- loại bỏ hoàn toàn hút thuốc lá chủ động và bị động
 - khám sàng lọc phát hiện ung thư trong cộng đồng
 - phẫu thuật đối với những ung thư giai đoạn sớm
 - điều trị tia xạ sớm đối với trường hợp phát hiện ung thư
15. Dự phòng cấp I đối với bệnh đái tháo đường :
- tăng cường vận động tối thiểu 1 giờ/ngày và kiểm soát cân nặng
 - giảm chế độ ăn nhiều đạm bằng tăng cường tinh bột.
 - Khám sàng lọc phát hiện đái tháo đường tại cộng đồng để điều trị hiệu quả
 - Giám sát hiệu quả điều trị đái đường bằng sử dụng thuốc
16. Dự phòng cấp I đối với bệnh mạch vành:
- chế độ ăn hạn chế muối, giám sát cân nặng hợp lý
 - phát hiện sớm bệnh
 - điều trị tích cực cao huyết áp
 - theo dõi giám sát dự phòng cơn tái phát
17. Dự phòng cấp I đối với bệnh ung thư vú ở phụ nữ :
- hoạt động thể lực tối thiểu 2h/ngày, giám sát cân nặng hợp lý
 - định kỳ kiểm tra sức khỏe
 - phẫu thuật sớm khi phát hiện
 - không phù hợp ở tất cả các trường hợp nêu trên

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng/sai thích hợp trong các câu hỏi sau:

STT	Câu hỏi	Đ	S
1.	Mục tiêu trước tiên của các nghiên cứu dịch tễ học bệnh không lây phổ biến hiện nhằm phát hiện các yếu tố nguy cơ và can thiệp dự phòng hậu quả nghiêm trọng của bệnh thông qua chẩn đoán sớm, phát hiện điều trị		
2.	Việc loại trừ được hút thuốc lá chủ động và bị động sẽ làm giảm nguy cơ bệnh ung thư phổi		

3.	Duy trì chế độ ăn hạn chế muối trong khẩu phần ăn dưới 5 gr/ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.		
4.	Vận động tối thiểu 1 giờ/ngày và giám sát duy trì cân nặng hợp lý không làm giảm được nguy cơ bệnh đái tháo đường		
5.	Ung thư vú có tỷ lệ cao hơn ở nhóm phụ nữ béo phì và thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai		
6.	Loại bỏ các yếu tố nguy cơ đối với bệnh tim mạch là thực hiện chiến lược dự phòng cấp I		
7.	Khám định kỳ, phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ là thực hiện chiến lược dự phòng cấp II		
8.	Giám sát và duy trì cân nặng phù hợp, đồng thời lựa chọn chơi một môn thể thao thích hợp với mỗi cá nhân là một biện pháp dự phòng đái tháo đường típ II		

Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống trong những câu hỏi sau :

1. Chế độ ăn uống làm giảm nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp trước hết là.....
2. Yếu tố tuổi là yếu tốđối với bệnh đái tháo đường
3. Thừa cân, béo phì là yếu tốđối với bệnh đái tháo đường
4. Hút thuốc lá gián tiếp là yếu tốđối với bệnh ung thư phổi
5. Khẩu phần ăn hạn chế muối và tăng cường vận động là can thiệp dự phòng cấp.....đối với bệnh tăng huyết áp.

Tiêm chủng phòng bệnh

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào kí tự ở đầu câu trong các câu hỏi sau :

1. Tình huống nào sau đây **không** phải là nhiệm vụ của cán bộ y tế tuyến huyện đối với việc tiêm chủng mở rộng :
 - a. xác định đối tượng và có danh sách đối tượng tiêm chủng tại cơ sở
 - b. lập kế hoạch tiêm chủng và dự trữ vaccin
 - c. giám sát công tác tiêm chủng tại trạm y tế xã phường
 - d. thông báo và hẹn lịch tiêm cho đối tượng tiêm chủng
2. Mục tiêu của chương trình tiêm chủng mở rộng :
 - a. hạn chế tỷ lệ trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm
 - b. hạn chế tỷ lệ trẻ mắc 6 bệnh truyền nhiễm phổ biến
 - c. tạo miễn dịch chủ động cho trẻ với 6 bệnh (lao, bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, sởi)
 - d. hạn chế tỷ lệ mắc và chết do các bệnh truyền ở trẻ
3. Vaccin sởi được chỉ định tiêm cho trẻ khi:
 - a. càng sớm càng tốt
 - b. trẻ 3 tháng tuổi
 - c. trẻ 9 tháng tuổi
 - d. trẻ 12 tháng tuổi
4. Vaccin tam liên (bạch hầu, uốn ván, ho gà) được chỉ định tiêm khi trẻ:
 - a. mũi 1 khi trẻ đủ 2 tháng tuổi
 - b. mũi 2 cách mũi một 6 tháng
 - c. mũi 3 cách mũi hai 12 tháng
 - d. tiêm 2 mũi là tạo được miễn dịch an toàn cho trẻ
5. Để tạo miễn dịch cơ bản cho trẻ đối với bạch hầu, uốn ván, ho gà cần tiêm vaccin tam liên:
 - a. một mũi vaccin duy nhất khi trẻ đủ 1 tháng tuổi
 - b. tiêm 3 mũi vaccin , mỗi mũi cách nhau 1 tháng và mũi một tiêm khi trẻ đủ 2 tháng tuổi
 - c. tiêm 2 mũi vaccin khi trẻ 2 tháng và 3 tháng tuổi. Mũi thứ 3 tiêm nhắc lại sau 1 năm.

- d. tiêm 3 mũi vaccin theo lịch khi trẻ 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi và 6 tháng tuổi
6. Để tạo miễn dịch cơ bản cho trẻ dự phòng bệnh bại liệt cần cho uống vaccin theo lịch sau:
- a. 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng, lần đầu tiên khi trẻ đủ 2 tháng tuổi
 - b. 3 lần, lần một khi trẻ 2 tháng tuổi, lần 2 khi trẻ 3 tháng tuổi, lần 3 khi trẻ 6 tháng tuổi
 - c. 3 lần, lần một khi trẻ 2 tháng tuổi, lần 2 khi trẻ 6 tháng tuổi, lần 3 khi trẻ 12 tháng tuổi
 - d. lần 1 khi trẻ 2 tháng tuổi, lần 2 khi trẻ 3 tháng tuổi. Tiêm nhắc lại khi trẻ 2 tuổi
7. Tiêm vaccin phòng lao cho trẻ theo lịch sau:
- a. ngay sau khi sinh, càng sớm càng tốt
 - b. tốt nhất trong năm đầu
 - c. khi trẻ bắt đầu đi nhà trẻ
 - d. trẻ đủ 6 tháng tuổi
8. Khi trẻ 9 tháng tuổi, đến tiêm vaccin phòng sởi bạn có thể kiểm tra xem trẻ đã tiêm phòng lao chưa bằng cách:
- a. hỏi bà mẹ
 - b. kiểm tra phiếu tiêm chủng
 - c. kiểm tra sẹo lao ở cơ delta
 - d. không có cách nào đáng tin cậy
9. Khi kiểm tra kết quả tiêm phòng lao, trường hợp nào sau đây bạn có thể an tâm về tình trạng miễn dịch của trẻ với bệnh lao
- a. không có sẹo ở cơ delta 2 bên tay
 - b. sẹo mờ, rất khó phát hiện
 - c. sẹo lõm, đường kính 0,5cm
 - d. không có trường hợp nào phù hợp để đánh giá
10. Điều kiện nhiệt độ bảo quản vaccin nói chung tốt nhất là :
- a. dưới 0°C
 - b. $0 - 8^{\circ}\text{C}$
 - c. không quá 10°C
 - d. không quá 15°C
11. Vaccin nào sau đây có thể bảo quản ở nhiệt độ đông băng:
- a. lao
 - b. ho gà
 - c. uốn ván

- d. không phù hợp với những vaccin nêu trên
12. Vaccin nào sau đây không thể bảo quản ở nhiệt độ đông băng :
- a. lao
 - b. sởi
 - c. bại liệt
 - d. bạch hầu
13. Vaccin nào không thể có thể bảo quản ở nhiệt độ đông băng
- a. viêm não nhật bản B
 - b. lao
 - c. bại liệt
 - d. sởi
14. Vaccin được bảo quản trong phích lạnh khi đến các điểm tiêm phòng lưu đông, thời gian bảo quản tối đa:
- a. một ngày
 - b. hai ngày
 - c. ba ngày
 - d. bốn ngày
15. Thời gian tối đa bảo quản vaccin trong hòm lạnh là:
- a. 3 ngày
 - b. 4 ngày
 - c. 5 ngày
 - e. 7 ngày
16. Không tiêm vaccin phòng lao cho trẻ khi :
- a. trẻ đã bị lao sơ nhiễm
 - b. trẻ suy dinh dưỡng độ 1
 - c. trẻ bị tiêu chảy không mất nước
 - d. sốt $37,5^{\circ}\text{C}$
17. Tiêm phòng lao cho trẻ khi :
- a. đang điều trị kháng sinh vì viêm phổi
 - b. trẻ có seropositive với HIV
 - c. sốt 39°C
 - d. điều trị lao hạch
18. Chống chỉ định trì hoãn uống vaccin bại liệt cho trẻ khi:
- a. trẻ bị suy giảm miễn dịch

- b. trẻ bị tiêu chảy cấp
 - c. trẻ bị ho
 - d. trẻ bị teo cơ do bệnh bẩm sinh
19. Chống chỉ định tạm thời tiêm vaccin uốn ván cho trẻ khi:
- a. trẻ đang điều trị cocticoit
 - b. trẻ ho
 - c. trẻ tiêu chảy cấp
 - d. trẻ biếng ăn
20. Vaccin phòng lao được tiêm ở vùng cơ delta tay trái với chỉ định:
- a. tiêm trong da 0,1 ml
 - b. tiêm dưới da 0,5 ml
 - c. tiêm bắp 0,5 ml
 - d. tiêm dưới da 0,1ml
21. Khi cho trẻ uống vaccin bại liệt cần phải chuẩn bị nước cho trẻ uống :
- a. nước ngọt có ga
 - b. nước ấm
 - c. nước nguội
 - d. bất cứ loại nước uống nào
22. Vaccin bạch hầu, uốn ván, ho gà được chỉ định :
- a. tiêm dưới da 0,5ml
 - b. tiêm bắp 0,5ml
 - c. tiêm trong da 0,1ml
 - d. tiêm dưới da 1ml
23. Vaccin sởi được chỉ định :
- a. tiêm bắp sâu 0,5ml
 - b. tiêm dưới da 0,5ml
 - c. tiêm dưới da 0,1 ml
 - d. tiêm bắp sâu 1ml

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng hoặc sai thích hợp trong các câu hỏi sau:

STT	Câu hỏi	Đ	S
1.	tiêm chủng mở rộng được thực hiện cho trẻ mỗi khi đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế		

2.	Trẻ tiêm đúng lịch tiêm chủng thì trẻ có miễn dịch đầy đủ với 7 bệnh trong chương trình tiêm chủng		
3.	Tiêm phòng vaccin viêm não nhật bản B là thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi		
4.	Tiêm vaccin phòng viêm não nhật bản B cần tiêm 2 mũi, mỗi mũi cách nhau 15 ngày. Tiêm nhắc lại sau 1 năm		
5.	Vaccin sởi, viêm não nhật bản B, bại liệt có thể bảo quản ở nhiệt độ đông băng		
6.	Trẻ HIV/AIDS nên tiêm vaccin phòng lao ngay cả khi trẻ đang điều trị nhiễm trùng cơ hội		

Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống trong những câu hỏi sau:

- Chương trình tiêm chủng mở rộng áp dụng cho đối tượng trẻ.....
- Tiêm vaccin phòng sởi tốt nhất cho trẻ khi
- Tiêm vaccin phòng lao.....
- Vaccin viêm não Nhật bản B không thể bảo quản ở nhiệt độ.....
- Kể tên 3 loại vaccin trong chương trình tiêm chủng mở rộng có thể bảo quản ở nhiệt độ đông băng :
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
- Kể tên 3 loại vaccin trong chương trình tiêm chủng mở rộng không thể bảo quản ở nhiệt độ đông băng :
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....